

Buku Ajar **METODOLOGI KEPERAWATAN**

Ester Radandima • Asih Purwandari Wahyoe Puspita • Toto Harto
Muhammad Syahid Hidayat • Sri Astutik Andayani • Hernita Frisnawati Purba
D. Eka Harsanto • I Gusti Ayu Putu Desy Rohana



BUKU AJAR: METODOLOGI KEPERAWATAN

Penulis:

Ester Radandima, S.Kep., Ns., M.Kep.

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

Toto Harto, M.K.M.

Muhammad Syahid Hidayat BS., SH., S.Kep., MS., MH.

Sri Astutik Andayani, S.Kep., Ns, M.Kes.

Hernita Frisnawati Purba, S.Kep., M.Kep.

D. Eka Harsanto, S.Kp., M.Kes.

Ns. I Gusti Ayu Putu Desy Rohana, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Buku Ajar: Metodologi Keperawatan

Penulis: Ester Radandima, S.Kep., Ns., M.Kep.

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

Toto Harto, M.K.M.

Muhammad Syahid Hidayat BS., SH., S.Kep., MS., MH.

Sri Astutik Andayani, S.Kep., Ns, M.Kes.

Hernita Frisnawati Purba, S.Kep., M.Kep.

D. Eka Harsanto, S.Kp., M.Kes.

Ns. I Gusti Ayu Putu Desy Rohana, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-27-2

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini, berjudul "Metodologi Keperawatan", dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam memahami secara mendalam berbagai aspek metodologi yang menjadi dasar dalam praktik keperawatan.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan terstruktur tentang konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang merupakan fondasi penting dalam menjalankan praktik keperawatan secara efektif dan efisien. Kemampuan berpikir kritis menjadi kompetensi inti perawat dalam menghadapi tantangan klinis sehari-hari, sehingga keputusan yang diambil selalu berbasis bukti dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Selain itu, buku ini juga memaparkan secara rinci penerapan proses keperawatan sebagai metode ilmiah dalam penyelesaian berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi pasien. Pembahasan mengenai praktik penetapan diagnosa keperawatan, perbandingan antara metode ilmiah dan proses keperawatan, serta langkah-langkah konkret dalam praktik metodologi ilmiah menjadi perhatian khusus agar mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan ini dalam konteks nyata di lapangan.

Buku ini juga mengulas berbagai tren dan isu terbaru dalam keperawatan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pembaca mampu beradaptasi dengan perubahan serta meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara kontinu. Disamping itu, penekanan pada konsep perencanaan keperawatan yang sistematis dan terstruktur akan membantu pembaca dalam menyusun intervensi yang tepat, rasional, dan terukur.

Harapan kami, buku ajar ini tidak hanya menjadi referensi teoritis semata, melainkan juga menjadi panduan praktis yang mendukung mahasiswa maupun praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang optimal. Masukan dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 KONSEP BERPIKIR KRITIS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEPERAWATAN.....

A. Konsep Dasar Berpikir Kritis dalam Keperawatan	2
B. Pentingnya Berpikir Kritis dalam Keperawatan	3
C. Proses Pengambilan Keputusan dalam Keperawatan	4
D. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan dalam Keperawatan	6
E. Strategi Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Pengambilan Keputusan	8
F. Latihan Soal	9
G. Rangkuman Soal.....	11
H. Glosarium	12
I. Daftar pustaka	13

BAB 2 PRAKTIK PENERAPAN PROSES KEPERAWATAN SEBAGAI METODE ILMIAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH/ASUHAN KEPERAWATAN

A. Pengkajian.....	17
B. Diagnosa Keperawatan	19
C. Perencanaan.....	22
D. Implementasi	24
E. Evaluasi.....	27
F. Latihan Soal	29
G. Rangkuman Materi	31
H. Glosarium	33
I. Daftar pustaka	35

BAB 3 PRAKTIK MENETAPKAN MASALAH/DIAGNOSA KEPERAWATAN ..

A. Konsep Dasar Masalah dan Diagnosa Keperawatan	39
B. Identifikasi dan Klasifikasi Data	40
C. Langkah-Langkah Analisis Data	41
D. Perumusan Diagnosa Keperawatan.....	43
E. Hubungan Diagnosa Keperawatan dengan Intervensi	44
F. Latihan Soal	46
G. Rangkuman Materi	48
H. Glosarium	49
I. Daftar Pustaka	50

BAB 4 PERBANDINGAN METODE ILMIAH DAN PROSES KEPERAWATAN

SEBAGAI METODE PENYELESAIAN MASALAH	51
A. Konsep Dasar Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan	53
B. Perbandingan Langkah-langkah Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan	55
C. Integrasi Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan.....	58
D. Kelebihan dan Kekurangan Kedua Metode.....	59
E. Integrasi Kedua Metode.....	61
F. Integrasi Metode Ilmiah ke dalam Proses Keperawatan.....	61
G. Latihan Soal	63
H. Rangkuman materi	65
I. Glosarium	67
J. Daftar pustaka	68

BAB 5 TREND DAN ISSUE.....69

A. Tren dalam Metodologi Keperawatan.....	71
B. Isu Utama dalam Metodologi Keperawatan	72
C. Dampak Teknologi Digital.....	72
D. Tren Demografi dan Kebutuhan Metodologi Keperawatan	74
E. Pengaruh Pandemi Global.....	75
F. Latihan Soal	76
G. Rangkuman Materi	78
H. Glosarium	80
I. Daftar pustaka	81

BAB 6 PERENCANAAN KEPERAWATAN83

A. Konsep Dasar Perencanaan Keperawatan.....	85
B. Penentuan Prioritas Masalah.....	87
C. Formulasi Tujuan dan Kriteria Hasil (Outcome)	89
D. Pemilihan Intervensi Keperawatan	91
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perencanaan.....	92
F. Latihan Soal	95
G. Rangkuman materi	97
H. Glosarium	98
I. Daftar pustaka	99

BAB 7 PRAKTIK/PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH METODE ILMIAH

DALAM PENYELESAIAN MASALAH	101
A. Praktik Langkah-Langkah Metode Ilmiah	103
B. Penarikan Kesimpulan.....	113

C. Latihan Soal	115
D. Rangkuman materi	117
E. Glosarium	118
F. Daftar pustaka	120

BAB 8 KONSEP PROSES KEPERAWATAN.....121

A. Pengertian Proses Keperawatan	125
B. Tahapan Proses Keperawatan	126
C. Manfaat Proses Keperawatan.....	139
D. Proses Keperawatan Sebagai Metode Penyelesaian Masalah keperawatan..	141
E. Perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah	142
F. Latihan	143
G. Kunci Jawaban	146
H. Rangkuman Materi	146
I. Glosarium	147
J. Daftar Pustaka	148

PROFIL PENULIS149

BAB 1

KONSEP BERPIKIR KRITIS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEPERAWATAN

Pendahuluan

Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan esensial dalam profesi keperawatan, terutama dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika situasi klinis sehari-hari. Kemampuan ini tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan klinis yang efektif tetapi juga penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Penguasaan berpikir kritis memungkinkan perawat mengambil keputusan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar praktik terbaik serta prinsip etika profesional.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis secara sistematis, efektif, dan bertanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas tinggi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep berpikir kritis serta menggunakan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis dalam praktik keperawatan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan konsep dasar berpikir kritis dalam konteks keperawatan.
- Mengidentifikasi tahapan dan elemen penting dalam proses berpikir kritis.
- Mengaplikasikan keterampilan berpikir kritis dalam situasi klinis untuk pengambilan keputusan.
- Mengevaluasi hasil keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah dan prinsip etik profesional.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Berpikir Kritis dalam Keperawatan

Berpikir kritis dalam keperawatan merupakan proses intelektual yang disiplin, aktif, dan sistematis, melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi informasi secara mendalam. Tujuan dari berpikir kritis dalam keperawatan adalah untuk memastikan keputusan klinis yang diambil berdasarkan informasi akurat, bukti ilmiah terkini, pengalaman profesional, intuisi keperawatan, serta mempertimbangkan nilai-nilai etik dan moral dalam praktik sehari-hari. Menurut Facione (2020), berpikir kritis meliputi enam elemen utama, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri.

Elemen-elemen Berpikir Kritis dalam Keperawatan

Menurut Facione (2020), berpikir kritis terdiri dari beberapa elemen penting yang saling berkaitan erat dan harus dikuasai secara menyeluruh oleh perawat:

1. Interpretasi

Interpretasi adalah kemampuan perawat untuk memahami secara mendalam arti dari berbagai data klinis yang diperoleh melalui anamnesis pasien, wawancara dengan keluarga, hasil pemeriksaan fisik, dan data pendukung lainnya. Interpretasi yang tepat memungkinkan perawat memahami kondisi pasien secara holistik, sehingga mampu merumuskan masalah keperawatan secara tepat.

2. Analisis

Analisis merupakan kemampuan perawat dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi hubungan antardata klinis yang ada, termasuk tanda-tanda, gejala, hasil pemeriksaan laboratorium, serta riwayat kesehatan pasien. Dengan analisis yang tepat, perawat dapat menemukan pola-pola tertentu yang membantu menentukan diagnosis keperawatan secara lebih efektif.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah proses menilai validitas, kredibilitas, relevansi, serta signifikansi dari informasi klinis yang diperoleh. Evaluasi yang cermat memastikan perawat menggunakan informasi terbaik dalam proses pengambilan keputusan klinis, menghindari bias, dan memastikan bahwa tindakan yang dipilih tepat untuk kondisi pasien.

4. Inferensi

Inferensi merupakan kemampuan menarik kesimpulan logis berdasarkan analisis data dan bukti klinis. Melalui inferensi yang baik, perawat dapat membuat keputusan klinis yang tepat, seperti menentukan diagnosis keperawatan dan memilih intervensi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

5. Eksplanasi

Eksplanasi adalah kemampuan menjelaskan dengan jelas dan rasional alasan di balik keputusan klinis dan tindakan yang dipilih. Kemampuan ini penting untuk meningkatkan transparansi praktik keperawatan dan memperkuat komunikasi dengan pasien, keluarga, serta anggota tim kesehatan lainnya.

6. Regulasi Diri

Regulasi diri adalah kemampuan perawat dalam mengelola dan mengevaluasi proses berpikirnya secara mandiri. Regulasi diri membantu perawat memperbaiki kesalahan dalam proses berpikir, memastikan kualitas keputusan yang diambil selalu optimal, serta mendorong perkembangan profesional yang berkelanjutan.

B. Pentingnya Berpikir Kritis dalam Keperawatan

Berpikir kritis sangat penting dalam praktik keperawatan karena mampu membawa berbagai manfaat signifikan bagi perawat, pasien, dan tim kesehatan secara keseluruhan. Berikut ini beberapa alasan mengapa berpikir kritis menjadi aspek fundamental dalam keperawatan:

1. Menjamin Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti

Berpikir kritis memungkinkan perawat mengevaluasi informasi klinis secara objektif, mendalam, dan kritis. Dengan kemampuan ini, perawat dapat mengidentifikasi informasi yang relevan dan valid, serta memastikan bahwa keputusan klinis yang diambil didasarkan pada bukti ilmiah yang paling mutakhir. Asuhan berbasis bukti (evidence-based practice) memastikan bahwa intervensi keperawatan yang diberikan terbukti efektif secara ilmiah, meningkatkan hasil perawatan pasien, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pelayanan keperawatan.

2. Meningkatkan Kualitas Keputusan Klinis

Melalui berpikir kritis, perawat mampu menganalisis berbagai aspek situasi klinis dengan cermat, mempertimbangkan semua pilihan intervensi secara teliti, dan akhirnya memilih tindakan yang paling tepat sesuai dengan kondisi spesifik pasien. Kemampuan ini penting dalam memastikan bahwa keputusan klinis yang diambil relevan, akurat, dan mampu memenuhi kebutuhan individu pasien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

3. Meminimalkan Risiko Kesalahan Medis

Berpikir kritis memungkinkan perawat mengenali risiko atau potensi kesalahan medis secara dini. Dengan proses analisis yang sistematis dan mendalam, perawat mampu mengidentifikasi faktor risiko, mengevaluasi intervensi, dan memilih tindakan preventif yang efektif. Hal ini secara signifikan membantu mengurangi insiden kesalahan medis, meningkatkan keselamatan pasien, serta melindungi pasien dari komplikasi akibat tindakan medis yang tidak tepat.

4. Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Sumber Daya

Pengambilan keputusan yang efisien merupakan hasil dari berpikir kritis yang optimal. Perawat yang terampil dalam berpikir kritis dapat dengan cepat menentukan prioritas tindakan, mengidentifikasi intervensi yang paling efisien, serta mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya. Dalam lingkungan klinis yang serba cepat dan dinamis, kemampuan ini sangat penting untuk memberikan perawatan yang efektif dan berkualitas tinggi tanpa pemborosan sumber daya.

5. Mendukung Kolaborasi Interprofesional dalam Tim Kesehatan

Kemampuan berpikir kritis juga mendukung kolaborasi yang efektif dalam tim interprofesional. Melalui komunikasi yang jelas dan terstruktur, perawat mampu menyampaikan informasi klinis secara efektif kepada anggota tim kesehatan lainnya. Hal ini meningkatkan koordinasi antar anggota tim, membantu dalam pengambilan keputusan bersama, serta memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi pasien dan rencana perawatan yang diperlukan.

C. Proses Pengambilan Keputusan dalam Keperawatan

Pengambilan keputusan dalam keperawatan merupakan proses sistematis yang dilakukan perawat untuk menentukan tindakan terbaik guna memberikan asuhan keperawatan yang optimal kepada pasien. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan penting yang harus dilalui secara terstruktur dan terorganisir:

Tahapan Pengambilan Keputusan Klinis

1. Identifikasi Masalah

Tahap ini melibatkan upaya perawat dalam mengenali dan mendefinisikan masalah kesehatan pasien secara jelas dan spesifik. Identifikasi masalah yang akurat merupakan dasar penting karena menentukan arah tindakan keperawatan selanjutnya. Dalam tahap ini, perawat perlu memperhatikan secara mendalam keluhan pasien, tanda-tanda klinis, serta kebutuhan pasien secara menyeluruh dan komprehensif.

2. Pengumpulan Data

Setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data secara menyeluruh. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pasien dan keluarga, catatan medis pasien, hasil pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium. Pengumpulan data yang teliti dan komprehensif memungkinkan perawat mendapatkan informasi yang valid dan relevan, sebagai dasar yang kokoh untuk proses pengambilan keputusan.

3. Analisis dan Interpretasi Data

Pada tahap ini, perawat melakukan analisis yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan menemukan pola, hubungan antardata, dan makna klinis dari informasi tersebut. Interpretasi data yang akurat membantu perawat memahami situasi klinis pasien secara jelas dan sistematis, sehingga memungkinkan penentuan intervensi yang paling efektif.

4. Perumusan Alternatif Keputusan

Setelah melakukan analisis dan interpretasi data, perawat perlu merumuskan beberapa alternatif tindakan atau intervensi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Pada tahap ini, perawat dituntut untuk berpikir kreatif dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan solusi, sehingga tersedia beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

5. Evaluasi Alternatif

Setiap alternatif keputusan yang telah dirumuskan kemudian dievaluasi secara kritis dan teliti. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kelebihan, kekurangan, risiko, manfaat, dan relevansi setiap opsi berdasarkan bukti klinis terbaru, prinsip-prinsip etik, dan pertimbangan kepraktisan di lingkungan kerja. Evaluasi yang baik membantu perawat mengidentifikasi opsi yang paling optimal untuk diterapkan.

6. Pengambilan Keputusan

Setelah mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia, perawat memilih keputusan klinis yang dianggap paling tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Keputusan ini harus dibuat berdasarkan analisis yang mendalam, objektif, dan rasional, serta mempertimbangkan nilai-nilai etika keperawatan untuk memastikan hasil yang optimal dan memuaskan bagi pasien.

7. Implementasi Keputusan

Keputusan yang telah diambil selanjutnya diimplementasikan secara efektif. Tahap ini melibatkan pelaksanaan tindakan klinis yang telah dipilih dengan keterampilan teknis dan interpersonal yang baik. Implementasi yang tepat memastikan tindakan tersebut memberikan hasil maksimal bagi pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

8. Evaluasi Hasil Keputusan

Tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan adalah evaluasi hasil dari implementasi keputusan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas tindakan klinis, mengetahui tingkat keberhasilan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindakan belum optimal, perawat harus kembali meninjau proses sebelumnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan dalam Keperawatan

Pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penting. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menentukan kualitas serta efektivitas keputusan klinis yang diambil oleh perawat. Berikut ini adalah penjabaran rinci mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Pengetahuan dan Keterampilan Perawat

Pengetahuan dan keterampilan klinis yang dimiliki perawat adalah pondasi utama dalam proses pengambilan keputusan klinis. Pengetahuan ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, serta prinsip-prinsip keperawatan dasar dan lanjutan. Keterampilan teknis seperti kemampuan melakukan pemeriksaan fisik, penggunaan alat medis, dan prosedur klinis, serta keterampilan komunikasi interpersonal sangat menentukan efektivitas intervensi keperawatan. Perawat yang memiliki kompetensi klinis tinggi mampu menilai situasi klinis dengan cepat, tepat, dan mengambil keputusan yang akurat berdasarkan informasi dan bukti yang tersedia.

2. Pengalaman Profesional

Pengalaman profesional merupakan aset berharga bagi perawat dalam mengambil keputusan klinis. Semakin banyak pengalaman klinis yang dimiliki perawat, semakin baik kemampuannya dalam mengenali pola-pola klinis tertentu, memprediksi respons pasien terhadap berbagai intervensi, serta memilih tindakan yang paling sesuai berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman juga membantu perawat mengembangkan intuisi klinis yang kuat, meningkatkan rasa percaya diri, serta kemampuan dalam mengatasi situasi klinis yang tidak terduga atau kompleks.

3. Lingkungan Klinis

Lingkungan klinis tempat perawat bekerja memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan klinis. Lingkungan ini meliputi ketersediaan sumber daya medis seperti peralatan dan obat-obatan, kondisi fisik tempat kerja, dukungan administratif, serta dinamika hubungan antar anggota tim kesehatan. Lingkungan klinis yang mendukung, kondusif, dan kolaboratif akan memungkinkan perawat mengambil keputusan secara lebih efektif, tepat waktu, dan aman. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan hambatan dalam proses pengambilan keputusan serta mengurangi kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien.

4. Nilai Etik dan Moral

Keputusan klinis dalam keperawatan tidak hanya melibatkan aspek teknis atau medis, namun juga dipandu oleh nilai-nilai etik dan moral. Prinsip-prinsip etika seperti otonomi (menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan mengenai perawatannya sendiri), beneficence (melakukan yang terbaik untuk pasien), non-maleficence (tidak menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasien), justice (keadilan dalam pemberian layanan kesehatan), serta confidentiality (menjaga kerahasiaan informasi pasien) sangat menentukan keputusan yang diambil oleh perawat. Dengan memperhatikan nilai-nilai etik ini, perawat dapat memastikan bahwa keputusan klinis yang diambil tidak hanya tepat secara medis tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis.

5. Preferensi Pasien dan Keluarga

Dalam proses pengambilan keputusan klinis, penting bagi perawat untuk mempertimbangkan preferensi pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga biasanya memiliki harapan, nilai, keyakinan, serta kebutuhan khusus yang sangat mempengaruhi keputusan mengenai perawatan. Perawat harus mampu menjalin komunikasi efektif, mendengarkan secara aktif, dan memberikan edukasi tentang pilihan perawatan yang tersedia secara jelas kepada pasien dan keluarga.

Menghormati dan mengakomodasi preferensi pasien serta keluarganya tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien, tetapi juga menjamin bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pasien.

E. Strategi Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Pengambilan Keputusan

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis yang efektif, perawat dapat menerapkan beberapa strategi berikut secara lebih detail:

1. Pelatihan Berpikir Kritis Secara Terstruktur

Pelatihan berpikir kritis yang terstruktur mencakup program-program pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk memperkuat keterampilan berpikir analitis, evaluatif, dan inferensial. Pelatihan ini melibatkan pendekatan pedagogik yang jelas dan bertahap, serta menggunakan berbagai teknik seperti studi kasus, latihan pemecahan masalah, dan analisis situasi klinis. Tujuannya adalah untuk membantu perawat mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam mengambil keputusan, sehingga mereka mampu menghadapi situasi klinis yang kompleks dengan percaya diri dan kompeten.

2. Diskusi Kasus Klinis dan Refleksi Pengalaman

Diskusi kasus klinis merupakan metode pembelajaran interaktif yang sangat efektif dalam mengasah keterampilan berpikir kritis. Dalam diskusi ini, perawat secara kolektif menganalisis kasus nyata, mempertimbangkan berbagai aspek klinis, etis, sosial, dan emosional yang relevan, serta merumuskan berbagai alternatif keputusan. Diskusi ini mendorong perawat untuk berpikir secara kritis, mengasah kemampuan analisis, serta memperluas wawasan mereka melalui interaksi dengan rekan sejawat.

Refleksi pengalaman pribadi juga merupakan komponen penting dari pembelajaran berpikir kritis. Melalui refleksi, perawat mengevaluasi pengalaman klinis masa lalu, mengenali kekuatan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan mereka, serta merancang strategi perbaikan yang jelas untuk meningkatkan kualitas keputusan di masa depan.

3. Pendidikan Berbasis Simulasi

Pendidikan berbasis simulasi menyediakan lingkungan yang aman dan terkendali bagi perawat untuk melatih keterampilan klinis dan berpikir kritis. Dalam simulasi, perawat dihadapkan pada berbagai skenario klinis realistis yang mengharuskan mereka mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Simulasi memungkinkan perawat mengeksplorasi berbagai pendekatan, menerima umpan balik konstruktif secara langsung dari mentor atau instruktur, serta belajar dari

kesalahan tanpa risiko nyata bagi pasien. Strategi ini terbukti efektif dalam mempercepat penguasaan keterampilan berpikir kritis serta meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi klinis perawat.

4. Pembelajaran Interprofesional

Pembelajaran interprofesional melibatkan kolaborasi antara perawat dengan berbagai profesional kesehatan lainnya seperti dokter, farmasis, ahli gizi, dan terapis fisik. Dalam pembelajaran ini, perawat belajar memahami perspektif dan pendekatan profesional lainnya, berbagi informasi dan ide secara terbuka, serta membuat keputusan secara bersama-sama. Proses ini tidak hanya memperkaya wawasan perawat tetapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi mereka. Dengan demikian, pengambilan keputusan klinis yang dilakukan secara tim menjadi lebih holistik, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

5. Membaca Literatur Ilmiah Terbaru

Menjaga pengetahuan klinis tetap aktual dengan rutin membaca literatur ilmiah terbaru adalah strategi penting dalam pengembangan berpikir kritis. Dengan mengakses jurnal ilmiah terkini, perawat dapat memperbarui pemahaman mereka tentang intervensi keperawatan yang efektif, mengevaluasi relevansi informasi terbaru untuk praktik mereka, dan menerapkan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis. Strategi ini membantu perawat mempertahankan keunggulan kompetitif di lingkungan klinis yang terus berubah dan memastikan keputusan mereka selalu didasarkan pada informasi yang paling akurat dan relevan.

F. Latihan Soal

1. Seorang pasien, laki-laki 65 tahun, masuk rumah sakit dengan keluhan sesak napas, edema tungkai, dan nyeri dada. Data tambahan yang diperoleh meliputi tekanan darah 180/100 mmHg, respirasi 28 kali/menit, denyut nadi 102 kali/menit. Perawat melakukan analisis data dan menemukan hubungan antara keluhan pasien dan data klinis tersebut. Elemen berpikir kritis apakah yang digunakan perawat pada tahap ini?
 - A. Interpretasi
 - B. Analisis
 - C. Evaluasi
 - D. Inferensi
 - E. Eksplanasi

Kunci Jawaban: b. Analisis

Pembahasan: Analisis adalah kemampuan mengidentifikasi dan mengeksplorasi hubungan antara data klinis seperti tanda-tanda, gejala, dan hasil pemeriksaan. Pada kasus ini, perawat mengidentifikasi hubungan antara keluhan pasien dengan data klinis.

2. Seorang perawat menemukan bahwa beberapa informasi dalam catatan medis pasien tidak konsisten dengan hasil wawancara dengan pasien dan keluarganya. Sebelum mengambil keputusan, perawat menilai kembali validitas dan kredibilitas informasi tersebut. Tahapan berpikir kritis apa yang sedang dilakukan perawat?

- A. Interpretasi
- B. Analisis
- C. Evaluasi
- D. Inferensi
- E. Regulasi diri

Kunci Jawaban: c. Evaluasi

Pembahasan: Evaluasi melibatkan penilaian terhadap validitas, kredibilitas, relevansi, dan signifikansi dari informasi yang diperoleh untuk memastikan kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan klinis.

3. Seorang perawat telah merumuskan beberapa alternatif tindakan keperawatan untuk pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami hiperglikemia. Sebelum memilih tindakan terbaik, perawat melakukan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan setiap alternatif tindakan berdasarkan bukti ilmiah terbaru dan prinsip etika. Proses apa yang dilakukan perawat tersebut?

- A. Identifikasi masalah
- B. Evaluasi alternatif
- C. Pengumpulan data
- D. Implementasi keputusan
- E. Evaluasi hasil keputusan

Kunci Jawaban: b. Evaluasi alternatif

Pembahasan: Evaluasi alternatif adalah tahap menilai secara kritis kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif tindakan, mempertimbangkan bukti ilmiah terbaru serta prinsip etika dalam pengambilan keputusan.

4. Seorang pasien mengalami penurunan kesadaran mendadak pasca-operasi. Perawat segera melakukan pengumpulan data tambahan, seperti pemeriksaan vital sign dan data laboratorium terbaru untuk memahami kondisi pasien secara

menyeluruh sebelum mengambil keputusan klinis. Tahap berpikir kritis apakah yang digunakan perawat?

- A. Eksplanasi
- B. Inferensi
- C. Analisis
- D. Interpretasi
- E. Regulasi diri

Kunci Jawaban: d. Interpretasi

Pembahasan: Interpretasi adalah kemampuan memahami secara mendalam arti data klinis yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk merumuskan masalah secara tepat.

5. Setelah memberikan asuhan keperawatan selama 24 jam, perawat melakukan refleksi atas tindakan yang telah dilakukan, mengevaluasi apakah keputusan yang diambil efektif atau perlu perbaikan di masa depan. Elemen berpikir kritis manakah yang sedang diaplikasikan perawat tersebut?

- A. Evaluasi
- B. Inferensi
- C. Eksplanasi
- D. Regulasi diri
- E. Analisis

Kunci Jawaban: d. Regulasi diri

Pembahasan: Regulasi diri adalah kemampuan perawat untuk secara mandiri mengevaluasi dan memperbaiki proses berpikirnya, guna memastikan kualitas keputusan klinis dan terus meningkatkan kemampuan profesional.

G. Rangkuman Soal

Berpikir kritis dalam keperawatan merupakan proses intelektual aktif, sistematis, dan disiplin yang melibatkan analisis, sintesis, serta evaluasi informasi secara mendalam. Tujuan utama berpikir kritis adalah memastikan bahwa keputusan klinis didasarkan pada informasi akurat, bukti ilmiah terbaru, pengalaman profesional, intuisi keperawatan, serta prinsip-prinsip etik dan moral dalam praktik sehari-hari. Menurut Facione (2020), terdapat enam elemen utama dalam berpikir kritis, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri.

Interpretasi memungkinkan perawat memahami data klinis secara mendalam, sedangkan analisis membantu perawat mengidentifikasi hubungan antara berbagai data yang ada untuk menentukan diagnosis keperawatan secara efektif. Evaluasi memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan klinis

valid dan relevan, sementara inferensi digunakan untuk menarik kesimpulan logis dan menentukan intervensi keperawatan yang tepat. Eksplanasi memperkuat komunikasi perawat dengan pasien, keluarga, serta tim kesehatan lainnya dengan menjelaskan alasan tindakan yang dipilih. Regulasi diri membantu perawat mengevaluasi dan memperbaiki proses berpikirnya secara berkelanjutan untuk mempertahankan kualitas keputusan klinis.

Berpikir kritis sangat penting dalam praktik keperawatan karena mampu menjamin asuhan keperawatan berbasis bukti, meningkatkan kualitas keputusan klinis, mengurangi risiko kesalahan medis, mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya, serta mendukung kolaborasi interprofesional yang efektif dalam tim kesehatan.

Proses pengambilan keputusan klinis dalam keperawatan merupakan rangkaian langkah sistematis yang mencakup identifikasi masalah secara jelas, pengumpulan data yang komprehensif, analisis dan interpretasi data yang mendalam, perumusan berbagai alternatif keputusan, evaluasi alternatif secara kritis berdasarkan bukti dan etika, pemilihan keputusan terbaik, implementasi keputusan yang efektif, serta evaluasi hasil keputusan yang dilakukan untuk memastikan tindakan telah optimal atau perlu perbaikan lebih lanjut.

Pengambilan keputusan klinis dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan dan keterampilan klinis perawat, pengalaman profesional, kondisi lingkungan kerja, nilai etik dan moral yang dianut, serta preferensi pasien dan keluarga. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas keputusan klinis.

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis yang efektif, perawat dianjurkan mengikuti pelatihan berpikir kritis yang terstruktur, berdiskusi secara rutin mengenai kasus klinis, melakukan refleksi atas pengalaman pribadi, mengikuti pendidikan berbasis simulasi untuk mengembangkan keterampilan klinis secara aman, terlibat dalam pembelajaran interprofesional guna memperkaya wawasan serta meningkatkan kolaborasi antarprofesi, dan rutin memperbarui pengetahuan melalui pembacaan literatur ilmiah terbaru. Semua strategi ini membantu perawat mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk memberikan asuhan keperawatan berkualitas tinggi.

H. Glosarium

Analisis: Kemampuan mengidentifikasi dan mengeksplorasi hubungan antar data klinis untuk menemukan pola dan membantu menentukan diagnosis serta intervensi keperawatan yang tepat.

Berpikir Kritis: Proses intelektual disiplin, aktif, dan sistematis yang melibatkan analisis, sintesis, serta evaluasi informasi secara mendalam guna mengambil keputusan klinis yang akurat dan tepat.

Evaluasi: Proses penilaian terhadap validitas, kredibilitas, relevansi, dan signifikansi informasi klinis guna memastikan kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan klinis.

Eksplanasi: Kemampuan menjelaskan secara jelas dan rasional alasan di balik keputusan klinis dan tindakan yang dipilih, yang bertujuan memperkuat komunikasi dengan pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lainnya.

Inferensi: Kemampuan menarik kesimpulan logis berdasarkan analisis data dan bukti klinis, digunakan untuk menentukan diagnosis keperawatan dan intervensi yang paling efektif.

Interpretasi: Kemampuan memahami secara mendalam arti dari data klinis yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti wawancara pasien, hasil pemeriksaan fisik, dan data pendukung lainnya, untuk memahami kondisi pasien secara holistik.

Intuisi Keperawatan: Kemampuan perawat menggunakan naluri profesional berdasarkan pengalaman dalam menilai situasi klinis secara cepat untuk mengambil keputusan yang tepat.

Kolaborasi Interprofesional: Kerja sama efektif antarprofesional kesehatan dari berbagai bidang, seperti keperawatan, kedokteran, farmasi, dan nutrisi, guna memastikan pengambilan keputusan yang komprehensif dan terpadu.

Pengambilan Keputusan Klinis: Proses sistematis dalam menentukan tindakan terbaik untuk memberikan asuhan keperawatan optimal berdasarkan analisis yang mendalam, objektif, rasional, serta mempertimbangkan aspek etik dan preferensi pasien.

Regulasi Diri: Kemampuan perawat untuk secara mandiri mengelola dan mengevaluasi proses berpikirnya, memastikan kualitas keputusan klinis yang diambil serta mendorong perkembangan profesional secara berkelanjutan.

I. Daftar pustaka

- Alfaro-LeFevre, R. (2021). *Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical Judgment: A Practical Approach* (7th ed.). Elsevier.
- Benner, P., Hughes, R. G., & Sutphen, M. (2022). *Clinical Reasoning, Decision-Making, and Action: Thinking Critically and Clinically*. Springer.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson.
- Blais, K., & Hayes, J. S. (2020). *Professional Nursing Practice: Concepts and Perspectives* (8th ed.). Pearson.

- Facione, P. A. (2020). *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. Insight Assessment.
- Finkelman, A. (2020). *Professional Nursing Concepts: Competencies for Quality Leadership* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). *Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care* (10th ed.). Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2020). *Fundamentals of Nursing: Active Learning for Collaborative Practice* (2nd ed.). Elsevier.

BAB 2

PRAKTIK PENERAPAN PROSES KEPERAWATAN SEBAGAI METODE ILMIAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH/ASUHAN KEPERAWATAN

Pendahuluan

Proses keperawatan adalah serangkaian tindakan sistematis yang digunakan perawat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi berbagai masalah kesehatan pasien secara ilmiah dan rasional. Penerapan proses keperawatan sebagai metode ilmiah bertujuan untuk memastikan asuhan yang diberikan terstandar, terukur, dan berdasarkan bukti ilmiah terkini. Melalui penerapan langkah-langkah yang sistematis, perawat mampu melakukan intervensi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang praktik proses keperawatan sebagai metode ilmiah, mulai dari tahap pengkajian hingga evaluasi yang berbasis evidence-based practice.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan secara ilmiah untuk menyelesaikan berbagai masalah/asuhan keperawatan secara sistematis, kritis, dan berdasarkan evidence-based practice dalam konteks klinis yang nyata.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar proses keperawatan sebagai metode ilmiah.
- Mengaplikasikan proses keperawatan dalam situasi klinis secara sistematis dan terukur.
- Mengevaluasi efektivitas penerapan proses keperawatan sebagai metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah pasien.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi tahapan proses keperawatan secara ilmiah.
- Melakukan pengkajian yang komprehensif berbasis bukti dalam asuhan keperawatan.
- Merumuskan diagnosa keperawatan secara tepat berdasarkan data klinis.
- Menyusun rencana asuhan keperawatan yang terukur, realistis, dan berbasis evidence-based practice.
- Melaksanakan intervensi keperawatan secara efektif berdasarkan rencana yang telah disusun.
- Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan dengan metode evaluasi yang ilmiah dan rasional.

Uraian Materi

A. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang penting dan mendasar, berfungsi untuk mengumpulkan informasi komprehensif tentang kondisi pasien. Pada tahap ini, perawat mengidentifikasi status kesehatan pasien secara keseluruhan, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Data yang dikumpulkan dari tahap pengkajian menjadi landasan penting untuk menentukan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan yang tepat dan efektif.

1. Tujuan Pengkajian

Pengkajian dalam proses keperawatan bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi status kesehatan pasien secara lengkap
 - 1) Menentukan kondisi kesehatan umum pasien, baik yang normal maupun abnormal.
 - 2) Menilai fungsi organ dan sistem tubuh secara menyeluruh.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan dasar pasien yang terganggu
Menemukan masalah terkait kebutuhan dasar pasien seperti nutrisi, hidrasi, eliminasi, istirahat, dan aktivitas fisik.
- c. Mengidentifikasi faktor risiko dan potensi masalah kesehatan pasien
Mengenali faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi pasien, seperti riwayat penyakit sebelumnya, gaya hidup, serta lingkungan sosial dan fisik.
- d. Mengembangkan hubungan terapeutik yang baik antara perawat dengan pasien dan keluarga
 - 1) Membangun kepercayaan dan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarganya.
 - 2) Mendorong partisipasi aktif pasien dan keluarga dalam proses perawatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi melibatkan penggunaan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba untuk mengidentifikasi tanda-tanda klinis pasien. Observasi meliputi:

- 1) Penampilan fisik pasien (warna kulit, kebersihan diri, tanda-tanda edema atau luka)
- 2) Perilaku pasien (tingkat kesadaran, respons verbal dan non-verbal)
- 3) Ekspresi wajah dan postur tubuh (nyeri, kecemasan, ketegangan)
- 4) Pola pernapasan, irama jantung, dan tanda vital lainnya (tekanan darah, suhu tubuh, nadi, respirasi)

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah yang bertujuan menggali data subjektif melalui interaksi verbal dengan pasien atau keluarganya. Perawat harus memiliki keterampilan komunikasi terapeutik yang baik, seperti:

- 1) Mendengarkan secara aktif
- 2) Mengajukan pertanyaan terbuka (untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam)
- 3) Mengajukan pertanyaan tertutup (untuk mendapatkan informasi spesifik)
- 4) Menunjukkan empati dan perhatian penuh

c. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis menggunakan metode berikut:

- 1) Inspeksi: Mengamati kondisi fisik secara visual, seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan kelainan struktural.
- 2) Palpasi: Menggunakan sentuhan untuk merasakan tekstur, suhu, kelembaban kulit, adanya benjolan, atau rasa nyeri.
- 3) Perkusi: Mengetuk bagian tubuh tertentu untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, dan keberadaan cairan atau udara.
- 4) Auskultasi: Mendengarkan suara tubuh seperti denyut jantung, paru-paru, dan pergerakan usus menggunakan stetoskop.

d. Pemeriksaan Dokumentasi

Teknik ini melibatkan tinjauan terhadap berbagai dokumentasi medis yang telah tersedia, seperti:

- 1) Riwayat medis dan riwayat penyakit sebelumnya
- 2) Hasil pemeriksaan diagnostik (laboratorium, radiologi)
- 3) Catatan medis dari profesional kesehatan lain yang terlibat

3. Jenis Data dalam Pengkajian

a. Data Subjektif

Data subjektif diperoleh dari pasien atau keluarga berupa:

- 1) Keluhan utama pasien
- 2) Deskripsi rasa nyeri atau ketidaknyamanan
- 3) Persepsi pasien tentang kondisi kesehatannya
- 4) Riwayat kesehatan pasien dan keluarga

b. Data Objektif

Data objektif diperoleh dari observasi langsung, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi medis berupa:

- 1) Tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, frekuensi respirasi)
- 2) Hasil pemeriksaan fisik dan diagnostik (laboratorium, pencitraan)
- 3) Kondisi fisik yang teramati seperti luka, edema, dan kelainan fisik lainnya

4. Komponen Pengkajian Holistik

Pengkajian yang holistik mencakup berbagai aspek penting, yaitu:

- a. Aspek Fisik: Status kesehatan fisik pasien, tanda vital, fungsi organ.
- b. Aspek Psikologis: Kondisi mental, kecemasan, stres, depresi, mekanisme koping.
- c. Aspek Sosial: Dinamika keluarga, hubungan sosial, dukungan komunitas.
- d. Aspek Spiritual: Keyakinan agama, spiritualitas, praktik ibadah, dan pengaruhnya terhadap proses penyembuhan.

5. Pentingnya Dokumentasi Hasil Pengkajian

Dokumentasi hasil pengkajian memiliki peranan penting karena:

- a. Menjadi dasar kuat untuk menentukan diagnosa keperawatan yang tepat.
- b. Meningkatkan komunikasi efektif antar tim kesehatan.
- c. Memberikan landasan hukum terhadap tindakan perawatan yang dilakukan.
- d. Memastikan kontinuitas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

B. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan tahap penting dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan atau kebutuhan pasien secara spesifik berdasarkan data yang diperoleh selama pengkajian. Diagnosa keperawatan menekankan pada respons pasien terhadap kondisi kesehatan, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan diagnosa yang tepat, perawat dapat menentukan intervensi yang paling efektif guna mencapai hasil perawatan yang optimal.

1. Tujuan Diagnosa Keperawatan

Adapun tujuan utama diagnosa keperawatan meliputi:

- a. Menentukan masalah kesehatan atau kebutuhan pasien secara spesifik dan jelas.
Menyediakan data yang akurat tentang kondisi pasien secara holistik.
- b. Memudahkan perawat dalam merencanakan tindakan intervensi yang tepat dan efektif.

Memastikan bahwa setiap tindakan yang direncanakan relevan dengan kebutuhan pasien.

- c. Mengidentifikasi potensi komplikasi atau risiko yang dapat timbul selama perawatan.

Menyiapkan strategi preventif guna menghindari komplikasi lebih lanjut.

- d. Menjadi dasar dalam menentukan prioritas masalah keperawatan.

Membantu perawat dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien.

2. Proses Penentuan Diagnosa Keperawatan

Penentuan diagnosa keperawatan dilakukan melalui langkah-langkah sistematis berikut:

a. Analisis Data

Analisis data adalah proses kritis di mana perawat mengevaluasi informasi subjektif (keluhan pasien, riwayat kesehatan) dan data objektif (hasil pemeriksaan fisik dan diagnostik) yang telah diperoleh pada tahap pengkajian. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi pola atau tren, membandingkan dengan standar kesehatan normal, serta mengelompokkan data yang relevan.

b. Interpretasi Data

Setelah analisis, interpretasi data bertujuan memahami signifikansi klinis data tersebut. Perawat harus menentukan apakah data mengindikasikan suatu masalah aktual, potensi risiko, atau hanya informasi tambahan yang perlu dipantau.

c. Pengelompokan Data (Clustering Data)

Pada tahap ini, data yang diinterpretasikan diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok berdasarkan relevansi dan kemiripan masalah. Pengelompokan memudahkan perawat dalam mengenali masalah spesifik seperti gangguan pola tidur, gangguan nutrisi, defisit perawatan diri, atau risiko jatuh.

d. Identifikasi Masalah dan Penyusunan Diagnosa

Tahap akhir ini adalah mengidentifikasi masalah keperawatan secara spesifik berdasarkan data yang sudah dikelompokkan. Diagnosa keperawatan yang disusun harus sesuai dengan standar internasional, seperti NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association - International).

3. Jenis Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a. Diagnosa Aktual

Menggambarkan kondisi nyata yang dialami pasien berdasarkan tanda dan gejala yang sudah nyata. Contohnya, "Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan akumulasi sekret ditandai dengan sesak napas, batuk berdahak, dan ronki pada auskultasi paru."

b. Diagnosa Risiko

Mengacu pada kondisi yang berpotensi terjadi jika tidak dicegah. Misalnya, "Risiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka pascaoperasi."

c. Diagnosa Kesehatan atau Promosi Kesehatan

Fokus pada kesiapan pasien meningkatkan kesehatan atau mencegah penyakit. Contohnya adalah, "Kesiapan meningkatkan aktivitas fisik guna memperbaiki kondisi kesehatan."

4. Penyusunan Diagnosa Keperawatan Menurut NANDA-I

Dalam penyusunan diagnosa keperawatan berdasarkan NANDA-I, terdapat tiga komponen utama yang harus dipenuhi:

- a. Problem (Masalah): Masalah keperawatan yang dialami pasien secara nyata.
- b. Etiologi: Penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah tersebut.
- c. Symptom (Tanda dan Gejala): Bukti klinis yang mendukung adanya masalah keperawatan.

Format umum penulisan diagnosa keperawatan: "Masalah keperawatan (P) berhubungan dengan etiologi (E) dibuktikan dengan tanda dan gejala (S)."

5. Pentingnya Diagnosa Keperawatan dalam Praktik Klinis

Diagnosa keperawatan memiliki peranan penting dalam praktik klinis karena:

- a. Memberikan fondasi yang jelas dan kuat untuk menentukan intervensi keperawatan yang efektif.
- b. Menjamin kesinambungan pelayanan keperawatan, terutama dalam situasi multidisiplin.
- c. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice).
- d. Memfasilitasi komunikasi yang jelas antar tim kesehatan, sehingga tercipta perawatan yang terpadu, efektif, dan efisien.

C. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap penting dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menyusun strategi tindakan yang spesifik, jelas, terukur, dan terarah untuk mengatasi masalah kesehatan pasien yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosa keperawatan. Perencanaan yang baik didasarkan pada prioritas masalah, tujuan perawatan yang realistis, dan intervensi yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice). Dengan perencanaan yang matang, perawat dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pasien.

1. Tujuan Utama dari Tahap Perencanaan Keperawatan

Tujuan utama dari tahap perencanaan keperawatan meliputi:

- a. Menyusun strategi tindakan keperawatan yang spesifik, jelas, terukur, dan terarah dalam menangani masalah kesehatan pasien.
- b. Menentukan prioritas masalah berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap kondisi pasien.
- c. Menetapkan tujuan perawatan yang realistis, dapat dicapai, serta berorientasi pada hasil yang optimal bagi pasien.
- d. Menjamin semua intervensi yang dilakukan didasarkan pada evidence-based practice, sehingga kualitas perawatan terjamin dan terukur efektivitasnya.

2. Langkah-langkah dalam Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan melibatkan beberapa langkah sistematis, di antaranya:

a. Menentukan Prioritas Masalah

Dalam menentukan prioritas masalah, perawat perlu memperhatikan beberapa prinsip penting, yaitu:

- 1) Urgensi: Masalah yang membahayakan keselamatan dan mengancam jiwa pasien harus diatasi terlebih dahulu.
- 2) Keseriusan: Masalah dengan dampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien atau berpotensi menimbulkan komplikasi serius.
- 3) Preferensi Pasien: Mempertimbangkan nilai, preferensi, dan harapan pasien untuk mencapai kepuasan dalam pelayanan keperawatan.

b. Menetapkan Tujuan

Setelah menentukan prioritas, perawat harus menetapkan tujuan perawatan dengan kriteria SMART, yaitu:

- 1) Spesifik: Menjelaskan secara rinci apa yang ingin dicapai dalam proses perawatan.

- 2) Terukur: Memiliki indikator yang jelas untuk mengevaluasi pencapaian tujuan.
 - 3) Dapat dicapai: Realistis sesuai dengan kondisi pasien dan sumber daya yang tersedia.
 - 4) Relevan: Langsung berhubungan dengan diagnosa keperawatan dan masalah yang diidentifikasi.
 - 5) Berbasis Waktu: Menentukan jangka waktu yang spesifik untuk pencapaian tujuan tersebut.
- c. Memilih Intervensi Keperawatan
- Intervensi yang dipilih harus mempertimbangkan:
- 1) Efektivitas Intervensi: Berdasarkan bukti ilmiah yang menunjukkan keberhasilan intervensi tersebut dalam mengatasi masalah serupa.
 - 2) Kondisi Pasien: Menyesuaikan tindakan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.
 - 3) Ketersediaan Sumber Daya: Memastikan bahwa intervensi yang dipilih dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia.
 - 4) Kompetensi Perawat: Intervensi yang dipilih harus sesuai dengan keterampilan dan kompetensi perawat yang bertanggung jawab melaksanakannya.
- d. Dokumentasi Rencana Perawatan
- Setelah perencanaan dibuat, dokumentasi rencana perawatan harus dilakukan dengan jelas, terstruktur, dan rinci mencakup tujuan perawatan, intervensi spesifik, metode evaluasi, serta tim yang terlibat dalam pelaksanaannya.

3. Komponen Perencanaan Keperawatan

Komponen utama perencanaan meliputi:

- a. Tujuan (Goals): Menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dari perawatan.
- b. Kriteria Hasil (Outcome Criteria): Indikator spesifik dan terukur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan.
- c. Intervensi Keperawatan: Aktivitas keperawatan spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan perawatan.

4. Contoh Perencanaan Keperawatan

Berikut contoh detail perencanaan keperawatan untuk diagnosa "Risiko infeksi berhubungan dengan luka operasi":

- a. Tujuan: Pasien terbebas dari infeksi selama masa perawatan di rumah sakit.
- b. Kriteria Hasil:
 - 1) Tidak muncul tanda-tanda infeksi seperti demam, kemerahan, bengkak, nyeri, atau eksudat purulen pada luka.
 - 2) Hasil kultur luka negatif sepanjang masa perawatan.

c. Intervensi Keperawatan:

- 1) Melakukan perawatan luka dengan teknik aseptik setiap kali tindakan.
- 2) Memberikan edukasi secara rutin kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan perawatan luka secara mandiri.
- 3) Memantau tanda-tanda infeksi seperti suhu tubuh, kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan sekret luka setiap shift.
- 4) Mengganti balutan luka sesuai jadwal dan standar prosedur yang berlaku.
- 5) Kolaborasi dengan tim medis untuk tindakan lanjutan bila tanda infeksi muncul.

5. Pentingnya Perencanaan dalam Praktik Keperawatan

Perencanaan yang matang sangat penting dalam praktik keperawatan karena:

- a. Memastikan setiap tindakan keperawatan memiliki arah dan tujuan yang jelas.
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan material yang ada.
- c. Menjamin tindakan perawatan yang diberikan relevan, efektif, dan efisien.
- d. Meningkatkan koordinasi antar tim kesehatan sehingga memberikan pelayanan terpadu yang konsisten dan berkualitas tinggi.

D. Implementasi

Implementasi merupakan tahap krusial dalam proses keperawatan, di mana perawat melaksanakan intervensi keperawatan yang telah direncanakan secara langsung kepada pasien. Tahap ini tidak hanya sekadar melaksanakan tindakan, tetapi juga memastikan tindakan tersebut efektif dan memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan pasien. Implementasi melibatkan partisipasi aktif pasien dan keluarga dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan fisik dan emosional, serta kebutuhan psikologis pasien agar tercipta suasana terapeutik yang optimal.

1. Tujuan Implementasi

Tujuan dari tahap implementasi adalah:

- a. Melaksanakan intervensi keperawatan secara efektif dan sesuai dengan rencana.
- b. Meningkatkan kondisi kesehatan, kenyamanan fisik, emosional, dan psikologis pasien.
- c. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai tindakan keperawatan yang sedang dijalankan.
- d. Mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi aktif pasien serta keluarganya dalam proses perawatan.

2. Prinsip-prinsip Implementasi Keperawatan

Implementasi tindakan keperawatan harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip utama:

- a. Keselamatan Pasien: Menjamin bahwa semua tindakan dilakukan dengan standar keselamatan tertinggi untuk menghindari cedera, infeksi, atau komplikasi.
- b. Kenyamanan Pasien: Mengutamakan aspek kenyamanan pasien, baik fisik maupun psikologis, selama implementasi.
- c. Kolaborasi: Melibatkan pasien, keluarga, serta anggota tim kesehatan lainnya secara efektif dalam pelaksanaan intervensi.
- d. Konsistensi: Memastikan intervensi yang dilaksanakan konsisten dengan rencana keperawatan yang telah disusun.
- e. Berbasis Bukti (Evidence-based): Semua tindakan didasarkan pada praktik terbaik yang telah teruji secara ilmiah.

3. Langkah-langkah Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan terdiri dari beberapa langkah detail berikut ini:

a. Persiapan

Persiapan sebelum implementasi mencakup:

- 1) Meninjau ulang rencana keperawatan untuk memastikan keakuratan dan relevansinya dengan kondisi pasien saat ini.
- 2) Memastikan semua alat, bahan, dan lingkungan yang dibutuhkan telah siap, steril, dan aman.
- 3) Mempersiapkan pasien dan keluarga secara psikologis dengan memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini, perawat melaksanakan tindakan keperawatan secara langsung, yang mencakup:

- 1) Mengikuti prosedur aseptik dan profesional sesuai standar yang berlaku.
- 2) Mengkomunikasikan setiap tindakan secara jelas kepada pasien dan keluarganya.
- 3) Mengamati dan mencatat respons pasien secara cermat dan detail selama dan setelah tindakan.

c. Dokumentasi

Setelah melaksanakan intervensi, perawat wajib mencatat:

- 1) Tindakan keperawatan yang dilakukan dengan jelas dan lengkap.
- 2) Reaksi atau respons pasien terhadap tindakan yang telah dilakukan.
- 3) Kondisi fisik dan emosional pasien setelah pelaksanaan intervensi.
- 4) Kejadian khusus atau catatan tambahan jika diperlukan.

4. Strategi Implementasi yang Efektif

Strategi efektif dalam implementasi tindakan keperawatan meliputi:

- a. Komunikasi Efektif: Menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk memastikan pasien dan keluarga memahami setiap tindakan.
- b. Pendekatan Individual: Menyesuaikan intervensi berdasarkan kondisi unik pasien, meliputi usia, latar belakang budaya, kondisi fisik, dan psikologis.
- c. Evaluasi Berkala: Melakukan observasi rutin terhadap kondisi pasien untuk memastikan intervensi sesuai kebutuhan.
- d. Fleksibilitas: Siap menyesuaikan atau memodifikasi intervensi jika terjadi perubahan kondisi pasien atau ada hambatan pelaksanaan.

5. Peran Perawat dalam Implementasi

Peran penting perawat dalam tahap implementasi meliputi:

- a. Sebagai pelaksana utama dalam tindakan keperawatan.
- b. Sebagai edukator yang menyediakan informasi penting kepada pasien dan keluarga.
- c. Sebagai advokat yang melindungi hak pasien, memastikan kenyamanan dan keselamatan.
- d. Sebagai koordinator yang memastikan kelancaran kolaborasi antar tim kesehatan.

6. Contoh Implementasi dalam Praktik Keperawatan

Berikut adalah contoh implementasi tindakan keperawatan pada diagnosa keperawatan "Risiko infeksi berhubungan dengan luka operasi":

- a. Menggunakan teknik aseptik ketat selama perawatan luka.
- b. Memberikan edukasi secara rinci kepada pasien dan keluarga tentang cara perawatan luka yang tepat di rumah.
- c. Melakukan pemeriksaan rutin luka untuk mendeteksi tanda-tanda awal infeksi, seperti kemerahan, nyeri, atau peningkatan suhu tubuh.
- d. Melaporkan dengan cepat kepada tim medis jika ada tanda-tanda infeksi yang terdeteksi.

7. Pentingnya Implementasi dalam Praktik Keperawatan

Implementasi yang dilakukan secara baik dan tepat memiliki manfaat berikut:

- a. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan efektivitas intervensi.
- b. Mempercepat proses pemulihan pasien secara menyeluruh.
- c. Mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan.
- d. Meningkatkan hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.

E. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam proses keperawatan, di mana perawat secara sistematis menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan perawatan telah tercapai, serta memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Hasil dari tahap evaluasi digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, apakah intervensi perlu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan, sesuai dengan kondisi pasien yang terbaru dan kebutuhan yang teridentifikasi.

1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dalam proses keperawatan bertujuan untuk:

- a. Menilai efektivitas dan efisiensi intervensi keperawatan yang telah dilaksanakan.
- b. Mengukur pencapaian tujuan perawatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Menyesuaikan rencana intervensi berikutnya berdasarkan hasil evaluasi.
- d. Menilai tingkat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan.

2. Prinsip-prinsip Evaluasi Keperawatan

Dalam melaksanakan evaluasi, perawat harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. **Objektivitas:** Evaluasi harus dilakukan berdasarkan data objektif yang akurat dan dapat dipercaya.
- b. **Kontinuitas:** Evaluasi harus berlangsung secara terus-menerus selama proses perawatan untuk memastikan relevansi tindakan yang diberikan.
- c. **Fleksibilitas:** Evaluasi harus fleksibel sehingga memungkinkan penyesuaian intervensi apabila terjadi perubahan kondisi pasien.

- d. Keterlibatan Pasien dan Keluarga: Pasien dan keluarga harus dilibatkan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas intervensi.

3. Langkah-langkah Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan terdiri dari beberapa langkah penting berikut:

- a. Mengumpulkan Data Evaluasi

Perawat mengumpulkan data yang relevan, meliputi:

- 1) **Data subjektif:** informasi langsung dari pasien tentang perubahan yang dirasakan setelah tindakan, seperti keluhan, rasa nyeri, atau kenyamanan.
- 2) **Data objektif:** hasil observasi klinis, pemeriksaan fisik, dan data laboratorium setelah pelaksanaan tindakan.

- b. Membandingkan Data dengan Tujuan

Data yang diperoleh dibandingkan secara langsung dengan tujuan perawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai sepenuhnya, sebagian, atau belum tercapai.

- c. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil

Perawat perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil evaluasi, seperti:

- 1) Respons fisik dan psikologis pasien terhadap intervensi yang diberikan.
- 2) Faktor internal pasien seperti kepatuhan dalam menjalankan intervensi atau instruksi perawatan.
- 3) Faktor eksternal seperti ketersediaan sumber daya atau dukungan keluarga.

- d. Merumuskan Tindakan Lanjutan

Berdasarkan hasil evaluasi, perawat harus merumuskan rencana tindakan berikutnya, yang dapat berupa:

- 1) Melanjutkan intervensi yang terbukti efektif.
- 2) Mengubah atau memodifikasi intervensi yang kurang efektif.
- 3) Menghentikan intervensi yang tidak memberikan hasil atau tidak relevan lagi.

- e. Dokumentasi Hasil Evaluasi

Setelah evaluasi dilakukan, semua hasil dan rencana tindak lanjut harus didokumentasikan secara jelas dan terstruktur dalam catatan keperawatan, guna menunjang kontinuitas perawatan dan komunikasi antar tim kesehatan.

4. Metode Evaluasi Keperawatan

Berikut beberapa metode evaluasi yang umum digunakan:

- a. Observasi langsung: Mengamati secara langsung perubahan kondisi pasien.
- b. Wawancara pasien dan keluarga: Mengumpulkan informasi langsung dari pasien dan keluarga terkait kondisi terkini.

- c. Pemeriksaan fisik dan klinis: Melakukan pengkajian fisik dan pemeriksaan klinis untuk mendapatkan data objektif tentang kondisi pasien.
- d. Review data dokumentasi: Meninjau kembali catatan keperawatan untuk membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi.

5. Contoh Evaluasi dalam Praktik Keperawatan

Berikut contoh evaluasi untuk diagnosa keperawatan "Risiko infeksi berhubungan dengan luka operasi":

- a. Tujuan perawatan: Pasien bebas dari tanda infeksi selama perawatan di rumah sakit.
- b. Data evaluasi:
 - 1) Tidak ditemukan tanda-tanda infeksi seperti demam, nyeri, kemerahan, bengkak, atau adanya eksudat pada luka.
 - 2) Hasil kultur luka menunjukkan negatif infeksi.
- c. Kesimpulan evaluasi: Tujuan perawatan tercapai.
- d. Tindakan lanjutan: Melanjutkan edukasi tentang cara merawat luka secara mandiri di rumah untuk mencegah risiko infeksi.

6. Pentingnya Evaluasi dalam Praktik Keperawatan

Evaluasi yang sistematis dan efektif sangat penting karena:

- a. Menyediakan informasi yang jelas tentang efektivitas intervensi keperawatan.
- b. Menjamin bahwa perawatan yang diberikan selalu relevan dengan kondisi pasien.
- c. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan melalui perbaikan yang berkelanjutan.
- d. Memastikan bahwa sumber daya yang digunakan selama proses keperawatan digunakan secara efisien dan efektif.

F. Latihan Soal

1. Seorang perempuan usia 55 tahun datang ke poliklinik mengeluhkan nyeri dada kiri sejak dua hari terakhir. Ia juga mengatakan sulit tidur karena cemas dengan kondisinya. Data berikut yang termasuk data subjektif dalam pengkajian adalah...
 - A. Tekanan darah 150/90 mmHg
 - B. Ekspresi wajah tegang dan pucat
 - C. Keluhan nyeri dada kiri sejak dua hari terakhir
 - D. Frekuensi pernapasan 24 kali/menit
 - E. Terdengar ronki saat auskultasi paru-paru

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Data subjektif merupakan informasi yang disampaikan langsung oleh pasien tentang perasaan atau keluhan yang dialami. Keluhan nyeri dada kiri termasuk data subjektif, sedangkan opsi lainnya adalah data objektif yang diperoleh melalui observasi atau pemeriksaan fisik oleh perawat.

2. Seorang laki-laki usia 70 tahun pasca stroke tampak mengalami kesulitan bergerak. Hasil pengkajian menunjukkan pasien mengalami defisit perawatan diri yang ditandai dengan kesulitan mandi, berpakaian, dan makan. Berdasarkan data tersebut, diagnosa keperawatan yang tepat adalah...
- A. Risiko jatuh berhubungan dengan kelemahan otot
 - B. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot
 - C. Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan otot ditandai dengan kesulitan mandi, berpakaian, dan makan
 - D. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan fungsi otak
 - E. Risiko infeksi berhubungan dengan tirah baring lama

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Diagnosa keperawatan disusun berdasarkan format NANDA-I, yaitu mencakup masalah, etiologi, dan gejala/tanda (P-E-S). Pasien mengalami defisit perawatan diri dengan penyebab kelemahan otot dan dibuktikan dengan kesulitan mandi, berpakaian, dan makan.

3. Seorang perempuan, usia 30 tahun, dirawat pasca-operasi appendiktomi. Pasien berisiko mengalami infeksi luka operasi. Perawat menetapkan tujuan keperawatan dengan kriteria hasil spesifik. Salah satu indikator kriteria hasil yang paling tepat adalah...
- A. Pasien merasa nyaman selama dirawat
 - B. Suhu tubuh pasien tidak melebihi 37,5°C selama masa perawatan
 - C. Pasien dapat berjalan sendiri ke kamar mandi dalam waktu 2 hari
 - D. Pasien mengerti pentingnya menjaga kebersihan
 - E. Pasien menunjukkan wajah ceria

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Tujuan perawatan dengan kriteria SMART harus spesifik dan terukur. Indikator suhu tubuh tidak melebihi 37,5°C merupakan indikator terukur untuk menentukan ada tidaknya tanda infeksi pada pasien pasca-operasi.

4. Seorang pasien laki-laki, usia 65 tahun, dirawat dengan diagnosa keperawatan "Risiko infeksi berhubungan dengan luka operasi". Implementasi keperawatan yang paling tepat untuk dilakukan perawat adalah...
- A. Memberikan obat analgesik secara teratur
 - B. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap tanda-tanda infeksi luka
 - C. Mengukur tekanan darah setiap 6 jam
 - D. Mengatur posisi tidur pasien setiap 2 jam
 - E. Memberikan makanan tinggi kalori dan protein

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Implementasi keperawatan harus relevan dengan diagnosa keperawatan yang telah ditentukan. Pada diagnosa risiko infeksi, tindakan keperawatan yang utama adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap tanda-tanda infeksi untuk deteksi dini sehingga infeksi dapat dicegah atau segera ditangani.

5. Setelah tiga hari dilakukan tindakan keperawatan, pasien dengan diagnosa "Risiko infeksi berhubungan dengan luka operasi" dievaluasi. Data evaluasi berikut menunjukkan tujuan perawatan telah tercapai secara optimal adalah...
- A. Luka operasi sedikit kemerahan dan bengkak
 - B. Pasien mengeluhkan nyeri ringan di daerah luka operasi
 - C. Luka operasi kering, bersih, tanpa tanda kemerahan atau bengkak
 - D. Pasien tampak cemas saat melihat luka operasi
 - E. Suhu tubuh pasien 38°C

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan intervensi keperawatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Luka operasi yang kering, bersih, tanpa tanda kemerahan atau bengkak menunjukkan tidak adanya tanda infeksi dan menandakan bahwa tujuan perawatan tercapai secara optimal.

G. Rangkuman Materi

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang bertujuan mengumpulkan data menyeluruh tentang kondisi kesehatan pasien meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Informasi dari pengkajian digunakan untuk menentukan diagnosa, perencanaan, implementasi, serta evaluasi keperawatan secara efektif. Teknik pengumpulan data pada pengkajian mencakup observasi langsung terhadap kondisi fisik pasien, wawancara mendalam dengan pasien dan keluarga, pemeriksaan fisik yang sistematis melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan

auskultasi, serta pemeriksaan dokumentasi medis pasien. Data dalam pengkajian terdiri dari data subjektif berupa keluhan pasien dan persepsi kesehatannya, serta data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan diagnostik. Pengkajian secara holistik mempertimbangkan kondisi fisik, mental, sosial, serta spiritual pasien, sehingga didapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi pasien. Dokumentasi hasil pengkajian menjadi penting karena digunakan sebagai dasar penentuan diagnosa keperawatan yang tepat, meningkatkan komunikasi antar tim kesehatan, memberikan dasar hukum tindakan keperawatan, dan memastikan kontinuitas layanan keperawatan.

Diagnosa keperawatan merupakan tahap yang bertujuan mengidentifikasi masalah kesehatan pasien secara spesifik berdasarkan data pengkajian yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Tahap ini penting dalam menentukan intervensi yang tepat serta memprediksi potensi komplikasi selama perawatan. Proses penentuan diagnosa dilakukan melalui analisis data secara sistematis, interpretasi makna klinis data, pengelompokan data berdasarkan kemiripan masalah, serta penyusunan diagnosa sesuai standar internasional (NANDA-I). Jenis diagnosa keperawatan meliputi diagnosa aktual (masalah nyata yang dialami pasien), diagnosa risiko (potensi masalah yang dapat terjadi), serta diagnosa kesehatan atau promosi kesehatan (kesiapan pasien untuk memperbaiki kesehatan). Diagnosa keperawatan yang akurat menjadi dasar kuat dalam merencanakan intervensi, menjamin kontinuitas pelayanan, meningkatkan kualitas perawatan melalui pendekatan berbasis bukti, serta memudahkan komunikasi antar tim kesehatan.

Perencanaan keperawatan merupakan tahap penyusunan strategi tindakan yang spesifik, jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil yang optimal bagi pasien berdasarkan diagnosa yang telah ditentukan. Tahap ini melibatkan penentuan prioritas masalah berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan preferensi pasien. Tujuan perawatan dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, relevan dengan diagnosa, dan memiliki batas waktu jelas (SMART). Intervensi yang dipilih harus mempertimbangkan efektivitas berdasarkan bukti ilmiah, kondisi pasien, ketersediaan sumber daya, dan kompetensi perawat. Dokumentasi rencana perawatan mencakup tujuan, intervensi spesifik, metode evaluasi, dan tim pelaksana tindakan. Perencanaan yang baik memastikan tindakan keperawatan efektif, efisien, relevan dengan kebutuhan pasien, serta meningkatkan koordinasi pelayanan kesehatan secara terpadu.

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan langsung dari rencana keperawatan yang telah disusun sebelumnya. Tujuannya adalah melaksanakan tindakan secara efektif, meningkatkan kondisi kesehatan dan kenyamanan pasien,

memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam perawatan. Pelaksanaan intervensi harus memperhatikan prinsip keselamatan, kenyamanan pasien, kolaborasi efektif antar tim kesehatan, konsistensi dengan rencana yang ada, serta berbasis bukti ilmiah. Langkah implementasi mencakup persiapan (peninjauan ulang rencana, menyiapkan lingkungan, alat, serta edukasi pasien), pelaksanaan tindakan secara profesional, serta dokumentasi tindakan dan respons pasien. Strategi implementasi efektif melibatkan komunikasi terapeutik, pendekatan individual sesuai kondisi pasien, evaluasi berkala, serta fleksibilitas terhadap perubahan kondisi pasien. Implementasi yang baik mempercepat pemulihan, mengurangi komplikasi, meningkatkan kualitas perawatan, serta memperkuat hubungan harmonis antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan menilai efektivitas intervensi dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah tindakan dilaksanakan. Evaluasi berperan dalam menentukan sejauh mana tujuan perawatan telah tercapai, menyesuaikan tindakan lanjutan, serta menilai tingkat kepuasan pasien dan keluarga. Evaluasi harus memperhatikan prinsip objektivitas, kontinuitas, fleksibilitas, serta melibatkan perspektif pasien dan keluarga. Langkah-langkah evaluasi meliputi pengumpulan data subjektif dan objektif terkait kondisi pasien setelah intervensi, membandingkan data tersebut dengan tujuan yang telah ditentukan, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hasil, merumuskan tindakan lanjutan, serta mendokumentasikan seluruh hasil evaluasi secara jelas. Metode evaluasi umum adalah observasi langsung, wawancara pasien dan keluarga, pemeriksaan fisik, serta review dokumentasi medis. Evaluasi yang sistematis memastikan bahwa tindakan keperawatan selalu relevan, efektif, efisien, dan memberikan dasar untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

H. Glosarium

Analisis Data: Tahap kritis dalam diagnosa keperawatan yang melibatkan evaluasi informasi subjektif dan objektif untuk menemukan pola atau tren masalah kesehatan pasien.

Auskultasi: Teknik pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar suara organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan pergerakan usus.

Data Objektif: Informasi tentang kondisi pasien yang diperoleh melalui observasi langsung, pemeriksaan fisik, serta hasil pemeriksaan diagnostik seperti laboratorium dan radiologi.

Data Subjektif: Informasi yang disampaikan langsung oleh pasien atau keluarganya tentang keluhan, perasaan, persepsi, dan riwayat kesehatannya.

Diagnosa Aktual: Kondisi nyata yang sedang dialami pasien, ditandai dengan gejala atau tanda klinis yang jelas.

Diagnosa Keperawatan: Penilaian klinis oleh perawat terhadap respons individu terhadap masalah kesehatan, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Diagnosa Risiko: Kondisi yang belum terjadi tetapi berpotensi muncul jika tidak dicegah atau diatasi secara dini.

Dokumentasi: Pencatatan secara sistematis data pasien, tindakan yang dilakukan, serta respons pasien untuk menjaga kontinuitas, komunikasi antar tim kesehatan, dan sebagai dasar hukum tindakan keperawatan.

Evaluasi: Tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan menilai sejauh mana tujuan keperawatan tercapai dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Implementasi: Pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan, melibatkan tindakan langsung kepada pasien untuk mencapai tujuan perawatan yang telah ditetapkan.

Inspeksi: Pemeriksaan fisik dengan cara pengamatan visual untuk menilai kondisi umum, warna kulit, struktur tubuh, dan kelainan fisik pasien.

Intervensi Keperawatan: Aktivitas atau tindakan yang dirancang secara spesifik oleh perawat untuk mencapai tujuan perawatan berdasarkan diagnosa keperawatan.

Interpretasi Data: Proses memahami dan memberikan makna klinis terhadap data hasil analisis, untuk menentukan apakah data menunjukkan masalah aktual, risiko, atau hanya informasi tambahan.

Kriteria Hasil (Outcome Criteria): Indikator spesifik dan terukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan perawatan.

Palpasi: Pemeriksaan fisik dengan menggunakan sentuhan untuk mengevaluasi tekstur, suhu, kelembaban kulit, serta mendeteksi adanya benjolan atau rasa nyeri.

Pengelompokan Data (Clustering Data): Mengklasifikasikan data berdasarkan relevansi dan kemiripan untuk membantu mengidentifikasi masalah keperawatan secara spesifik.

Pengkajian: Tahap pertama dalam proses keperawatan untuk mengumpulkan informasi komprehensif tentang kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh dan holistik.

Percusi: Teknik pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk bagian tubuh tertentu untuk menilai ukuran, konsistensi organ, serta keberadaan cairan atau udara dalam tubuh.

Perencanaan Keperawatan: Proses menyusun rencana tindakan spesifik, terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil untuk mengatasi masalah kesehatan yang telah diidentifikasi berdasarkan diagnosa keperawatan.

Prioritas Masalah: Penentuan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan preferensi pasien untuk memastikan efisiensi tindakan keperawatan.

Proses Keperawatan: Serangkaian tahap sistematis yang digunakan oleh perawat meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam memberikan asuhan yang profesional dan efektif.

SMART (Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Relevan, Berbasis Waktu): Kriteria dalam penyusunan tujuan perawatan agar jelas, realistis, efektif, dan terukur.

Teknik Aseptik: Cara kerja dalam tindakan keperawatan untuk mencegah terjadinya infeksi melalui prosedur yang menjaga sterilitas.

Wawancara: Metode pengumpulan data subjektif melalui komunikasi dua arah antara perawat dengan pasien atau keluarga, menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang efektif.

I. Daftar pustaka

Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Flynn Makic, M. B., Martinez-Kratz, M., & Zannoti, M. (2022). *Nursing diagnosis handbook: An evidence-based guide to planning care* (13th ed.). Elsevier.

Berman, A., Snyder, S. J., Frandsen, G., & Kozier, B. (2021). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson Education.

Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Diagnosis Manual: Planning, Individualizing, and Documenting Client Care* (6th ed.). F.A. Davis Company.

Fischbach, F., & Dunning, M. B. (2021). *A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests* (11th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Gulanick, M., & Myers, J. L. (2022). *Nursing Care Plans: Diagnoses, Interventions, & Outcomes* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.

Jarvis, C. (2019). *Physical Examination and Health Assessment* (8th ed.). Elsevier.

NANDA International. (2021). *Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 2021-2023* (12th ed.). Thieme Publishers.

Perry, A. G., Potter, P. A., & Ostendorf, W. R. (2022). *Clinical Nursing Skills & Techniques* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2022). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2018). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Care* (9th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Wilkinson, J. M., Treas, L. S., Barnett, K., & Smith, M. H. (2020). *Fundamentals of Nursing: Theory, Concepts, and Applications* (4th ed.). F.A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2020). *Fundamentals of Nursing: Active Learning for Collaborative Practice* (2nd ed.). Elsevier.

BAB 3

PRAKTIK MENETAPKAN MASALAH/DIAGNOSA KEPERAWATAN

Pendahuluan

Menetapkan diagnosa keperawatan merupakan tahap penting dalam proses keperawatan yang membantu perawat dalam menentukan rencana asuhan yang tepat dan spesifik berdasarkan data hasil pengkajian. Diagnosa keperawatan berfungsi sebagai landasan dalam memilih intervensi keperawatan yang efektif untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal bagi pasien. Pemahaman yang mendalam mengenai proses identifikasi dan penetapan diagnosa keperawatan memungkinkan perawat memberikan pelayanan kesehatan secara akurat, relevan, dan komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.

Dalam bab ini, mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik penting dalam praktik menetapkan masalah atau diagnosa keperawatan, mulai dari analisis data hasil pengkajian, klasifikasi masalah, formulasi diagnosa, hingga penerapan diagnosa sesuai standar keperawatan terkini.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran dalam bab ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dan praktik penetapan masalah atau diagnosa keperawatan secara efektif, terintegrasi, dan berbasis bukti untuk mendukung pelayanan keperawatan berkualitas.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan penetapan diagnosa keperawatan dengan tepat dan berbasis bukti untuk merencanakan intervensi keperawatan yang efektif pada berbagai kondisi klinis.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar masalah dan diagnosa keperawatan.
- Mengidentifikasi dan mengklasifikasi data pengkajian dalam penetapan diagnosa keperawatan.

- Menerapkan langkah-langkah analisis data untuk mengidentifikasi masalah atau diagnosa keperawatan.
- Merumuskan diagnosa keperawatan secara akurat sesuai standar terminologi yang diakui (NANDA-I).
- Menjelaskan hubungan antara diagnosa keperawatan dengan intervensi keperawatan yang relevan dan efektif.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Masalah dan Diagnosa Keperawatan

Masalah keperawatan adalah kondisi yang memerlukan intervensi keperawatan, yang diidentifikasi berdasarkan hasil pengkajian terhadap pasien. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinis tentang respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau potensi masalah kesehatan. Diagnosa keperawatan menjadi pedoman utama dalam menentukan prioritas tindakan.

Masalah keperawatan timbul dari berbagai kondisi yang dialami pasien, baik secara langsung terkait dengan penyakit atau kondisi kesehatan, maupun dampak psikososial dan spiritual yang dihadapi. Identifikasi masalah keperawatan dilakukan melalui proses pengkajian yang teliti, mengumpulkan informasi secara objektif dan subjektif, termasuk tanda-tanda fisik, gejala yang dialami pasien, riwayat kesehatan, serta data psikososial dan spiritual.

Diagnosa keperawatan memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari diagnosa medis. Diagnosa keperawatan fokus pada respons pasien terhadap kondisi atau situasi yang dihadapi, sedangkan diagnosa medis berfokus pada identifikasi penyakit atau kondisi patologis. Diagnosa keperawatan menggunakan pendekatan holistik, memperhatikan seluruh aspek kehidupan pasien untuk menentukan intervensi yang paling tepat.

Untuk menetapkan diagnosa keperawatan dengan tepat, perawat harus memahami jenis-jenis diagnosa keperawatan secara lebih mendalam, yaitu:

1. **Diagnosa Aktual** Diagnosa aktual adalah kondisi nyata yang sedang dialami oleh pasien dan sudah menunjukkan tanda-tanda serta gejala-gejala jelas. Perawat dapat mengenali kondisi ini melalui observasi langsung, wawancara, dan hasil pengukuran klinis yang menunjukkan adanya penyimpangan dari kondisi normal. Contohnya adalah nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, dan risiko infeksi.
2. **Diagnosa Risiko** Diagnosa risiko adalah kondisi yang belum terjadi tetapi memiliki potensi besar untuk muncul jika tidak ada intervensi pencegahan yang memadai. Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan analisis faktor-faktor predisposisi seperti usia, pola hidup, atau kondisi kesehatan tertentu. Contohnya adalah risiko jatuh pada lansia, risiko infeksi pada pasien pasca operasi, dan risiko cedera akibat gangguan kesadaran.
3. **Diagnosa Promosi Kesehatan** Diagnosa promosi kesehatan berfokus pada pengembangan kondisi sehat secara optimal dengan meningkatkan kesadaran pasien tentang pentingnya menjaga kesehatan. Diagnosa ini menekankan pada upaya preventif dan edukatif yang mendukung peningkatan kesehatan pasien,

keluarga, atau komunitas secara menyeluruh. Contohnya adalah kesiapan untuk peningkatan aktivitas fisik, kesiapan untuk belajar manajemen stres, dan kesiapan untuk perubahan pola nutrisi.

Proses penetapan diagnosa keperawatan melibatkan tahapan-tahapan krusial seperti:

1. **Analisis Data:** Memeriksa dan menginterpretasi data secara mendalam untuk menemukan pola atau hubungan antar data.
2. **Validasi Data:** Memastikan data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan komprehensif.
3. **Identifikasi Pola:** Mengenali pola-pola khusus dari kumpulan data yang mengindikasikan adanya masalah keperawatan.
4. **Penggunaan Terminologi Standar (NANDA-I):** Menjamin bahwa diagnosa keperawatan diformulasikan dengan jelas, sistematis, dan diakui secara internasional.

Penetapan diagnosa yang akurat sangat penting dalam menentukan prioritas tindakan dan intervensi keperawatan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

B. Identifikasi dan Klasifikasi Data

Identifikasi dan klasifikasi data adalah proses sistematis dalam praktik keperawatan yang bertujuan untuk mengenali masalah kesehatan pasien berdasarkan informasi yang didapatkan selama proses pengkajian. Tahap ini sangat krusial karena kualitas pengumpulan dan analisis data akan sangat menentukan akurasi diagnosa keperawatan yang dihasilkan.

Dalam tahap identifikasi data, perawat secara aktif mengumpulkan informasi yang relevan melalui beberapa metode penting:

1. **Wawancara:** Mengumpulkan data dari pasien atau keluarganya melalui komunikasi verbal yang terstruktur dan efektif. Teknik ini membantu perawat memahami keluhan utama, riwayat kesehatan, kebiasaan hidup, serta kondisi emosional dan sosial pasien.
2. **Observasi:** Mengamati perilaku pasien, interaksi sosial, serta respons fisik dan emosional terhadap lingkungan dan kondisi kesehatannya.
3. **Pemeriksaan Fisik:** Menggunakan metode inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi untuk menilai status fisik pasien secara sistematis dan menyeluruh.
4. **Penelaahan Rekam Medis:** Mengkaji catatan klinis pasien sebelumnya untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai riwayat kesehatan, diagnosis sebelumnya, pengobatan, serta hasil pemeriksaan diagnostik terdahulu.

Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama dengan detail sebagai berikut:

1. Data Subjektif

Data subjektif merupakan informasi yang bersumber langsung dari pasien atau keluarga pasien berdasarkan persepsi pribadi mereka. Data ini penting untuk memahami pengalaman pasien secara menyeluruh. Data subjektif meliputi:

- a. Keluhan utama pasien seperti nyeri, mual, sesak napas.
- b. Persepsi emosional dan psikologis seperti kecemasan, depresi, rasa takut.
- c. Informasi tentang pola tidur, nafsu makan, serta tingkat energi dan kelelahan.
- d. Deskripsi pasien mengenai gejala yang dirasakan, baik durasi, intensitas, maupun faktor pemicu dan pereda.

2. Data Objektif

Data objektif adalah informasi yang terukur dan dapat diamati secara langsung oleh perawat atau tenaga medis. Data ini penting untuk memastikan validasi dari data subjektif yang diperoleh. Data objektif mencakup:

- a. Tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, denyut jantung, frekuensi napas.
- b. Temuan fisik seperti kondisi kulit, edema, luka, dan perubahan fisik lainnya.
- c. Hasil pemeriksaan laboratorium seperti kadar gula darah, hemoglobin, elektrolit.
- d. Hasil diagnostik seperti gambar radiologi, hasil EKG, hasil ultrasonografi.

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, proses selanjutnya adalah pengorganisasian dan analisis data. Tahap ini melibatkan:

- a. Mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan (misalnya masalah respirasi, sirkulasi, psikologis).
- b. Mengidentifikasi pola atau tren data untuk menemukan hubungan antar data.
- c. Menentukan signifikansi klinis data yang ditemukan, memastikan bahwa data tersebut relevan dengan masalah pasien.
- d. Menggunakan teknik berpikir kritis untuk mengintegrasikan data subjektif dan objektif secara logis.

Tahapan-tahapan ini memastikan bahwa diagnosa keperawatan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi pasien secara holistik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas tindakan dan intervensi keperawatan yang efektif dan efisien.

C. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data dalam keperawatan merupakan tahap kritis yang menentukan ketepatan diagnosa keperawatan. Proses ini terdiri dari beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis dan cermat untuk menghasilkan diagnosa yang akurat.

1. Validasi Data

Validasi data merupakan tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan selama pengkajian adalah akurat, relevan, dan konsisten. Dalam tahap ini, perawat harus:

- a. Mengecek kembali data yang dikumpulkan dengan pasien atau keluarga untuk memastikan ketepatan informasi.
- b. Membandingkan data subjektif dengan data objektif untuk menemukan ketidaksesuaian atau inkonsistensi.
- c. Melakukan konsultasi dengan tim kesehatan lainnya jika ditemukan data yang tidak jelas atau meragukan.
- d. Melakukan klarifikasi dengan pasien tentang informasi yang ambigu atau tidak jelas untuk mendapatkan data yang lebih valid.

2. Interpretasi Data

Setelah data tervalidasi, perawat melakukan interpretasi data untuk memahami arti dan signifikansi klinisnya. Proses interpretasi meliputi:

- a. Menentukan hubungan antar data, seperti korelasi antara tanda vital yang tidak normal dengan keluhan subjektif pasien.
- b. Mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dari data yang terkumpul, misalnya pola penurunan fungsi respirasi, peningkatan kecemasan, atau pola perubahan pola tidur.
- c. Menghubungkan data pasien dengan teori-teori keperawatan, konsep fisiologi, dan patologi untuk memahami kondisi pasien secara mendalam dan komprehensif.
- d. Menyimpulkan implikasi klinis dari data yang telah diinterpretasi untuk menentukan prioritas masalah yang akan ditangani.

3. Pengelompokan Data

Pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan perawat dalam menetapkan masalah utama dan masalah tambahan yang dialami pasien. Langkah ini mencakup:

- a. Mengorganisasi data ke dalam kategori berdasarkan sistem tubuh atau aspek kehidupan pasien, misalnya sistem respirasi, sirkulasi, neurologis, psikologis, sosial, spiritual, dan nutrisi.
- b. Menentukan data mana yang saling terkait dan relevan terhadap suatu masalah atau diagnosa tertentu untuk menciptakan gambaran yang jelas tentang kondisi pasien.
- c. Mengelompokkan data dalam format yang jelas, seperti tabel, diagram, atau bagan, untuk visualisasi yang lebih baik dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

- d. Melakukan analisis data dengan pendekatan berpikir kritis untuk menentukan apakah data yang dikelompokkan tersebut mendukung diagnosa keperawatan tertentu.

Dengan mengikuti langkah-langkah analisis data ini secara sistematis, perawat dapat menentukan diagnosa keperawatan yang akurat dan mencerminkan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Diagnosa yang tepat ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana intervensi keperawatan yang efektif, efisien, dan terarah untuk meningkatkan hasil pelayanan keperawatan.

D. Perumusan Diagnosa Keperawatan

Perumusan diagnosa keperawatan merupakan proses penting yang dilakukan setelah analisis data selesai dilakukan. Diagnosa keperawatan dirumuskan menggunakan standar terminologi NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association-International) yang telah diakui secara internasional. Standar ini mencakup tiga komponen utama yaitu identifikasi label diagnosa, faktor etiologi (penyebab), dan tanda serta gejala yang relevan.

1. Identifikasi Label Diagnosa

Label diagnosa merupakan pernyataan atau judul yang jelas dan spesifik tentang masalah kesehatan atau kondisi pasien berdasarkan data yang telah dikaji. Label diagnosa memberikan gambaran jelas mengenai fokus perawatan yang akan diberikan oleh perawat. Untuk memilih label diagnosa yang tepat, perawat harus secara kritis mengevaluasi semua data yang dikumpulkan dan menentukan mana yang paling relevan terhadap kondisi pasien. Contoh label diagnosa keperawatan meliputi "Risiko Infeksi", "Gangguan Mobilitas Fisik", "Ansietas", dan "Gangguan Pola Tidur".

2. Faktor Etiologi (Penyebab)

Faktor etiologi adalah elemen penting yang menjelaskan alasan atau penyebab munculnya masalah keperawatan. Mengetahui faktor etiologi memungkinkan perawat untuk merancang intervensi spesifik dan efektif. Faktor etiologi dapat bersifat biologis (fisiologis), psikologis, lingkungan, sosial, atau bahkan spiritual. Sebagai contoh, diagnosa "Risiko Infeksi" bisa disebabkan oleh "luka terbuka pada area operasi", sementara "Gangguan Mobilitas Fisik" mungkin terkait dengan "kelemahan otot akibat stroke".

3. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala adalah bukti klinis yang menunjukkan adanya masalah keperawatan. Tanda adalah data objektif yang diamati secara langsung oleh perawat, seperti demam, pembengkakan, atau perubahan tekanan darah. Sebaliknya, gejala adalah data subjektif yang dirasakan pasien dan dilaporkan,

seperti rasa nyeri, kecemasan, mual, atau kelelahan. Penulisan tanda dan gejala harus detil dan spesifik agar mendukung akurasi diagnosa. Misalnya, "Ansietas ditandai dengan pasien menyatakan perasaan takut berlebihan, gelisah, dan sulit berkonsentrasi".

4. Format Perumusan Diagnosa

Diagnosa keperawatan dirumuskan menggunakan format yang baku:

[Label Diagnosa] berhubungan dengan [Faktor Etiologi] dibuktikan oleh [Tanda dan Gejala]

Contoh perumusan diagnosa:

- a. "Gangguan Pola Tidur berhubungan dengan nyeri pasca operasi dibuktikan oleh pasien menyatakan sulit tidur, tampak lesu, dan mengeluh sering terbangun di malam hari."
- b. "Risiko Infeksi berhubungan dengan adanya luka operasi terbuka dibuktikan oleh area operasi kemerahan dan pasien melaporkan rasa tidak nyaman."

Dengan mengikuti struktur perumusan diagnosa ini secara cermat, perawat dapat secara jelas menentukan kondisi pasien dan kebutuhan intervensi yang tepat. Diagnosa keperawatan yang akurat memungkinkan perawat merancang rencana perawatan yang sistematis, efektif, dan efisien, sehingga membantu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan hasil klinis pasien.

E. Hubungan Diagnosa Keperawatan dengan Intervensi

Hubungan antara diagnosa keperawatan dengan intervensi keperawatan merupakan elemen penting dalam proses perencanaan asuhan keperawatan. Setelah diagnosa keperawatan ditetapkan, perawat harus menentukan intervensi spesifik yang sesuai dengan masalah pasien, sehingga intervensi yang dipilih mampu memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut secara efektif dan efisien.

Intervensi keperawatan adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang dirancang berdasarkan diagnosa keperawatan untuk mencapai hasil yang diinginkan bagi pasien. Setiap diagnosa keperawatan harus secara jelas dan logis terhubung dengan intervensi tertentu yang relevan. Pemilihan intervensi didasarkan pada faktor etiologi dan tanda serta gejala yang ditemukan selama proses pengkajian dan analisis data.

Proses Menentukan Intervensi Keperawatan

Proses menentukan intervensi keperawatan mencakup beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Mengidentifikasi Tujuan Intervensi Tujuan intervensi harus spesifik, terukur, tercapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Tujuan yang jelas ini membantu perawat dalam mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan terhadap hasil yang diinginkan.
2. Memilih Intervensi Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice) Pemilihan intervensi harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaru, rekomendasi dari penelitian terkini, serta panduan praktik klinis yang telah teruji. Hal ini memastikan intervensi yang dipilih benar-benar efektif dan aman dalam mengatasi masalah pasien.
3. Menyesuaikan Intervensi dengan Kondisi Pasien Setiap pasien memiliki kondisi unik dan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, perawat harus mempertimbangkan faktor individual seperti usia, tingkat keparahan penyakit, riwayat kesehatan sebelumnya, preferensi pasien, serta kondisi psikososial dan budaya yang dimiliki oleh pasien.
4. Mendokumentasikan Rencana Intervensi Setelah intervensi dipilih, perawat harus mendokumentasikan rencana asuhan secara jelas dan rinci. Dokumentasi ini penting agar semua anggota tim kesehatan memiliki pemahaman yang sama mengenai tindakan yang akan dilaksanakan dan dapat berkoordinasi secara efektif dalam memberikan perawatan.

Contoh Hubungan Diagnosa dan Intervensi Keperawatan

- 1. Diagnosa: Gangguan Pola Tidur berhubungan dengan nyeri pasca operasi.**
 - a. Mengatur lingkungan tidur pasien agar tenang, nyaman, dan minim gangguan.
 - b. Mengajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan meditasi untuk membantu pasien mengelola nyeri.
 - c. Memberikan obat analgesik sesuai indikasi medis dengan pemantauan ketat terhadap efek samping.
- 2. Diagnosa: Risiko Infeksi berhubungan dengan luka operasi terbuka.**
 - a. Melakukan perawatan luka menggunakan teknik aseptik sesuai standar protokol klinik.
 - b. Memantau tanda-tanda awal infeksi seperti kemerahan, bengkak, atau keluarnya cairan dari luka.
 - c. Mengedukasi pasien dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kebersihan luka dan mengenali tanda-tanda infeksi dini.
- 3. Diagnosa: Ansietas berhubungan dengan prosedur medis yang akan dilakukan.**
 - a. Memberikan penjelasan yang jelas, rinci, dan mudah dipahami tentang prosedur medis yang akan dilaksanakan.

- b. Menggunakan komunikasi terapeutik secara aktif dan empati untuk menenangkan pasien.
- c. Mengajarkan pasien metode relaksasi seperti teknik pernapasan dalam, guided imagery, atau meditasi ringan untuk mengurangi kecemasan.

Dengan memahami secara mendalam hubungan antara diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan, perawat dapat menyusun dan melaksanakan rencana perawatan yang terstruktur, sistematis, efektif, dan mampu menghasilkan hasil kesehatan pasien yang optimal.

F. Latihan Soal

1. Seorang pasien wanita, 45 tahun, dirawat di ruang bedah pasca operasi apendiktomi. Pasien mengeluh nyeri hebat di area luka operasi, sulit tidur, tampak lesu, dan sering terbangun malam hari. Hasil pemeriksaan menunjukkan luka operasi tertutup baik tanpa tanda infeksi.

Apa diagnosa keperawatan utama yang tepat pada pasien tersebut?

- A. Risiko infeksi
- B. Gangguan pola tidur
- C. Defisit perawatan diri
- D. Gangguan mobilitas fisik
- E. Kesiapan peningkatan pola tidur

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Keluhan pasien mengenai sulit tidur, lesu, dan sering terbangun malam hari, yang berhubungan langsung dengan nyeri pasca operasi menunjukkan pasien mengalami "Gangguan Pola Tidur".

2. Pasien laki-laki, 70 tahun, dibawa ke rumah sakit dengan riwayat hipertensi dan stroke ringan. Saat ini, pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan, tampak kesulitan berjalan, namun belum pernah mengalami jatuh.

Apa diagnosa keperawatan yang paling sesuai untuk kondisi pasien ini?

- A. Gangguan mobilitas fisik
- B. Risiko jatuh
- C. Defisit nutrisi
- D. Risiko infeksi
- E. Gangguan eliminasi urin

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasien memiliki kelemahan ekstremitas kanan pasca stroke ringan yang meningkatkan risiko jatuh, walaupun belum pernah terjadi jatuh sebelumnya.

3. Seorang pasien perempuan, 30 tahun, mengeluhkan rasa takut berlebihan karena akan menjalani operasi caesar keesokan hari. Pasien tampak gelisah, sulit berkonsentrasi, dan terus bertanya tentang risiko operasi.

Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah?

- A. A. Risiko infeksi
- B. B. Ansietas
- C. C. Gangguan pola tidur
- D. D. Risiko cedera
- E. E. Gangguan mobilitas fisik

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasien menunjukkan tanda dan gejala kecemasan tinggi, ketakutan berlebihan, sulit berkonsentrasi, serta tampak gelisah, sesuai dengan diagnosa keperawatan "Ansietas".

4. Seorang lansia berusia 75 tahun datang dengan keluhan sesak napas, sering terbangun malam hari karena kesulitan bernapas, dan tampak cemas saat bernapas. Hasil pemeriksaan menunjukkan tanda vital: TD 150/90 mmHg, frekuensi napas 28 kali/menit.

Data subjektif yang diperoleh dalam kasus ini adalah?

- A. Tekanan darah 150/90 mmHg
- B. Frekuensi napas 28 kali/menit
- C. Keluhan sesak napas dan cemas
- D. Tampak cemas saat bernapas
- E. Kesulitan tidur malam hari

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Data subjektif merupakan data yang diperoleh langsung dari pasien berupa keluhan atau perasaan pasien. Dalam kasus ini, keluhan sesak napas dan perasaan cemas merupakan data subjektif yang dikemukakan pasien.

5. Seorang pria, 60 tahun, dirawat dengan diabetes mellitus dan luka terbuka pada kaki kanan. Luka terlihat kemerahan di sekitar area dan pasien mengeluh rasa tidak nyaman. Belum ditemukan tanda infeksi yang jelas.

Diagnosa keperawatan yang paling tepat dalam kasus ini adalah?

- A. Gangguan mobilitas fisik
- B. Risiko infeksi
- C. Nyeri kronis
- D. Gangguan integritas kulit

E. Risiko cedera

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Meskipun belum ditemukan tanda infeksi jelas, pasien memiliki luka terbuka yang meningkatkan potensi atau risiko infeksi. Maka diagnosa keperawatan yang tepat adalah "Risiko Infeksi".

G. Rangkuman Materi

Masalah keperawatan adalah kondisi yang membutuhkan intervensi perawat, ditentukan melalui pengkajian lengkap terhadap pasien. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinis yang mencerminkan respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah atau potensi masalah kesehatan. Berbeda dengan diagnosa medis yang fokus pada kondisi patologis, diagnosa keperawatan memandang pasien secara holistik, mencakup respons terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Proses identifikasi masalah keperawatan dilakukan secara teliti melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan telaah rekam medis untuk mengumpulkan data subjektif dan objektif. Data subjektif adalah informasi berdasarkan persepsi pasien seperti nyeri, kecemasan, dan pola tidur, sedangkan data objektif adalah hasil observasi langsung seperti tanda vital, hasil pemeriksaan fisik, dan laboratorium.

Analisis data yang cermat sangat penting dalam menentukan diagnosa keperawatan. Tahapan analisis meliputi validasi data untuk memastikan keakuratan informasi, interpretasi untuk memahami signifikansi klinis data, serta pengelompokan data untuk memudahkan identifikasi masalah utama dan tambahan. Proses ini mendukung terciptanya diagnosa yang mencerminkan kondisi pasien secara komprehensif.

Dalam perumusan diagnosa keperawatan, digunakan terminologi standar internasional dari NANDA-I yang terdiri dari tiga komponen utama: label diagnosa yang menggambarkan masalah secara spesifik, faktor etiologi sebagai penyebab masalah, serta tanda dan gejala yang mendukung diagnosa tersebut. Format baku perumusan diagnosa adalah menghubungkan ketiga komponen ini secara jelas.

Diagnosa keperawatan secara langsung berkaitan dengan intervensi yang akan dilakukan. Intervensi merupakan tindakan spesifik yang dirancang berdasarkan diagnosa yang telah ditentukan. Pemilihan intervensi dilakukan melalui identifikasi tujuan yang spesifik dan terukur, penggunaan intervensi berbasis bukti ilmiah, penyesuaian terhadap kondisi unik pasien, dan dokumentasi rencana intervensi secara jelas untuk koordinasi tim yang efektif. Dengan mengikuti pendekatan ini,

perawat mampu menyediakan asuhan keperawatan yang tepat, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan pasien.

H. Glosarium

Diagnosa Keperawatan: Keputusan klinis tentang respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau potensi masalah kesehatan, digunakan sebagai dasar penentuan intervensi keperawatan.

Masalah Keperawatan: Kondisi yang memerlukan tindakan atau intervensi keperawatan yang diidentifikasi berdasarkan hasil pengkajian.

Diagnosa Aktual: Kondisi nyata yang sudah dialami pasien, disertai tanda-tanda dan gejala yang jelas dan memerlukan intervensi segera.

Diagnosa Risiko: Kondisi yang memiliki potensi besar untuk muncul jika tidak ada intervensi preventif yang tepat, diidentifikasi berdasarkan faktor predisposisi tertentu.

Diagnosa Promosi Kesehatan: Diagnosa yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan kondisi kesehatan optimal pasien, keluarga, atau komunitas melalui upaya edukatif dan preventif.

Data Subjektif: Informasi yang berasal langsung dari pasien atau keluarga berdasarkan persepsi dan pengalaman pribadi, termasuk keluhan utama, perasaan, serta gejala yang dirasakan.

Data Objektif: Informasi yang dapat diamati dan diukur secara langsung oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan fisik, tanda vital, dan hasil pemeriksaan diagnostik atau laboratorium.

Validasi Data: Proses pengecekan dan konfirmasi informasi yang dikumpulkan selama pengkajian untuk memastikan akurasi dan relevansi data.

Interpretasi Data: Tahap analisis yang bertujuan untuk memahami signifikansi klinis dari data yang terkumpul dan menentukan hubungan antar data untuk penentuan prioritas masalah.

Pengelompokan Data: Proses pengorganisasian data berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan identifikasi masalah utama dan tambahan.

NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association-International): Organisasi yang mengembangkan terminologi standar internasional untuk diagnosa keperawatan.

Faktor Etiologi: Penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah keperawatan.

Tanda dan Gejala: Bukti klinis berupa data objektif dan subjektif yang mendukung adanya diagnosa keperawatan tertentu.

Intervensi Keperawatan: Tindakan atau serangkaian tindakan yang dirancang berdasarkan diagnosa keperawatan untuk mencapai hasil kesehatan yang diinginkan.

Tujuan Intervensi SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound): Prinsip penyusunan tujuan intervensi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu.

Evidence-Based Practice: Pemilihan intervensi keperawatan berdasarkan bukti ilmiah terkini dan panduan praktik klinis teruji.

Komunikasi Terapeutik: Teknik komunikasi yang bertujuan untuk mendukung dan menenangkan pasien serta meningkatkan hubungan perawat-pasien.

Teknik Relaksasi: Metode seperti pernapasan dalam, meditasi, atau guided imagery yang digunakan untuk mengurangi stres atau kecemasan pasien.

I. Daftar Pustaka

- Carpenito, L. J. (2019). *Handbook of Nursing Diagnosis* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Herdman, T. H., Kamitsuru, S., & Lopes, C. T. (Eds.). (2021). *NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 2021-2023* (12th ed.). Thieme Publishers.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2018). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Care* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Wilkinson, J. M., Treas, L. S., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2019). *Fundamentals of Nursing: Theory, Concepts, & Applications* (4th ed.). F.A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of Nursing: Active Learning for Collaborative Practice* (2nd ed.). Elsevier.

BAB 4

PERBANDINGAN METODE ILMIAH DAN PROSES KEPERAWATAN SEBAGAI METODE PENYELESAIAN MASALAH

Pendahuluan

Metode ilmiah dan proses keperawatan merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Dalam praktik keperawatan, proses keperawatan menjadi landasan utama dalam memberikan asuhan yang efektif dan efisien kepada pasien. Sementara metode ilmiah lebih umum digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan bukti ilmiah yang dapat mendukung praktik klinis. Memahami perbandingan keduanya akan memberikan wawasan kepada perawat tentang penerapan prinsip ilmiah dalam praktik klinis secara optimal, serta bagaimana mengintegrasikan pendekatan ilmiah ke dalam tahapan proses keperawatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari materi ini, lulusan mampu menerapkan metode ilmiah dan proses keperawatan dalam menyelesaikan berbagai masalah keperawatan secara komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu membandingkan dan mengintegrasikan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai pendekatan penyelesaian masalah dalam praktik klinis.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar metode ilmiah dan proses keperawatan.
- Membandingkan langkah-langkah metode ilmiah dengan proses keperawatan dalam konteks praktik klinis.

- Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan metode ilmiah dan proses keperawatan dalam penyelesaian masalah.
- Mengintegrasikan metode ilmiah ke dalam tahapan proses keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan

Metode ilmiah merupakan pendekatan sistematis, objektif, dan kritis dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut meliputi observasi, formulasi hipotesis, eksperimen, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang memiliki validitas tinggi, reliabel, serta berbasis bukti, sehingga hasilnya dapat diaplikasikan secara luas dalam praktik klinis keperawatan.

Tahap pertama dari metode ilmiah adalah observasi. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengamatan mendalam terhadap fenomena atau situasi tertentu untuk memahami permasalahan secara jelas dan komprehensif. Observasi dilakukan dengan teliti dan objektif untuk mengumpulkan data awal yang menjadi dasar dalam menyusun langkah selanjutnya.

Setelah observasi, tahap berikutnya adalah formulasi hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi sementara yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel yang diamati. Hipotesis harus jelas, spesifik, dan dapat diuji secara empiris. Penentuan hipotesis ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan eksperimen atau penelitian.

Tahap eksperimen atau penelitian dilakukan untuk menguji validitas hipotesis yang telah diformulasikan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dengan metode yang sistematis, baik melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik atau analisis tematik untuk mendapatkan hasil yang objektif dan akurat.

Analisis data merupakan tahap kritis berikutnya dalam metode ilmiah. Data yang telah dikumpulkan dievaluasi secara menyeluruh menggunakan teknik analisis yang sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Hasil analisis data ini digunakan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak.

Tahap akhir dari metode ilmiah adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan analisis data yang dilakukan, yang kemudian dapat menghasilkan temuan baru atau memperkuat teori yang sudah ada. Kesimpulan ini juga digunakan sebagai dasar dalam pengembangan rekomendasi atau implementasi praktik berbasis bukti dalam keperawatan.

Dalam konteks keperawatan, metode ilmiah memainkan peran penting dalam pengembangan *evidence-based practice* (EBP). Melalui penelitian yang menggunakan metode ilmiah, perawat dapat memperoleh bukti ilmiah yang

membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih efektif, tepat, dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Di sisi lain, proses keperawatan merupakan metode yang spesifik dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah kesehatan secara langsung dalam praktik klinis. Proses ini terdiri atas lima tahapan utama, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi intervensi, dan evaluasi.

Tahap pengkajian adalah langkah awal dalam proses keperawatan, di mana perawat mengumpulkan data yang komprehensif tentang kondisi pasien, baik data subjektif (misalnya keluhan, riwayat kesehatan) maupun data objektif (hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium). Informasi yang dikumpulkan ini menjadi dasar dalam menetapkan diagnosa keperawatan.

Diagnosa keperawatan merupakan identifikasi masalah kesehatan aktual atau potensial yang dihadapi pasien. Diagnosa ini ditetapkan berdasarkan analisis yang sistematis terhadap data pengkajian, sehingga memungkinkan perawat untuk merencanakan intervensi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pada tahap perencanaan, perawat menyusun rencana intervensi yang jelas dan spesifik, termasuk tujuan yang ingin dicapai dan tindakan-tindakan keperawatan yang harus dilakukan. Rencana ini menjadi pedoman yang terukur dalam pelaksanaan intervensi.

Implementasi merupakan tahap di mana intervensi yang direncanakan diterapkan secara langsung kepada pasien. Tindakan ini dilakukan dengan memperhatikan standar keperawatan dan kondisi pasien yang dinamis.

Evaluasi adalah tahap terakhir dalam proses keperawatan. Di sini, perawat menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan. Evaluasi ini menentukan apakah tujuan keperawatan tercapai atau jika diperlukan modifikasi rencana untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pasien.

Proses keperawatan memiliki sifat siklik dan adaptif, memungkinkan perawat untuk kembali ke tahap sebelumnya jika terjadi perubahan kondisi pasien. Fleksibilitas dan kemampuan proses ini dalam menyentuh langsung kebutuhan individu pasien membuatnya sangat penting dalam praktik keperawatan klinis.

Dengan memahami secara mendalam konsep dasar dari metode ilmiah dan proses keperawatan, perawat dapat mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara efektif dalam praktik sehari-hari, sehingga mampu memberikan asuhan keperawatan yang optimal, holistik, dan berbasis bukti ilmiah demi peningkatan kualitas hidup pasien.

B. Perbandingan Langkah-langkah Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan

Metode ilmiah dan proses keperawatan merupakan dua pendekatan yang umum digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah, khususnya dalam penelitian dan praktik klinis keperawatan. Meski kedua metode ini memiliki langkah-langkah sistematis yang jelas dan terstruktur, terdapat sejumlah perbedaan signifikan yang memengaruhi cara penerapannya dalam praktik sehari-hari. Penjelasan berikut memberikan perbandingan detail mengenai tahapan masing-masing metode secara lebih mendalam.

1. Metode Ilmiah

Metode ilmiah terdiri dari enam langkah utama yang mencerminkan proses berpikir logis, kritis, dan sistematis:

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal di mana peneliti menentukan secara jelas dan spesifik permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan dengan pengamatan fenomena atau kejadian tertentu yang menarik perhatian atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Masalah yang dipilih harus relevan dan signifikan dalam konteks penelitian, serta mampu menghasilkan kontribusi ilmiah yang berguna.

b. Pengumpulan Data

Langkah ini melibatkan pengumpulan informasi secara sistematis, akurat, dan objektif. Peneliti dapat menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi langsung, wawancara mendalam, survei dengan kuesioner, atau analisis dokumen. Kualitas data yang dikumpulkan sangat penting untuk mendukung validitas hasil penelitian.

c. Formulasi Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang diamati. Hipotesis harus jelas, spesifik, terukur, dan dapat diuji melalui proses penelitian atau eksperimen. Formulasi hipotesis berfungsi sebagai panduan dalam desain penelitian, membantu peneliti memfokuskan upaya eksperimen dan analisisnya.

d. Pengujian Hipotesis melalui Eksperimen

Pengujian hipotesis dilakukan melalui eksperimen atau penelitian yang terstruktur dan terkontrol. Eksperimen ini bertujuan menguji apakah hipotesis tersebut benar atau salah, dengan cara mengumpulkan data secara sistematis dalam kondisi yang terkendali dan dapat direplikasi.

e. Analisis Hasil

Tahap ini mencakup analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan selama eksperimen. Metode analisis bisa berupa statistik deskriptif dan inferensial atau analisis kualitatif tematik. Tujuannya adalah menentukan apakah data yang diperoleh mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan.

f. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir di mana peneliti menarik interpretasi berdasarkan hasil analisis data. Tahap ini menentukan validitas hipotesis, menghasilkan kesimpulan yang bisa digeneralisasikan, serta menghasilkan temuan baru yang dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Proses Keperawatan

Proses keperawatan merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan dalam praktik klinis untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien secara individual:

a. Pengkajian

Tahap pengkajian dilakukan dengan mengumpulkan data pasien secara lengkap dan mendalam. Data ini meliputi aspek subjektif, seperti keluhan, perasaan, dan riwayat kesehatan pasien, serta aspek objektif berupa hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, dan penunjang diagnostik lainnya. Pengkajian ini menjadi dasar untuk menetapkan langkah selanjutnya.

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah tahap di mana perawat melakukan analisis terhadap data pengkajian untuk mengidentifikasi masalah kesehatan aktual atau potensial yang dialami pasien. Diagnosa ini bersifat spesifik dan terfokus pada respons pasien terhadap kondisi kesehatan atau penyakitnya, berbeda dari diagnosa medis yang menekankan aspek patologi.

c. Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi merupakan tahap penyusunan rencana tindakan yang spesifik, jelas, dan terukur. Intervensi ini didasarkan pada diagnosa keperawatan yang telah dirumuskan, dengan tujuan mencapai hasil tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan ini juga mencakup waktu, metode pelaksanaan, serta evaluasi keberhasilan intervensi tersebut.

d. Implementasi Intervensi

Implementasi adalah tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Dalam tahap ini, perawat melakukan intervensi keperawatan secara langsung terhadap pasien dengan memperhatikan standar praktik keperawatan.

Pelaksanaan ini harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi pasien yang mungkin terjadi selama perawatan.

e. Evaluasi Hasil

Tahap terakhir adalah evaluasi hasil intervensi yang telah dilakukan. Perawat menilai sejauh mana intervensi telah mencapai tujuan yang diinginkan, mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan, serta menentukan apakah perlu dilakukan modifikasi lebih lanjut untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Kesamaan Antara Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan

Metode ilmiah dan proses keperawatan memiliki beberapa kesamaan penting yang mendasari efektivitas keduanya dalam menyelesaikan berbagai jenis masalah, terutama di bidang keperawatan. Kesamaan ini terutama terletak pada tahapan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan objektif.

a. Pengumpulan Data

Baik metode ilmiah maupun proses keperawatan sama-sama mengharuskan adanya pengumpulan informasi yang sistematis dan komprehensif. Dalam kedua pendekatan ini, tahap pengumpulan data memegang peranan penting untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil yang diperoleh. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, survei atau kuesioner, analisis rekam medis, dan berbagai teknik lainnya yang sesuai dengan tujuan masing-masing metode. Ketelitian, kecermatan, serta keterampilan observasi yang tinggi diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar mewakili situasi atau fenomena yang diteliti atau diobservasi.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial lainnya yang menjadi titik kesamaan kedua metode ini. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur, mendalam, kritis, dan objektif. Tujuan analisis ini adalah mengolah informasi secara menyeluruh untuk memperoleh kesimpulan yang valid, reliabel, dan akurat. Metode analisis yang digunakan bisa mencakup teknik statistik atau analisis kualitatif, bergantung pada sifat data yang dikumpulkan. Analisis yang dilakukan menentukan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil, baik dalam konteks penelitian ilmiah maupun intervensi klinis keperawatan.

4. Perbedaan Antara Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan

Di samping kesamaan tersebut, terdapat pula beberapa perbedaan mendasar antara metode ilmiah dan proses keperawatan yang memengaruhi implementasi dan tujuannya.

a. Fokus Utama

- 1) Metode Ilmiah: Menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan tujuan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diterapkan secara luas dan umum. Fokus utama metode ini adalah teoritis, ilmiah, dan berorientasi pada pengembangan atau penyempurnaan teori.
- 2) Proses Keperawatan: Berfokus pada pemecahan masalah klinis pasien secara langsung **dan** individual. Orientasinya lebih praktis, aplikatif, dan spesifik sesuai kebutuhan pasien dalam situasi klinis nyata.

b. Tujuan Akhir

- 1) Metode Ilmiah: Bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan teori baru, atau memperkuat teori yang ada melalui penelitian ilmiah yang ketat. Hasil penelitian ilmiah memiliki sifat yang dapat digeneralisasi dan diterapkan dalam berbagai konteks.
- 2) Proses Keperawatan: Bertujuan untuk mencapai hasil klinis spesifik pada pasien, seperti perbaikan kondisi kesehatan, peningkatan kualitas hidup, atau penyelesaian masalah kesehatan tertentu. Hasil dari proses ini bersifat langsung dan nyata, terbatas pada kasus individual atau kelompok pasien tertentu.

c. Fleksibilitas dan Adaptasi

- 1) Metode Ilmiah: Memiliki struktur yang lebih ketat dengan kontrol yang tinggi terhadap variabel penelitian. Kondisi penelitian dikendalikan secara ketat untuk memastikan validitas data, namun hal ini menyebabkan kurangnya fleksibilitas terhadap perubahan yang tidak terduga.
- 2) Proses Keperawatan: Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi pasien selama proses perawatan berlangsung. Perawat dapat langsung menyesuaikan rencana intervensi berdasarkan respon atau perubahan klinis pasien.

d. Lingkup Penerapan

- 1) **Metode Ilmiah**: Diterapkan dalam konteks penelitian akademis atau ilmiah dengan tujuan menghasilkan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara umum untuk keperawatan secara luas.
- 2) **Proses Keperawatan**: Diterapkan secara langsung dalam praktik klinis sehari-hari, dengan orientasi yang spesifik pada pemecahan masalah kesehatan individual pasien secara nyata.

C. Integrasi Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan

Integrasi antara metode ilmiah dan proses keperawatan adalah aspek penting dalam pengembangan keperawatan berbasis bukti (Evidence-Based Practice).

Dengan integrasi ini, praktik keperawatan dapat didukung oleh pengetahuan ilmiah terbaru yang telah diuji validitasnya secara empiris. Perawat tidak hanya menyelesaikan masalah klinis pasien secara efektif, namun juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan secara keseluruhan. Integrasi ini memungkinkan perawat mengambil keputusan klinis yang didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan keperawatan.

D. Kelebihan dan Kekurangan Kedua Metode

Metode ilmiah dan proses keperawatan merupakan dua pendekatan esensial dalam praktik dan penelitian keperawatan, masing-masing menawarkan kelebihan dan menghadapi berbagai tantangan atau kekurangan. Memahami secara mendalam kelebihan dan kekurangan keduanya penting agar perawat dapat secara efektif mengaplikasikan metode yang paling tepat dalam konteks masing-masing kasus.

1. Kelebihan Metode Ilmiah

a. Validitas dan Reliabilitas Tinggi

Metode ilmiah menjamin validitas dan reliabilitas hasil karena mengikuti prosedur penelitian yang sistematis, terstruktur, dan sangat terkontrol. Pengontrolan ketat variabel dalam penelitian memastikan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar mencerminkan fenomena yang sedang diteliti dan bukan disebabkan oleh faktor lain yang tidak diinginkan.

b. Kemampuan Generalisasi

Hasil penelitian ilmiah memiliki potensi tinggi untuk digeneralisasi ke berbagai situasi atau kondisi serupa. Ini membuat metode ilmiah sangat berguna dalam menghasilkan pengetahuan baru yang bersifat umum dan dapat diterapkan secara luas di bidang keperawatan, mendukung pengembangan praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice).

c. Objektivitas

Metode ilmiah menekankan pentingnya objektivitas, dengan pendekatan kritis yang mengurangi bias dari peneliti. Objektivitas ini membantu menghasilkan kesimpulan yang lebih dapat dipercaya dan konsisten, bebas dari pengaruh subjektivitas atau bias pribadi peneliti.

2. Kekurangan Metode Ilmiah

a. Membutuhkan Waktu Lama

Penelitian dengan metode ilmiah seringkali membutuhkan waktu yang relatif panjang, mulai dari tahap desain penelitian, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan. Hal ini bisa menjadi kendala signifikan dalam situasi yang memerlukan hasil cepat dan segera.

b. Biaya yang Besar

Pelaksanaan penelitian ilmiah biasanya melibatkan biaya yang tinggi. Biaya ini mencakup alat-alat khusus, sumber daya manusia yang terlatih, serta operasional penelitian yang kompleks. Tingginya biaya ini bisa menjadi hambatan dalam menjalankan penelitian secara reguler atau berskala besar.

c. Kondisi Sangat Terkendali

Metode ilmiah memerlukan kondisi yang sangat terkendali dan ideal. Hal ini terkadang sulit diterapkan dalam kondisi klinis nyata yang penuh variabel dan perubahan dinamis, sehingga hasil penelitian mungkin kurang relevan untuk situasi klinis yang kompleks dan alami.

3. Kelebihan Proses Keperawatan

a. Aplikatif dan Praktis

Proses keperawatan berorientasi pada solusi yang langsung aplikatif di lingkungan klinis. Langkah-langkahnya praktis, dengan fokus nyata pada peningkatan kondisi kesehatan pasien. Hal ini menjadikan proses keperawatan sangat relevan dan berguna dalam praktik klinis harian.

b. Fleksibel dan Adaptif

Kelebihan lain proses keperawatan adalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Proses ini memungkinkan perawat untuk segera menyesuaikan intervensi berdasarkan perubahan kondisi pasien. Hal ini penting dalam menghadapi situasi klinis yang seringkali dinamis dan tidak dapat diprediksi.

c. Relevan dengan Situasi Klinis

Proses keperawatan memiliki relevansi langsung terhadap kebutuhan dan kondisi klinis pasien, menjadikannya efektif dalam mencapai tujuan keperawatan seperti perbaikan kondisi pasien atau peningkatan kualitas hidup.

4. Kekurangan Proses Keperawatan

a. Subjektivitas Tinggi

Proses keperawatan sangat tergantung pada kemampuan individual perawat. Kemampuan klinis yang bervariasi antar perawat dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan proses, yang berpotensi mempengaruhi hasil perawatan.

b. Sulit Digeneralisasi

Intervensi yang diberikan melalui proses keperawatan biasanya disesuaikan secara spesifik untuk pasien individu, sehingga hasilnya sulit digeneralisasi ke situasi atau pasien lain. Hal ini membatasi penerapan hasil secara lebih luas.

c. Keterbatasan dalam Validitas

Pendekatan yang subjektif dan personal dalam proses keperawatan berpotensi mengurangi validitas dan reliabilitas hasil, terutama jika dibandingkan dengan metode ilmiah yang sangat terkontrol.

E. Integrasi Kedua Metode

Mengintegrasikan metode ilmiah dengan proses keperawatan memberikan manfaat besar dalam praktik keperawatan modern. Integrasi ini memungkinkan perawat menggunakan bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung tindakan klinis mereka, sambil tetap mempertahankan relevansi dan fleksibilitas intervensi klinis dalam merespons kebutuhan pasien yang dinamis. Dengan demikian, integrasi ini memastikan pelayanan keperawatan tidak hanya efektif tetapi juga berbasis bukti ilmiah yang kuat, sehingga meningkatkan kualitas keseluruhan pelayanan yang diberikan kepada pasien.

F. Integrasi Metode Ilmiah ke dalam Proses Keperawatan

Integrasi metode ilmiah ke dalam proses keperawatan merupakan pendekatan penting dalam praktik keperawatan modern yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP). Pendekatan ini menggabungkan keahlian klinis perawat dengan hasil penelitian ilmiah terbaru untuk menghasilkan intervensi keperawatan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Tahapan Integrasi Metode Ilmiah dalam Proses Keperawatan

Integrasi metode ilmiah ke dalam proses keperawatan dapat dilakukan pada setiap tahap dalam proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi intervensi, dan evaluasi hasil. Berikut penjelasan lebih rinci setiap tahapan:

a. Pengkajian

Dalam tahap pengkajian, integrasi metode ilmiah dilakukan dengan memanfaatkan data hasil penelitian terbaru yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Perawat melakukan pengumpulan data secara sistematis menggunakan informasi terbaru untuk memperkuat akurasi data yang diperoleh. Misalnya, perawat dapat menggunakan studi terkini tentang tanda-tanda vital tertentu yang spesifik untuk kondisi klinis tertentu, sehingga data pengkajian yang didapatkan lebih akurat, komprehensif, dan relevan dengan kondisi pasien.

b. Diagnosa Keperawatan

Integrasi metode ilmiah dalam tahap diagnosa keperawatan membantu perawat menentukan diagnosa secara lebih akurat dan berbasis bukti. Dengan memanfaatkan hasil penelitian terkini, perawat dapat merumuskan diagnosa dengan presisi tinggi serta mengurangi kemungkinan kesalahan klinis akibat bias subyektif. Diagnosa keperawatan yang didukung oleh penelitian ilmiah meningkatkan kepercayaan terhadap keputusan klinis yang diambil.

c. Perencanaan Intervensi

Pada tahap perencanaan intervensi, integrasi hasil penelitian ilmiah memungkinkan perawat untuk merancang tindakan keperawatan yang efektif dan berbasis bukti. Perawat merujuk pada hasil penelitian yang telah terbukti efektif dalam situasi yang sama atau serupa. Dengan demikian, intervensi yang direncanakan tidak hanya berbasis pengalaman individu perawat, tetapi didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Hal ini meningkatkan potensi keberhasilan intervensi yang diberikan.

d. Implementasi Intervensi

Integrasi metode ilmiah dalam tahap implementasi memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perawat didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Dalam tahap ini, perawat menerapkan intervensi yang telah teruji secara ilmiah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dengan menggunakan tindakan yang didukung oleh penelitian, perawat dapat memperkuat praktik keperawatan berbasis bukti di lingkungan klinis.

e. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, integrasi metode ilmiah dilakukan dengan menggunakan indikator keberhasilan yang telah terbukti secara ilmiah. Perawat mengevaluasi efektivitas intervensi berdasarkan data penelitian ilmiah yang jelas dan terukur. Evaluasi yang berbasis bukti ilmiah memungkinkan perawat menilai apakah tujuan intervensi telah tercapai atau apakah diperlukan modifikasi lebih lanjut untuk mencapai hasil klinis yang optimal.

2. Manfaat Integrasi Metode Ilmiah dalam Proses Keperawatan

Integrasi metode ilmiah ke dalam proses keperawatan memberikan berbagai manfaat penting, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan: Memastikan setiap tindakan keperawatan berbasis pada bukti ilmiah terkini sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Reduksi Kesalahan Klinis: Membantu mengurangi risiko kesalahan dalam diagnosa dan intervensi karena keputusan yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang valid.

- c. Pengembangan Praktik Keperawatan Berbasis Bukti: Mendorong budaya belajar dan berkembang secara kontinu dalam praktik klinis dengan menggunakan hasil penelitian ilmiah terbaru.
- d. Peningkatan Hasil Klinis Pasien: Terbukti secara ilmiah bahwa intervensi berbasis bukti meningkatkan hasil klinis pasien secara signifikan.

3. Tantangan dalam Integrasi Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan

Meski memiliki banyak manfaat, integrasi metode ilmiah ke dalam proses keperawatan juga menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi, di antaranya:

- a. Keterbatasan Akses terhadap Penelitian Terbaru: Tidak semua perawat memiliki kemudahan dalam mengakses hasil penelitian terkini, terutama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas.
- b. Keterampilan Interpretasi Hasil Penelitian: Perawat membutuhkan keterampilan khusus dalam membaca, memahami, dan menerapkan hasil penelitian ilmiah agar efektif dalam praktik klinis.
- c. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya: Proses integrasi seringkali membutuhkan tambahan waktu dan sumber daya yang mungkin terbatas di banyak lingkungan praktik klinis.

4. Strategi Mengatasi Tantangan Integrasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi berikut:

- a. Pelatihan dan Edukasi Berkelanjutan: Pelaksanaan pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam memahami dan mengaplikasikan hasil penelitian.
- b. Membangun Budaya Kolaborasi: Meningkatkan kolaborasi antar perawat, peneliti, dan institusi pendidikan untuk mempermudah akses informasi ilmiah.
- c. Optimalisasi Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan akses cepat terhadap jurnal dan hasil penelitian terbaru yang relevan.

G. Latihan Soal

1. Seorang perawat di unit perawatan intensif ingin mengetahui penyebab peningkatan infeksi pada pasien pasca operasi. Ia memutuskan melakukan observasi sistematis dan mencatat setiap prosedur perawatan luka yang dilakukan.

Langkah dalam metode ilmiah yang sedang dilakukan perawat tersebut adalah:

- A. Formulasi hipotesis
- B. Pengumpulan data
- C. Pengujian hipotesis

- D. Analisis hasil
- E. Penarikan kesimpulan

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Tahap awal dalam metode ilmiah setelah identifikasi masalah adalah pengumpulan data, yaitu proses observasi yang sistematis dan objektif terhadap fenomena yang terjadi.

2. Setelah melakukan pengkajian terhadap seorang pasien dengan diabetes mellitus, perawat menyusun diagnosa keperawatan berdasarkan hasil pemeriksaan kadar gula darah, keluhan pasien, dan hasil pemeriksaan fisik lainnya.

Langkah dalam proses keperawatan yang dilakukan perawat adalah:

- A. Pengkajian
- B. Diagnosa keperawatan
- C. Perencanaan intervensi
- D. Implementasi intervensi
- E. Evaluasi hasil

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Diagnosa keperawatan merupakan tahap analisis terhadap data pengkajian untuk mengidentifikasi masalah aktual atau potensial pasien berdasarkan informasi objektif dan subjektif yang dikumpulkan.

3. Seorang peneliti melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas intervensi edukasi terhadap peningkatan pengetahuan pasien hipertensi mengenai pola hidup sehat.

Tahapan metode ilmiah yang sedang dilaksanakan peneliti tersebut adalah:

- A. Identifikasi masalah
- B. Formulasi hipotesis
- C. Pengujian hipotesis melalui eksperimen
- D. Analisis hasil
- E. Penarikan kesimpulan

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Tahapan ini merupakan pengujian hipotesis melalui eksperimen, yang bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis tentang intervensi edukasi tersebut efektif atau tidak.

4. Seorang perawat mengevaluasi hasil intervensi keperawatan pada pasien stroke dengan melihat perkembangan kemampuan motorik pasien setelah intervensi fisioterapi selama dua minggu.

Langkah dalam proses keperawatan yang dilakukan oleh perawat adalah:

- A. Pengkajian
- B. Diagnosa keperawatan
- C. Perencanaan intervensi
- D. Implementasi intervensi
- E. Evaluasi hasil

Kunci Jawaban: E

Pembahasan: Evaluasi adalah tahap akhir dalam proses keperawatan, di mana perawat menilai efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai sesuai tujuan perawatan.

5. Seorang perawat melakukan penelitian terkait hubungan antara tingkat stres kerja dengan performa perawat di ruang IGD. Setelah mengumpulkan data melalui kuesioner, perawat melakukan analisis statistik untuk melihat hubungan tersebut.

Langkah metode ilmiah yang sedang dilakukan oleh perawat ini adalah:

- A. Identifikasi masalah
- B. Formulasi hipotesis
- C. Pengujian hipotesis
- D. Analisis hasil
- E. Penarikan kesimpulan

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis hasil dari data yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menentukan apakah data mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan sebelumnya.

H. Rangkuman materi

Metode ilmiah dan proses keperawatan adalah dua pendekatan penting dalam menyelesaikan masalah dalam bidang keperawatan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tahapan yang sistematis serta terstruktur. Metode ilmiah merupakan pendekatan objektif dan kritis yang bertujuan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digeneralisasi dan berbasis bukti melalui tahapan observasi, formulasi hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Setiap tahap metode ilmiah ini dilakukan dengan teliti dan terstruktur, mulai dari pengumpulan data melalui observasi mendalam hingga perancangan eksperimen

yang terkontrol untuk menguji hipotesis. Hasil analisis data menentukan validitas hipotesis, yang akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan serta memberikan kontribusi terhadap praktik klinis berbasis bukti.

Sementara itu, proses keperawatan adalah pendekatan yang langsung diterapkan dalam praktik klinis untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien secara individual. Proses ini terdiri dari lima tahap utama yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi intervensi, dan evaluasi hasil. Dalam pengkajian, perawat mengumpulkan data subjektif dan objektif secara mendalam dan menyeluruh tentang kondisi pasien. Berdasarkan data tersebut, perawat kemudian menyusun diagnosa keperawatan untuk mengidentifikasi masalah pasien secara spesifik. Tahap berikutnya adalah merancang rencana intervensi yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan perawatan yang telah ditentukan. Implementasi intervensi dilakukan secara langsung oleh perawat dengan mempertimbangkan kondisi pasien yang dinamis. Evaluasi dilakukan pada akhir proses untuk menilai efektivitas intervensi dan menentukan perlunya modifikasi lebih lanjut.

Meski metode ilmiah dan proses keperawatan memiliki tahapan yang mirip, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis data, kedua metode ini memiliki perbedaan mendasar dalam fokus, tujuan akhir, fleksibilitas, dan lingkup penerapannya. Metode ilmiah cenderung teoritis, dengan tujuan pengembangan teori yang dapat digeneralisasi, serta memiliki kontrol ketat terhadap kondisi penelitian. Sebaliknya, proses keperawatan lebih aplikatif, fokus pada penyelesaian masalah klinis spesifik pasien, memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan kondisi pasien, dan terbatas penerapannya pada situasi klinis individu atau kelompok pasien tertentu.

Integrasi metode ilmiah ke dalam proses keperawatan adalah pendekatan penting dalam praktik keperawatan modern yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui Evidence-Based Practice (EBP). Integrasi ini melibatkan penerapan hasil penelitian ilmiah terbaru pada setiap tahap proses keperawatan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah dan praktik klinis, perawat dapat meningkatkan akurasi diagnosa, efektivitas intervensi, dan hasil klinis pasien secara signifikan. Meskipun demikian, integrasi ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses terhadap penelitian terkini, keterampilan interpretasi hasil penelitian, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pelatihan berkelanjutan, penguatan kolaborasi antar disiplin, dan optimalisasi teknologi informasi. Dengan memahami secara mendalam konsep dasar dan integrasi kedua metode ini, perawat

mampu memberikan asuhan yang lebih efektif, holistik, dan berbasis bukti ilmiah demi peningkatan kualitas hidup pasien.

I. Glosarium

Analisis Data: Proses sistematis dalam menelaah data yang telah terkumpul untuk menemukan pola, hubungan, atau tren yang membantu dalam mengambil kesimpulan dari penelitian atau tindakan klinis.

Diagnosa Keperawatan: Keputusan klinis yang dibuat oleh perawat berdasarkan analisis data hasil pengkajian pasien untuk mengidentifikasi masalah kesehatan aktual atau potensial yang dihadapi pasien.

Evidence-Based Practice (EBP): Praktik keperawatan yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaik dengan keahlian klinis perawat serta nilai-nilai pasien dalam pengambilan keputusan klinis.

Evaluasi: Tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan untuk menentukan apakah tujuan perawatan tercapai atau perlu modifikasi lebih lanjut.

Eksperimen: Tahap dalam metode ilmiah yang digunakan untuk menguji validitas hipotesis melalui pengumpulan data yang terkontrol dan sistematis.

Formulasi Hipotesis: Proses menyusun dugaan atau asumsi sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen.

Implementasi Intervensi: Tahap pelaksanaan tindakan keperawatan secara langsung kepada pasien berdasarkan perencanaan intervensi yang telah disusun sebelumnya.

Integrasi Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan: Pendekatan yang menggabungkan hasil penelitian ilmiah terbaru dengan praktik klinis perawat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan keperawatan berbasis bukti ilmiah.

Metode Ilmiah: Pendekatan sistematis dan objektif yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara observasi, formulasi hipotesis, eksperimen, analisis data, hingga penarikan kesimpulan.

Observasi: Tahap awal dalam metode ilmiah berupa pengamatan sistematis dan mendalam terhadap fenomena atau masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data awal yang relevan.

Pengkajian: Langkah pertama dalam proses keperawatan yang melibatkan pengumpulan data secara komprehensif tentang kondisi pasien, meliputi aspek subjektif dan objektif.

Pengumpulan Data: Proses mendapatkan informasi secara objektif dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau analisis dokumen.

Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir metode ilmiah di mana peneliti membuat interpretasi berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menghasilkan temuan yang baru atau memperkuat teori yang ada.

Perencanaan Intervensi: Tahap penyusunan rencana tindakan keperawatan yang spesifik, jelas, terukur, dan berdasarkan diagnosa keperawatan yang bertujuan mencapai hasil klinis tertentu pada pasien.

Proses Keperawatan: Pendekatan terstruktur yang digunakan dalam praktik klinis untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien secara individu, terdiri atas pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Reliabilitas: Tingkat konsistensi atau kestabilan hasil pengukuran atau penelitian apabila dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama.

Validitas: Tingkat sejauh mana suatu hasil penelitian atau pengukuran benar-benar mengukur atau mencerminkan fenomena yang seharusnya diukur atau diteliti.

J. Daftar pustaka

- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). American Nurses Association.
- Brown, S. J. (2017). *Evidence-based nursing: The research-practice connection* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing care plans: Guidelines for individualizing client care across the life span* (10th ed.). F.A. Davis Company.
- Gray, J. R., Grove, S. K., & Sutherland, S. (2017). *Burns and Grove's the practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence* (8th ed.). Elsevier.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2021). *Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2018). *Fundamentals of nursing: The art and science of person-centered care* (9th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice* (2nd ed.). Elsevier.

BAB 5

TREND DAN ISSUE

Pendahuluan

Metodologi keperawatan terus berkembang seiring perubahan kebutuhan kesehatan global. Tren terbaru dalam keperawatan mencerminkan respons terhadap isu-isu kontemporer seperti peningkatan kualitas layanan, integrasi teknologi digital, fokus pada perawatan berbasis bukti, serta tantangan demografi akibat populasi lansia yang meningkat. Untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif, perawat perlu memahami tren-tren ini dan isu yang menyertainya agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan praktik klinis.

Isu-isu global seperti pandemi, transformasi digital, perubahan pola penyakit kronis, serta peningkatan tuntutan kualitas dan keamanan pelayanan menjadi perhatian utama yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, metodologi keperawatan modern harus memperhitungkan tren ini agar praktik keperawatan tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pasien dan komunitas.

Capaian Pembelajaran (CPL)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis tren dan isu terkini dalam metodologi keperawatan serta implikasinya bagi praktik keperawatan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan tren terbaru dalam metodologi keperawatan.
- Mengidentifikasi isu-isu utama yang mempengaruhi perkembangan metodologi keperawatan.
- Menganalisis implikasi tren dan isu dalam penerapan metodologi keperawatan berbasis bukti.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Mendeskripsikan berbagai tren dalam praktik keperawatan global.
- Mengidentifikasi isu-isu terkini yang mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan.
- Menjelaskan dampak teknologi digital terhadap metodologi keperawatan.
- Menganalisis hubungan antara tren demografi dengan kebutuhan metodologi keperawatan.
- Mengevaluasi pengaruh pandemi global terhadap perubahan metodologi keperawatan.

Uraian Materi

A. Tren dalam Metodologi Keperawatan

Metodologi keperawatan modern semakin berkembang dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan keperawatan secara signifikan. Salah satu inovasi utama adalah telehealth, sebuah pendekatan yang memungkinkan perawat memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh melalui platform virtual. Telehealth mencakup berbagai layanan, seperti konsultasi virtual secara langsung antara perawat dengan pasien, pemantauan kesehatan pasien secara jarak jauh (remote monitoring), dan edukasi kesehatan secara daring yang lebih interaktif dan luas jangkauannya. Telehealth terutama memberikan manfaat besar bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau, membantu mengurangi hambatan geografis dan memastikan bahwa pasien dapat tetap menerima layanan keperawatan berkualitas tinggi.

Selain telehealth, konsep e-health semakin berkembang pesat di era digital ini. E-health mengintegrasikan berbagai teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan informasi kesehatan pasien secara efisien dan efektif. Salah satu elemen penting dari e-health adalah Sistem Pencatatan Elektronik (Electronic Health Record/EHR), yang memungkinkan dokumentasi data kesehatan pasien secara sistematis, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh tim kesehatan yang terlibat. Penggunaan EHR mempermudah komunikasi antar tenaga kesehatan, membantu pengambilan keputusan klinis secara akurat berdasarkan data real-time, dan meningkatkan koordinasi pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Integrasi teknologi digital juga diperkuat dengan pemanfaatan perangkat wearable, yaitu perangkat canggih yang dapat dikenakan pasien untuk memantau kondisi kesehatan secara real-time. Wearable mampu merekam data vital seperti tekanan darah, kadar gula darah, denyut jantung, pola tidur, serta aktivitas fisik harian. Data ini sangat bermanfaat bagi perawat untuk memonitor kondisi kesehatan pasien secara kontinu, menganalisis pola kesehatan yang muncul, serta menentukan intervensi klinis yang tepat waktu dan efektif guna mencegah komplikasi atau kondisi yang lebih serius.

Di sisi lain, tren yang sama pentingnya adalah perawatan berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP). Metode ini menekankan pada pentingnya pengambilan keputusan klinis yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini yang tervalidasi, pengalaman klinis perawat, serta nilai-nilai dan preferensi pasien. Dalam penerapan EBP, perawat diharapkan terus memperbarui pengetahuan melalui sumber penelitian terbaru, mengintegrasikan temuan penelitian dalam praktik klinis,

serta rutin melakukan evaluasi untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan tetap optimal dan sesuai standar profesional yang tinggi.

Dengan mengadopsi berbagai tren ini, perawat diharapkan dapat lebih kompeten dalam menghadapi tantangan praktik keperawatan modern, lebih efisien dalam memberikan pelayanan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasien dan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis. Ini akan mendukung tercapainya tujuan utama keperawatan yaitu memberikan asuhan yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan di berbagai kondisi pelayanan kesehatan.

B. Isu Utama dalam Metodologi Keperawatan

Metodologi keperawatan menghadapi beberapa isu global penting yang berdampak signifikan terhadap praktik sehari-hari perawat. Salah satu isu utama adalah kekurangan tenaga perawat yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kekurangan ini berdampak langsung pada tingginya beban kerja yang harus ditanggung oleh perawat, menyebabkan kelelahan fisik dan psikologis, serta meningkatnya risiko kesalahan dalam pelayanan.

Tingginya beban kerja ini juga erat kaitannya dengan masalah kesehatan mental di kalangan perawat. Kondisi seperti stres, burnout, dan depresi semakin umum ditemukan di kalangan perawat akibat tuntutan kerja yang terus meningkat tanpa adanya dukungan yang cukup. Oleh karena itu, kesehatan mental perawat menjadi perhatian yang harus segera diatasi melalui dukungan psikologis yang tepat serta lingkungan kerja yang kondusif.

Selain tantangan internal, isu keselamatan pasien juga merupakan aspek krusial yang terus menjadi fokus utama dalam keperawatan. Kesalahan medikasi, infeksi nosokomial, dan kecelakaan akibat peralatan medis yang tidak aman merupakan beberapa contoh masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karenanya, perawat dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan spesifik berbasis bukti.

Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan agar perawat mampu memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi, memastikan keselamatan pasien, serta menghadapi tantangan dan tuntutan pelayanan kesehatan modern dengan lebih percaya diri dan kompeten. Dengan demikian, metodologi keperawatan mampu menjawab isu-isu penting tersebut secara efektif, meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

C. Dampak Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital dalam keperawatan memberikan dampak yang luas dan mendalam terhadap berbagai aspek metodologi praktik keperawatan

modern. Salah satu dampak yang paling menonjol terlihat dalam metode pengumpulan data pasien. Teknologi digital memungkinkan perawat untuk mengumpulkan data kesehatan pasien secara lebih efisien, akurat, dan real-time melalui perangkat digital yang canggih seperti tablet, komputer, dan perangkat wearable. Penggunaan perangkat wearable memungkinkan pemantauan data vital pasien secara kontinu, seperti tekanan darah, denyut jantung, kadar gula darah, pola tidur, serta aktivitas fisik. Data ini kemudian dapat diakses secara instan oleh tenaga kesehatan, yang memungkinkan pengambilan keputusan klinis secara tepat waktu dan berbasis data.

Selain pengumpulan data, dokumentasi digital juga membawa perubahan signifikan. Sistem pencatatan elektronik (Electronic Health Records/EHR) memberikan keunggulan dalam dokumentasi pasien yang terstruktur, terintegrasi, dan aman. Informasi kesehatan pasien dapat dengan mudah diakses oleh berbagai tenaga kesehatan, mempercepat proses koordinasi dan kolaborasi dalam perawatan pasien. EHR membantu mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memungkinkan analisis kesehatan populasi secara komprehensif, mendukung penelitian dan pengembangan layanan kesehatan yang lebih baik.

Teknologi digital juga membawa perubahan radikal dalam komunikasi antar tenaga kesehatan. Platform komunikasi elektronik yang terintegrasi, seperti pesan instan, konferensi video, dan sistem informasi kesehatan yang terpusat, memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dan efisien antar tim multidisiplin. Dalam situasi emergensi atau kritis, kemampuan berkomunikasi secara instan dan jelas sangat penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat, sehingga mampu mengurangi risiko kesalahan medis dan meningkatkan hasil perawatan.

Telekeperawatan merupakan inovasi penting yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital dalam keperawatan. Telekeperawatan membantu perawat menjangkau populasi terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau secara fisik oleh layanan medis tradisional. Melalui telekeperawatan, pasien dapat menerima konsultasi, edukasi kesehatan, dan pemantauan kondisi kesehatan secara remote tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Ini secara signifikan meningkatkan akses layanan kesehatan, mengurangi hambatan geografis, waktu, dan biaya transportasi, serta memastikan layanan kesehatan yang kontinu dan berkualitas tinggi bagi semua pasien.

Meski demikian, implementasi teknologi digital di bidang keperawatan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan kompetensi digital yang tinggi di kalangan tenaga kesehatan, khususnya perawat. Banyak perawat yang belum sepenuhnya terbiasa dengan teknologi digital yang

canggih, sehingga memerlukan pelatihan dan edukasi khusus untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perawat mampu menguasai dan menggunakan teknologi digital secara optimal dalam praktik sehari-hari.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara strategis, pemanfaatan teknologi digital dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan keperawatan. Perawat yang kompeten secara digital akan lebih siap menghadapi tantangan era digitalisasi dalam bidang kesehatan, sehingga menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih inovatif, aman, dan berkelanjutan.

D. Tren Demografi dan Kebutuhan Metodologi Keperawatan

Pertumbuhan populasi lansia yang signifikan di berbagai belahan dunia menghadirkan tantangan baru dalam penyediaan layanan kesehatan. Fenomena ini dikenal sebagai "aging population" atau "populasi menua", di mana proporsi lansia dalam populasi secara global terus meningkat. Kondisi ini berdampak besar terhadap perencanaan dan pengembangan metodologi keperawatan yang perlu secara khusus diarahkan pada kebutuhan lansia yang kompleks dan beragam.

Metodologi keperawatan untuk lansia membutuhkan pendekatan holistik yang berorientasi pada kualitas hidup dan bukan hanya sekadar manajemen penyakit. Metodologi ini mencakup berbagai dimensi kesehatan, seperti kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual, dengan memperhatikan kebutuhan unik dari setiap individu lansia. Perawatan holistik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia secara menyeluruh, mengurangi beban keluarga, serta mengoptimalkan fungsi independen lansia dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan yang berpusat pada pasien (patient-centered care) menjadi prinsip utama dalam metodologi perawatan lansia. Dalam pendekatan ini, lansia dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi perawatan yang mereka terima. Komunikasi terbuka dan empati tinggi dari tenaga kesehatan, khususnya perawat, menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini. Perawat tidak hanya bertindak sebagai pemberi layanan kesehatan tetapi juga sebagai advokat yang memastikan kebutuhan lansia didengar dan dihargai.

Selain pasien, pendekatan perawatan berbasis keluarga juga memainkan peran penting dalam metodologi keperawatan lansia. Keluarga merupakan unit utama pendukung lansia, yang berperan dalam memberikan dukungan emosional, fisik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pelibatan keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan perawatan sangat esensial. Perawat perlu memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga agar mampu berpartisipasi aktif dalam merawat lansia,

serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses perawatan.

Selanjutnya, pendekatan komunitas juga penting dalam konteks metodologi perawatan lansia. Pengembangan program berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga sosial, organisasi kesehatan, pemerintah, dan masyarakat luas, dapat mendukung terciptanya lingkungan yang ramah lansia. Program tersebut mencakup inisiatif-inisiatif seperti kegiatan sosial, program kesehatan preventif, edukasi kesehatan masyarakat, dan peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam rangka merespons tantangan demografi ini, metodologi keperawatan juga perlu terus dikembangkan melalui penelitian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode-metode terbaik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan lansia, mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan perawatan, serta memberikan bukti ilmiah yang kuat sebagai dasar praktik klinis.

Dengan pendekatan holistik yang berpusat pada pasien, keluarga, dan komunitas, serta didukung oleh penelitian berbasis bukti, metodologi keperawatan lansia mampu secara efektif menjawab tantangan yang muncul akibat perubahan demografi ini. Hal ini akan memastikan bahwa layanan kesehatan bagi lansia tidak hanya berfokus pada panjang usia tetapi juga pada kualitas hidup yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan individu lansia secara komprehensif dan berkelanjutan.

E. Pengaruh Pandemi Global

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dan signifikan dalam praktik keperawatan di seluruh dunia. Krisis kesehatan ini secara drastis mengubah cara kerja perawat dan metodologi keperawatan yang selama ini digunakan. Dalam situasi pandemi, metode kerja jarak jauh seperti telekeperawatan menjadi keharusan untuk meminimalkan risiko penularan virus sekaligus mempertahankan kontinuitas pelayanan kesehatan.

Telekeperawatan memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan konsultasi, edukasi kesehatan, dan pemantauan kondisi kesehatan pasien secara jarak jauh. Hal ini sangat membantu dalam menjaga akses layanan kesehatan bagi pasien yang tidak dapat mengunjungi fasilitas kesehatan secara fisik karena keterbatasan gerak akibat kebijakan lockdown atau isolasi mandiri. Telekeperawatan juga memainkan peran penting dalam manajemen kasus COVID-19, termasuk pemantauan pasien dengan gejala ringan hingga sedang yang menjalani perawatan di rumah.

Selain metode kerja jarak jauh, penerapan protokol kesehatan yang ketat juga menjadi bagian integral dari praktik keperawatan selama pandemi. Protokol ini mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD) secara konsisten, praktik kebersihan tangan yang ketat, pengaturan jarak fisik di lingkungan pelayanan kesehatan, serta prosedur dekontaminasi dan sterilisasi lingkungan yang intensif. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini tidak hanya melindungi pasien tetapi juga menjamin keselamatan tenaga kesehatan itu sendiri.

Pandemi COVID-19 juga menunjukkan pentingnya adaptasi cepat oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, terhadap kondisi darurat kesehatan global. Perawat harus mampu dengan cepat menyesuaikan praktik mereka dengan perubahan panduan dan pedoman yang seringkali berubah seiring berkembangnya pemahaman tentang virus COVID-19. Fleksibilitas ini melibatkan peningkatan kompetensi klinis dan keterampilan manajerial untuk menghadapi situasi kritis dan memastikan bahwa perawatan pasien tetap optimal di tengah situasi yang dinamis.

Pandemi juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi krisis kesehatan global. Sistem kesehatan yang tangguh membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif, logistik medis yang memadai, serta komunikasi yang efisien antar unit layanan. Metodologi keperawatan harus mencakup perencanaan kontinjensi yang baik untuk memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat, termasuk pelatihan khusus untuk manajemen bencana dan pandemi.

Selama pandemi, perawat juga menghadapi tantangan psikososial yang signifikan, seperti kelelahan fisik dan mental, stres kerja yang tinggi, serta risiko burnout yang meningkat akibat tekanan kerja yang luar biasa. Oleh karena itu, dukungan psikologis, kebijakan manajemen stres, dan intervensi kesehatan mental bagi tenaga kesehatan menjadi sangat penting. Institusi kesehatan perlu menyediakan mekanisme dukungan seperti konseling psikologis, program kesehatan mental, serta dukungan sosial untuk menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan.

Dengan pemahaman komprehensif terhadap tren dan isu ini, perawat akan lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan serta mampu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Metodologi keperawatan yang fleksibel, adaptif, dan berbasis bukti akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi dampak pandemi serta tantangan kesehatan global lainnya di masa depan. Penguatan kompetensi dan kesiapan perawat menjadi faktor krusial dalam meningkatkan ketahanan sistem kesehatan global.

F. Latihan Soal

1. Seorang perawat di klinik terpencil melaporkan kesulitan memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien lansia yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau. Klinik kemudian memutuskan menerapkan telekeperawatan. Apa manfaat utama telekeperawatan bagi pasien dalam kasus ini?
 - A. Mengurangi biaya pengobatan
 - B. Menghilangkan kebutuhan tenaga kesehatan
 - C. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
 - D. Menggantikan sepenuhnya interaksi langsung
 - E. Mengurangi jumlah pasien yang membutuhkan perawatan

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Telekeperawatan terutama bermanfaat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien yang berada di lokasi terpencil, memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus bepergian jauh.

2. Seorang perawat mencatat bahwa terjadi beberapa kesalahan medikasi akibat proses pencatatan manual yang kurang terstruktur. Rumah sakit memutuskan menerapkan Sistem Pencatatan Elektronik (EHR). Manakah manfaat utama dari penggunaan EHR dalam kasus ini?
 - A. Menurunkan kualitas komunikasi antar staf
 - B. Mempercepat rotasi tenaga perawat
 - C. Mengurangi kesalahan administrasi
 - D. Membatasi akses informasi pasien
 - E. Mengurangi kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Penggunaan EHR dapat mengurangi kesalahan administrasi karena pencatatan data pasien menjadi lebih sistematis, terintegrasi, dan akurat, sehingga meminimalisasi kesalahan medikasi.

3. Seorang perawat melaporkan kelelahan dan stres berat akibat beban kerja yang tinggi selama pandemi COVID-19. Manakah strategi yang paling tepat untuk mengatasi kondisi perawat tersebut?
 - A. Mengurangi komunikasi antar staf
 - B. Menambah jam kerja perawat
 - C. Mengabaikan keluhan perawat
 - D. Memberikan dukungan psikologis dan manajemen stres
 - E. Menutup sementara fasilitas kesehatan

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Memberikan dukungan psikologis dan manajemen stres merupakan pendekatan terbaik untuk mengatasi kelelahan fisik dan mental yang dialami perawat akibat tekanan kerja yang tinggi.

4. Rumah sakit sedang merencanakan penerapan perangkat wearable untuk pemantauan kondisi pasien dengan penyakit kronis. Manakah manfaat utama dari pemanfaatan perangkat wearable tersebut dalam konteks keperawatan?
- A. Mengurangi kebutuhan kunjungan langsung pasien
 - B. Mengganti peran perawat sepenuhnya
 - C. Menyediakan data vital pasien secara real-time
 - D. Menurunkan kompetensi digital perawat
 - E. Menghilangkan peran dokter dalam diagnosis pasien

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Perangkat wearable menyediakan data vital pasien secara real-time, yang membantu perawat memonitor kondisi pasien secara kontinu, mengambil keputusan klinis yang tepat waktu, dan mencegah komplikasi.

5. Seorang perawat sedang menghadapi populasi lansia yang meningkat secara signifikan di wilayah kerjanya. Metode perawatan apakah yang paling tepat diterapkan untuk menghadapi tantangan ini?
- A. Pendekatan perawatan berbasis keluarga dan komunitas
 - B. Mengurangi interaksi sosial lansia
 - C. Mengandalkan perawatan medis sepenuhnya tanpa interaksi sosial
 - D. Meningkatkan isolasi sosial pada lansia
 - E. Mengurangi partisipasi lansia dalam keputusan kesehatan

Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Pendekatan perawatan berbasis keluarga dan komunitas merupakan metode paling tepat karena melibatkan keluarga dan komunitas dalam memberikan dukungan holistik untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual lansia.

G. Rangkuman Materi

Metodologi keperawatan modern kini semakin maju dengan integrasi teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Salah satu bentuk inovasi penting dalam bidang ini adalah telehealth, yang memungkinkan perawat memberikan layanan kesehatan secara jarak jauh melalui platform virtual. Telehealth meliputi konsultasi virtual, pemantauan kesehatan secara jarak jauh, serta edukasi kesehatan daring yang lebih interaktif. Metode ini sangat bermanfaat bagi

pasien di daerah terpencil dengan akses terbatas, memudahkan mereka memperoleh layanan keperawatan berkualitas tanpa hambatan geografis.

Selain telehealth, konsep e-health juga mengalami perkembangan pesat di era digital. E-health memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola informasi kesehatan pasien secara efektif dan efisien. Salah satu komponen utama dari e-health adalah Electronic Health Record (EHR), sistem pencatatan elektronik yang memungkinkan data pasien terdokumentasi dengan rapi, terintegrasi, dan mudah diakses oleh semua tenaga kesehatan terkait. Penggunaan EHR meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan, mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data real-time, serta mempercepat koordinasi layanan kesehatan.

Teknologi digital juga menghadirkan perangkat wearable yang berfungsi untuk memonitor kondisi kesehatan pasien secara kontinu, mencakup pengukuran tekanan darah, denyut jantung, kadar gula darah, pola tidur, dan aktivitas fisik harian. Data dari perangkat ini sangat membantu perawat dalam melakukan pemantauan secara real-time, menganalisis pola kesehatan pasien, serta menentukan intervensi klinis yang tepat guna mencegah komplikasi.

Metodologi keperawatan berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP) menjadi tren penting lainnya. EBP menekankan pengambilan keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis perawat, serta preferensi pasien. Pendekatan ini mengharuskan perawat selalu memperbaharui pengetahuan mereka melalui riset terbaru, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam praktik klinis, serta melakukan evaluasi rutin untuk menjaga kualitas pelayanan.

Di sisi lain, metodologi keperawatan menghadapi beberapa tantangan global yang signifikan. Kekurangan tenaga perawat secara global mengakibatkan tingginya beban kerja yang berdampak pada kelelahan fisik dan psikologis, serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan. Masalah kesehatan mental seperti stres, burnout, dan depresi semakin umum dialami perawat akibat kurangnya dukungan psikologis dan lingkungan kerja yang kondusif.

Keselamatan pasien juga merupakan isu penting dalam praktik keperawatan. Perawat harus terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan berbasis bukti untuk mengurangi risiko kesalahan medikasi, infeksi nosokomial, serta kecelakaan yang berkaitan dengan peralatan medis. Dengan demikian, perawat mampu memberikan layanan berkualitas tinggi dan aman.

Perubahan demografi dengan meningkatnya populasi lansia menghadirkan kebutuhan baru dalam metodologi keperawatan yang lebih holistik dan berorientasi pada kualitas hidup. Pendekatan berbasis pasien, keluarga, dan komunitas semakin dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan kompleks lansia, dengan

penekanan pada komunikasi empatik, keterlibatan aktif pasien dalam keputusan kesehatan, serta pelibatan keluarga dan komunitas dalam proses perawatan.

Pandemi COVID-19 juga berdampak besar pada praktik keperawatan global. Situasi ini menuntut perawat mengadopsi metode kerja jarak jauh seperti telekeperawatan untuk meminimalisir risiko penularan virus. Protokol kesehatan yang ketat, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pedoman klinis, serta kesiapan sistem kesehatan untuk merespons kondisi darurat menjadi sangat penting. Selain itu, tantangan psikososial seperti stres dan burnout memerlukan perhatian khusus melalui intervensi kesehatan mental dan dukungan psikologis yang intensif bagi perawat.

Dengan memahami secara komprehensif tren dan isu dalam metodologi keperawatan, perawat akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan memberikan asuhan yang unggul, inovatif, serta berkelanjutan.

H. Glosarium

Telehealth: Pendekatan layanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan platform virtual untuk konsultasi, pemantauan pasien, dan edukasi kesehatan secara daring.

E-health: Integrasi teknologi informasi dalam layanan kesehatan untuk pengelolaan data pasien secara efisien dan efektif.

Electronic Health Record (EHR): Sistem pencatatan elektronik untuk mendokumentasikan data kesehatan pasien secara sistematis dan terintegrasi, yang dapat diakses oleh seluruh tim kesehatan secara real-time.

Perangkat Wearable: Perangkat elektronik yang dikenakan oleh pasien untuk memonitor kondisi kesehatan secara real-time, mencakup data vital seperti tekanan darah, denyut jantung, kadar gula darah, pola tidur, dan aktivitas fisik harian.

Evidence-Based Practice (EBP): Pendekatan dalam praktik klinis yang menggunakan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis perawat, serta preferensi pasien sebagai dasar pengambilan keputusan.

Burnout: Kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang diakibatkan oleh stres kronis, biasanya terjadi pada tenaga kesehatan akibat tuntutan kerja yang tinggi.

Infeksi Nosokomial: Infeksi yang didapat oleh pasien selama menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.

Telekeperawatan: Pelayanan keperawatan yang diberikan secara jarak jauh melalui teknologi digital untuk pasien yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Kompetensi Digital: Keterampilan yang diperlukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk menguasai dan menggunakan teknologi digital secara efektif dalam praktik sehari-hari.

Populasi Menua (Aging Population): Fenomena peningkatan proporsi lansia dalam populasi global, yang mempengaruhi kebutuhan metodologi perawatan kesehatan khusus bagi lansia.

Perawatan Holistik: Pendekatan perawatan yang mempertimbangkan berbagai dimensi kesehatan (fisik, mental, emosional, sosial, spiritual) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

Patient-centered Care: Pendekatan perawatan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai fokus utama dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi pelayanan.

Pendekatan Perawatan Berbasis Keluarga: Metode perawatan yang melibatkan keluarga secara aktif dalam proses perawatan pasien, khususnya lansia.

Pendekatan Komunitas: Strategi pengembangan program kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, khususnya lansia.

Protokol Kesehatan: Aturan atau pedoman yang ditetapkan untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari risiko kesehatan, terutama dalam situasi pandemi seperti COVID-19.

Manajemen Stres: Teknik atau strategi untuk membantu tenaga kesehatan mengelola stres akibat beban kerja tinggi dan kondisi darurat, termasuk dukungan psikologis dan intervensi kesehatan mental.

Kesiapan Sistem Kesehatan: Kapasitas sistem kesehatan dalam merespons dan mengelola situasi darurat kesehatan global, mencakup manajemen sumber daya manusia, logistik medis, dan komunikasi antar unit pelayanan.

I. Daftar pustaka

- Almathami, H. K., Win, K. T., & Vlahu-Gjorgievska, E. (2020). Barriers and Facilitators That Influence Telemedicine-Based, Real-Time, Online Consultation at Patients' Homes: Systematic Literature Review. *Journal of Medical Internet Research*, 22(2), e16407. <https://doi.org/10.2196/16407>
- Baig, M. M., GholamHosseini, H., Moqem, A. A., Mirza, F., & Lindén, M. (2017). A Systematic Review of Wearable Patient Monitoring Systems – Current Challenges and Opportunities for Clinical Adoption. *Journal of Medical Systems*, 41(7), 115. <https://doi.org/10.1007/s10916-017-0760-1>
- Bates, D. W., & Singh, H. (2018). Two Decades Since To Err Is Human: An Assessment of Progress and Emerging Priorities in Patient Safety. *Health Affairs*, 37(11), 1736–1743. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2018.0738>
- Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V., Barisone, M., Timmins, F., Rossi, S., ... & Sasso, L. (2018). A review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. *Journal of Nursing Management*, 26(8), 918–932. <https://doi.org/10.1111/jonm.12638>

- Chung, S., Lee, S. Y., & Nahm, E. S. (2021). Patient-Centeredness in Telehealth and E-Health: A Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(4), e25095. <https://doi.org/10.2196/25095>
- Grant, J., Lines, L., Darbyshire, P., & Parry, Y. (2017). How do nurses use evidence-based practice? A systematic review and thematic synthesis. *Implementation Science*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0617-5>
- Innes, A., Page, S. J., & Cutler, C. (2016). Barriers to Leisure Participation for People with Dementia and Their Carers: An Exploratory Analysis of Carer and People with Dementia's Experiences. *Dementia*, 15(6), 1643–1665. <https://doi.org/10.1177/1471301215570346>
- Jha, A. K., & Pronovost, P. J. (2016). Toward a Safer Health Care System: The Critical Need to Improve Measurement. *JAMA*, 315(17), 1831–1832. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.3448>
- Levine, D. M., Lipsitz, S. R., & Linder, J. A. (2018). Trends in Seniors' Use of Digital Health Technology in the United States, 2011-2014. *JAMA*, 318(7), 648–650. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.9124>
- Meskó, B., Drobni, Z., Béneyei, É., Gergely, B., & Györfy, Z. (2017). Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare. *MHealth*, 3, 38. <https://doi.org/10.21037/mhealth.2017.08.07>
- Rouleau, G., Gagnon, M. P., Côté, J., Payne-Gagnon, J., Hudson, E., & Dubois, C. A. (2017). Impact of Information and Communication Technologies on Nursing Care: Results of an Overview of Systematic Reviews. *Journal of Medical Internet Research*, 19(4), e122. <https://doi.org/10.2196/jmir.6686>
- Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2019). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Whitelaw, S., Mamas, M. A., Topol, E., & Van Spall, H. G. C. (2020). Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response. *The Lancet Digital Health*, 2(8), e435–e440. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30142-4](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30142-4)
- World Health Organization. (2020). State of the World's Nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership. WHO.

BAB 6

PERENCANAAN KEPERAWATAN

Pendahuluan

Perencanaan keperawatan merupakan tahapan penting dalam proses keperawatan yang menjadi acuan utama bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara sistematis dan terorganisasi. Perencanaan keperawatan bertujuan untuk menetapkan prioritas masalah, menentukan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, serta memilih intervensi keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah pasien secara efektif. Proses ini menuntut keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang terintegrasi dalam praktek klinik keperawatan sehari-hari. Dengan demikian, kualitas asuhan keperawatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, memberikan dampak positif terhadap kondisi pasien dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan metode ilmiah dalam menyusun rencana keperawatan berdasarkan hasil pengkajian komprehensif dan mampu mengambil keputusan secara kritis, kreatif, dan inovatif dalam praktik keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menyusun perencanaan keperawatan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis evidence-based practice untuk berbagai situasi klinik dengan mempertimbangkan aspek bio-psiko-sosio-spiritual pasien.

4. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar perencanaan keperawatan.
- Menyusun prioritas masalah keperawatan berdasarkan hasil pengkajian yang valid dan akurat.
- Merumuskan tujuan dan kriteria hasil (outcome) secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

- Menentukan intervensi keperawatan berbasis evidence-based practice yang efektif dan efisien.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perencanaan keperawatan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan adalah tahap dalam proses keperawatan yang secara spesifik menentukan prioritas masalah, menetapkan tujuan yang jelas, serta memilih intervensi yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Proses perencanaan ini merupakan jembatan penting antara tahap pengkajian dan implementasi, memastikan bahwa tindakan keperawatan dilakukan secara terorganisir, efektif, dan terarah. Untuk menjalankan proses ini dengan baik, perawat harus dilengkapi dengan pengetahuan teoritis yang kuat, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan interpersonal yang baik.

Dalam praktik klinis, perencanaan keperawatan membantu perawat untuk bekerja secara sistematis dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas tindakan yang dilakukan. Hal ini juga memberikan dasar evaluasi yang jelas terhadap hasil asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien.

1. Tujuan Perencanaan Keperawatan

Tujuan utama dari perencanaan keperawatan adalah:

- a. Menentukan prioritas masalah keperawatan yang harus segera ditangani berdasarkan tingkat urgensi.
- b. Merumuskan tujuan yang jelas dan realistis untuk memperbaiki kondisi pasien.
- c. Menentukan intervensi yang efektif dan efisien berdasarkan evidence-based practice (EBP).
- d. Menyediakan pedoman pelaksanaan asuhan keperawatan yang konsisten dan berkualitas.

2. Elemen Utama dalam Perencanaan Keperawatan

a. Penentuan Prioritas Masalah

Penentuan prioritas masalah dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, antara lain:

- 1) Hierarki Kebutuhan Maslow: Memprioritaskan kebutuhan fisiologis (seperti kebutuhan oksigen, nutrisi, cairan), keamanan (perlindungan dari cedera), kebutuhan sosial (rasa dicintai dan diterima), penghargaan (pengakuan dan penghormatan), dan aktualisasi diri (pengembangan potensi).
- 2) Pendekatan ABC (Airway, Breathing, Circulation): Memastikan pasien dalam kondisi stabil terlebih dahulu, terutama pada kondisi kritis yang mengancam kehidupan.
- 3) Pendekatan Risiko: Memprioritaskan intervensi berdasarkan risiko komplikasi atau dampak terhadap kualitas hidup pasien, seperti risiko infeksi, jatuh, atau komplikasi pascaoperasi.

b. Formulasi Tujuan Keperawatan

Tujuan yang baik dalam perencanaan keperawatan memiliki karakteristik SMART:

- 1) Spesifik (Specific): Jelas, detail, dan terfokus pada satu aspek spesifik.
- 2) Terukur (Measurable): Memiliki indikator atau parameter yang jelas untuk mengukur pencapaian.
- 3) Dapat Dicapai (Achievable): Realistis dan sesuai dengan kondisi pasien serta sumber daya yang tersedia.
- 4) Relevan (Relevant): Langsung berhubungan dengan masalah utama pasien, memberikan dampak positif bagi pasien.
- 5) Berbasis Waktu (Time-bound): Memiliki batas waktu tertentu yang jelas untuk mencapai hasil yang diharapkan.

c. Pemilihan Intervensi Keperawatan

Intervensi yang dipilih harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Pertimbangan dalam memilih intervensi meliputi:

- 1) Bukti Ilmiah (EBP): Intervensi yang dipilih didukung oleh penelitian terbaru yang membuktikan efektivitasnya.
- 2) Keadaan Klinis Pasien: Mengacu pada kondisi pasien yang spesifik dan kebutuhan individualnya.
- 3) Preferensi Pasien dan Keluarga: Menyesuaikan intervensi dengan preferensi dan nilai yang dimiliki pasien dan keluarganya untuk meningkatkan penerimaan dan kerjasama.
- 4) Ketersediaan Sumber Daya: Mempertimbangkan fasilitas, peralatan, dan tenaga kesehatan yang tersedia dalam lingkungan pelayanan kesehatan.

3. Proses Berpikir Kritis dalam Perencanaan Keperawatan

Berpikir kritis merupakan komponen penting dalam perencanaan keperawatan. Perawat harus mampu menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi alternatif intervensi, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman klinis. Proses ini mencakup:

- a. Mengumpulkan data secara sistematis dan mengevaluasinya secara kritis untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta menghubungkannya dengan bukti ilmiah yang tersedia.
- c. Menimbang risiko dan manfaat masing-masing alternatif intervensi yang tersedia secara mendalam.
- d. Mengambil keputusan berdasarkan prioritas, urgensi, efektivitas, efisiensi, dan kemungkinan hasil yang optimal bagi pasien.

4. Peran Keterampilan Interpersonal dalam Perencanaan Keperawatan

Keterampilan interpersonal yang baik diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya, termasuk:

- a. Komunikasi Empatik: Mampu mendengarkan secara aktif, memahami kebutuhan dan perasaan pasien serta keluarganya.
- b. Kerjasama Tim: Bekerja sama secara harmonis dengan tim multidisiplin untuk mencapai tujuan perawatan yang komprehensif.
- c. Edukasi Pasien dan Keluarga: Memberikan informasi secara jelas dan tepat, sehingga pasien dan keluarga memahami dan mendukung rencana perawatan yang disusun.

B. Penentuan Prioritas Masalah

Penentuan prioritas masalah keperawatan adalah langkah krusial dalam proses perencanaan keperawatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa masalah pasien yang paling kritis ditangani terlebih dahulu. Langkah ini menuntut kemampuan analisis, penilaian kritis, serta pengambilan keputusan yang matang berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasien. Penentuan prioritas masalah ini memastikan bahwa perawat memberikan asuhan keperawatan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pasien yang mendesak.

1. Pendekatan dalam Menentukan Prioritas Masalah

a. Pendekatan Hierarki Kebutuhan Maslow

Pendekatan ini didasarkan pada teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam bentuk hierarki yang dimulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Prioritas intervensi keperawatan berdasarkan pendekatan ini biasanya dimulai dari kebutuhan paling dasar menuju kebutuhan yang lebih kompleks:

- 1) Kebutuhan Fisiologis: Merupakan kebutuhan dasar yang esensial untuk kelangsungan hidup seperti oksigenasi, nutrisi, cairan, tidur, eliminasi, dan perlindungan fisik. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan fisiologis ini wajib diatasi terlebih dahulu karena bersifat vital dan kritis.
- 2) Kebutuhan Keamanan: Kebutuhan akan perlindungan dari cedera, bahaya, infeksi, serta stabilitas dalam lingkungan pasien. Perawat harus memastikan lingkungan yang aman untuk menghindari cedera atau bahaya tambahan.
- 3) Kebutuhan Sosial: Kebutuhan akan kasih sayang, penerimaan, serta hubungan interpersonal yang baik. Intervensi dalam hal ini berfokus pada pemberian dukungan emosional dan sosial.

- 4) Kebutuhan Penghargaan: Kebutuhan akan rasa percaya diri, pengakuan, dan penghormatan dari orang lain. Fokus intervensi keperawatan di sini adalah membangun kepercayaan diri pasien dan penghormatan terhadap dirinya.
 - 5) Kebutuhan Aktualisasi Diri: Mencapai potensi maksimal diri, yaitu kebutuhan tertinggi di mana individu mengejar pemenuhan pribadi yang optimal.
- b. Pendekatan Klinis ABC (Airway, Breathing, Circulation)

Pendekatan ABC digunakan dalam situasi kritis atau keadaan darurat yang dapat mengancam nyawa pasien. Prioritas ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup pasien:

- 1) Airway (Jalan Napas): Perawat harus segera memastikan jalan napas pasien terbuka dan tidak ada sumbatan yang dapat menghalangi pernapasan.
- 2) Breathing (Pernapasan): Mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas ventilasi pasien, kemampuan bernapas, serta kecukupan oksigenasi.
- 3) Circulation (Sirkulasi): Menilai dan menjaga stabilitas sirkulasi darah pasien, termasuk denyut nadi, tekanan darah, dan perfusi jaringan agar tetap adekuat.

Protokol ini memastikan bahwa tindakan keperawatan yang diambil bertujuan untuk segera mengatasi masalah vital yang dapat mengancam jiwa pasien terlebih dahulu.

c. Pendekatan Risiko

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengutamakan masalah keperawatan berdasarkan risiko komplikasi serta dampaknya terhadap keselamatan pasien dan kualitas hidupnya. Risiko ini dikategorikan berdasarkan tingkatannya, yaitu:

- 1) Risiko Tinggi: Masalah yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya komplikasi serius atau bahkan kematian, seperti risiko infeksi serius, risiko cedera akibat jatuh, atau risiko perdarahan hebat.
- 2) Risiko Sedang: Masalah yang harus mendapat perhatian namun tidak bersifat mendesak, namun jika dibiarkan akan berkembang menjadi masalah serius. Contohnya adalah risiko luka tekan atau risiko gangguan nutrisi yang sedang.
- 3) Risiko Rendah: Masalah yang memiliki dampak kecil terhadap kondisi pasien dan dapat ditangani setelah risiko yang lebih tinggi telah ditangani.

2. Pertimbangan dalam Menentukan Prioritas Masalah

Dalam proses menentukan prioritas masalah keperawatan, perawat perlu mempertimbangkan beberapa aspek kunci sebagai berikut:

- a. Urgensi: Seberapa mendesak intervensi harus dilakukan untuk mencegah komplikasi atau kondisi yang lebih parah.

- b. Tingkat Keparahan: Seberapa serius dampak dari masalah tersebut terhadap kesehatan pasien saat ini.
- c. Risiko Keselamatan: Potensi risiko atau bahaya yang dapat dialami pasien apabila masalah tersebut tidak segera diatasi.
- d. Dampak terhadap Kualitas Hidup: Bagaimana masalah yang ada memengaruhi kehidupan sehari-hari pasien, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional.

C. Formulasi Tujuan dan Kriteria Hasil (Outcome)

Formulasi tujuan dan kriteria hasil atau outcome merupakan tahap penting dalam proses perencanaan keperawatan yang mendefinisikan secara eksplisit tujuan yang ingin dicapai melalui intervensi yang dirancang. Tahap ini menjadi landasan penting karena menentukan fokus intervensi dan memberikan pedoman evaluasi yang jelas dalam praktik keperawatan.

1. Karakteristik SMART dalam Tujuan Keperawatan

Formulasi tujuan keperawatan yang efektif harus memenuhi kriteria SMART, yaitu:

- a. Spesifik (Specific) Tujuan yang disusun harus jelas dan mendetail, tidak ambigu, serta secara spesifik mengacu pada masalah yang dihadapi pasien. Spesifikasi tujuan akan membantu perawat mengarahkan perhatian pada intervensi yang diperlukan secara tepat.

Contoh: "Pasien mampu mempertahankan saturasi oksigen $\geq 95\%$ selama istirahat."

- b. Terukur (Measurable) Tujuan harus memiliki parameter yang jelas sehingga pencapaiannya dapat diukur secara objektif. Parameter yang digunakan harus mudah diamati, dikuantifikasi, atau dinilai.

Contoh: "Pasien mampu berjalan mandiri sejauh 30 meter tanpa alat bantu dalam waktu satu minggu."

- c. Dapat Dicapai (Achievable) Tujuan yang dirumuskan harus realistis dan memungkinkan untuk dicapai dengan mempertimbangkan kondisi pasien, kemampuan tim kesehatan, serta sumber daya yang tersedia. Tujuan yang realistis akan meningkatkan motivasi pasien dan tim perawat.

Contoh: "Pasien mampu duduk tegak tanpa bantuan dalam waktu 48 jam setelah operasi."

- d. Relevan (Relevant) Tujuan harus relevan dengan masalah utama pasien yang diidentifikasi dan memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi pasien. Relevansi memastikan bahwa intervensi memberikan kontribusi nyata pada pemulihan pasien.

Contoh: "Pasien mampu menurunkan kadar glukosa darah hingga <140 mg/dL dalam waktu dua minggu."

- e. Berbasis Waktu (Time-bound) Tujuan harus memiliki jangka waktu tertentu untuk dicapai sehingga dapat menjadi acuan evaluasi hasil tindakan secara tepat waktu. Adanya batas waktu memberikan motivasi tambahan dan kejelasan dalam proses intervensi keperawatan.

Contoh: "Pasien dapat mengurangi skala nyeri dari skala 7 menjadi 3 dalam waktu 48 jam."

2. Pentingnya Formulasi Tujuan SMART

- a. Efektivitas Intervensi: Menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien.
- b. Evaluasi yang Objektif: Memudahkan perawat untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi secara objektif dan terukur.
- c. Motivasi Pasien dan Tim: Adanya target yang jelas memberikan motivasi yang lebih baik kepada pasien serta meningkatkan kolaborasi antar tim kesehatan.

3. Langkah-langkah dalam Formulasi Tujuan dan Outcome

- a. Analisis Data Pengkajian Mengkaji data klinis secara komprehensif untuk memahami secara mendalam kondisi pasien, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi.
- b. Identifikasi Masalah Prioritas Menentukan masalah utama yang mendesak berdasarkan tingkat keparahan, urgensi, serta dampaknya terhadap kondisi pasien.
- c. Penetapan Tujuan Berdasarkan Prioritas Masalah Menentukan tujuan keperawatan yang spesifik dan relevan dengan memperhatikan kriteria SMART agar tercapai hasil yang optimal.
- d. Pemilihan Indikator Outcome Menentukan parameter atau indikator spesifik yang digunakan sebagai standar evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan yang dilakukan.

4. Contoh Penerapan SMART dalam Praktik Klinis

- a. Pasien dengan Gangguan Pernapasan:
 - 1) Tujuan: "Pasien mampu mempertahankan saturasi oksigen $\geq 94\%$ tanpa bantuan oksigen tambahan dalam waktu 72 jam."
 - 2) Indikator: Pengukuran saturasi oksigen secara berkala setiap 4 jam.
- b. Pasien dengan Luka Operasi:
 - 1) Tujuan: "Pasien menunjukkan penyembuhan luka tanpa tanda-tanda infeksi (kemerahan, pembengkakan, nyeri, sekret purulen) dalam waktu 7 hari pasca operasi."

- 2) Indikator: Observasi luka harian, pengukuran suhu tubuh, dan tanda vital lainnya secara berkala.

D. Pemilihan Intervensi Keperawatan

Pemilihan intervensi keperawatan merupakan tahapan kritis dalam proses perencanaan keperawatan yang bertujuan menentukan tindakan paling efektif untuk mengatasi masalah pasien secara optimal. Intervensi yang dipilih harus berlandaskan pada bukti ilmiah terbaru (evidence-based practice), memastikan bahwa tindakan yang diberikan terbukti efektif dalam mencapai hasil klinis yang diinginkan.

1. Karakteristik Intervensi Keperawatan Berbasis Bukti

Intervensi keperawatan berbasis bukti memiliki beberapa karakteristik penting yang harus dipenuhi:

- a. Berbasis Bukti Ilmiah Intervensi keperawatan harus didukung penelitian terbaru dan bukti ilmiah kuat yang menunjukkan efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah pasien secara klinis.

Contoh: Penggunaan antiseptik berbasis alkohol dalam protokol higiene tangan yang telah terbukti secara ilmiah efektif menurunkan angka infeksi nosokomial.

- b. Sesuai dengan Kebutuhan Pasien Intervensi harus disesuaikan secara individual berdasarkan kondisi klinis pasien, memastikan kebutuhan khusus setiap pasien terpenuhi.

Contoh: Menyesuaikan jadwal pemberian obat sesuai pola aktivitas pasien guna meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi.

- c. Memperhatikan Sumber Daya Tersedia Pemilihan intervensi harus realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, peralatan medis, fasilitas, dan dukungan administratif yang tersedia di lingkungan klinis.

Contoh: Memilih intervensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan.

- d. Mempertimbangkan Preferensi Pasien dan Keluarga Intervensi keperawatan perlu mempertimbangkan preferensi, nilai, dan keyakinan pasien serta keluarganya untuk memastikan tindakan tersebut dapat diterima dan efektif dalam pelaksanaannya.

Contoh: Menggunakan metode nonfarmakologis untuk pengelolaan nyeri sesuai dengan preferensi pasien, seperti terapi musik atau teknik relaksasi.

- e. Konteks Klinik Intervensi yang dipilih harus sesuai dengan situasi klinis, budaya organisasi, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di tempat pasien dirawat.

Contoh: Memilih metode pengendalian infeksi yang konsisten dengan kebijakan rumah sakit tertentu.

5. Langkah-langkah dalam Pemilihan Intervensi Keperawatan

- a. Identifikasi Masalah Keperawatan Utama Menentukan masalah prioritas berdasarkan data pengkajian menyeluruh yang telah dilakukan sebelumnya.
- b. Tinjauan Literatur Berbasis Bukti Melakukan pencarian bukti ilmiah terkini melalui jurnal ilmiah dan basis data penelitian yang relevan untuk memastikan efektivitas intervensi.
- c. Evaluasi Sumber Daya yang Tersedia Mengkaji ketersediaan fasilitas, peralatan, tenaga kesehatan, serta dukungan administratif yang diperlukan dalam implementasi intervensi.
- d. Konsultasi dengan Pasien dan Keluarga Berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan keluarganya untuk memastikan intervensi yang dipilih sejalan dengan preferensi dan nilai-nilai mereka.
- e. Pertimbangan Konteks Klinik Menyesuaikan intervensi dengan kebijakan, prosedur, dan budaya klinis dari lingkungan pelayanan kesehatan tempat pasien dirawat.

6. Pentingnya Intervensi Berbasis Bukti

- a. Efektivitas Tindakan: Memastikan tindakan keperawatan yang dilakukan efektif dalam mengatasi masalah pasien.
- b. Efisiensi Pelayanan: Meningkatkan efisiensi sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun fasilitas.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas hasil klinis dan kepuasan pasien melalui pendekatan ilmiah dan terukur.

7. Contoh Praktis Pemilihan Intervensi Berbasis Bukti

- a. Pasien dengan Risiko Infeksi:

Intervensi: Melaksanakan kebersihan tangan secara ketat menggunakan antiseptik berbasis alkohol sesuai protokol rumah sakit, untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi silang di antara pasien.

- b. Pasien dengan Nyeri Kronis:

Intervensi: Mengkombinasikan terapi farmakologis dengan teknik nonfarmakologis berbasis bukti seperti meditasi, terapi musik, atau distraksi untuk manajemen nyeri kronis secara efektif.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perencanaan

Implementasi perencanaan keperawatan adalah tahapan penting dalam proses keperawatan yang menentukan keberhasilan tindakan dan pencapaian tujuan perawatan yang diharapkan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada

berbagai faktor yang perlu dipahami dan dikelola dengan baik oleh seluruh tim kesehatan. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perencanaan keperawatan:

1. Kompetensi Perawat

Kompetensi perawat merupakan faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan implementasi perencanaan keperawatan. Kompetensi mencakup tiga komponen utama:

- a. Pengetahuan Teoritis: Perawat harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai konsep dasar keperawatan, teori keperawatan, anatomi dan fisiologi tubuh manusia, serta memahami bukti ilmiah terbaru.
- b. Keterampilan Praktis: Perawat harus mampu menerapkan teknik-teknik intervensi keperawatan secara terampil dan efektif dalam praktik sehari-hari.
- c. Kemampuan Interpersonal: Perawat harus mampu berkomunikasi secara empati dan efektif dengan pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lainnya.

Perawat dengan kompetensi yang baik akan mampu:

- a. Melaksanakan intervensi keperawatan dengan akurat dan efisien.
- b. Mengevaluasi hasil tindakan secara kritis dan objektif.
- c. Mengambil keputusan klinis yang tepat berdasarkan situasi pasien.

2. Keterlibatan Pasien dan Keluarga

Keterlibatan pasien dan keluarga merupakan aspek penting dalam keberhasilan perencanaan dan implementasi keperawatan. Partisipasi aktif dari pasien dan keluarganya memberikan dampak positif, seperti:

- a. Peningkatan Pemahaman: Pasien dan keluarga lebih memahami tujuan dan manfaat dari tindakan keperawatan yang diberikan.
- b. Komitmen Tinggi: Pasien lebih cenderung mematuhi dan mengikuti rencana perawatan secara konsisten.
- c. Penguatan Dukungan Sosial: Dukungan emosional dan sosial dari keluarga dapat meningkatkan kondisi psikologis pasien, membantu proses pemulihan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Strategi untuk meningkatkan keterlibatan pasien dan keluarga antara lain:

- a. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan berkelanjutan.
- b. Memberikan edukasi rutin tentang kondisi pasien dan rencana perawatan.
- c. Mengajak keluarga untuk terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait intervensi yang dipilih.

3. Ketersediaan Sumber Daya

Implementasi perencanaan keperawatan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, meliputi:

- a. Fasilitas: Ketersediaan fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai.
- b. Alat dan Perlengkapan: Ketersediaan alat medis yang memadai untuk mendukung tindakan keperawatan.
- c. Obat-obatan: Ketersediaan obat-obatan yang cukup dan sesuai kebutuhan.
- d. Tenaga Kesehatan: Jumlah tenaga perawat yang mencukupi, serta dukungan dari tim administrasi kesehatan.

Dengan sumber daya yang cukup, implementasi perencanaan keperawatan dapat dilakukan dengan optimal, tepat waktu, dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara signifikan.

4. Dukungan Tim Multidisiplin

Kolaborasi antarprofesi kesehatan dalam implementasi perencanaan keperawatan sangat penting karena masalah pasien sering kali kompleks dan memerlukan intervensi dari berbagai disiplin ilmu. Tim multidisiplin dapat mencakup:

- a. Dokter: Memberikan pandangan medis dan membantu dalam diagnosis serta pengobatan pasien.
- b. Ahli Gizi: Memberikan rekomendasi nutrisi sesuai dengan kondisi pasien.
- c. Fisioterapis: Memberikan terapi fisik yang mendukung mobilitas dan pemulihan pasien.
- d. Tenaga Kesehatan Lainnya: Bekerja sama untuk menyusun intervensi yang komprehensif.

Kolaborasi yang baik memastikan bahwa setiap tindakan bersifat terpadu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi perencanaan keperawatan.

5. Lingkungan Organisasi yang Kondusif

Lingkungan organisasi yang kondusif secara langsung mempengaruhi keberhasilan implementasi perencanaan keperawatan. Aspek lingkungan organisasi ini meliputi:

- a. Budaya Kerja: Budaya kerja yang mendorong pembelajaran berkelanjutan, inovasi, serta penerapan praktik berbasis bukti.
- b. Kepemimpinan Efektif: Pemimpin yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan mendukung tim keperawatan dalam melaksanakan perencanaan dan implementasi.
- c. Kebijakan dan Prosedur Jelas: Keberadaan kebijakan yang jelas, terstruktur, serta mendukung intervensi keperawatan.
- d. Sistem Penghargaan: Sistem penghargaan dan pengakuan yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan komitmen tenaga keperawatan.

Lingkungan organisasi yang baik akan menciptakan kondisi ideal yang memungkinkan perawat bekerja secara efektif dan profesional.

6. Pentingnya Memahami Faktor-Faktor Implementasi

Memahami faktor-faktor tersebut sangat penting bagi keberhasilan implementasi perencanaan keperawatan karena:

- a. Menjamin tercapainya tujuan perawatan dengan hasil klinis yang optimal.
- b. Mengurangi potensi kegagalan atau kesalahan dalam implementasi tindakan.
- c. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan.

F. Latihan Soal

1. Seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun masuk ruang perawatan dengan keluhan sesak napas berat. Pasien tampak pucat, bernapas cepat dengan frekuensi 32 kali/menit, saturasi oksigen 88%, dan suara napas wheezing. Dalam perencanaan keperawatan, masalah apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu oleh perawat?

- A. Risiko jatuh
- B. Ketidakseimbangan nutrisi
- C. Gangguan pertukaran gas
- D. Ansietas
- E. Gangguan tidur

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Pendekatan ABC (Airway, Breathing, Circulation) menuntut perawat untuk memprioritaskan masalah terkait gangguan pernapasan terlebih dahulu. Masalah gangguan pertukaran gas merupakan masalah fisiologis yang vital untuk segera diatasi.

2. Seorang pasien wanita berusia 45 tahun pasca operasi apendektomi mengeluhkan nyeri hebat dengan skala 8 dari skala 0-10. Apa tujuan keperawatan yang sesuai dengan kriteria SMART untuk mengatasi masalah nyeri pasien ini?

- A. Pasien bebas nyeri dalam waktu 1 jam
- B. Pasien mengurangi nyeri hingga skala 3 dalam waktu 4 jam setelah pemberian analgesik
- C. Pasien nyaman sepanjang hari ini
- D. Pasien mampu tidur dengan nyaman malam ini
- E. Pasien tidak lagi merasakan nyeri

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Tujuan yang dipilih jelas (spesifik), memiliki indikator (terukur), realistis (dapat dicapai), relevan dengan masalah pasien (relevan), serta memiliki batas waktu (time-bound) sehingga memenuhi kriteria SMART.

3. Seorang pasien berusia 70 tahun dirawat dengan diagnosis stroke. Pasien mengalami kelemahan sisi kanan tubuh dan sulit bergerak mandiri. Dalam memilih intervensi keperawatan yang tepat, aspek apa yang perlu dipertimbangkan agar efektif?

- A. Preferensi perawat
- B. Pengalaman pasien sebelumnya
- C. Nilai dan preferensi pasien serta keluarga
- D. Keinginan tim medis saja
- E. Jadwal dinas perawat

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Intervensi keperawatan harus memperhatikan preferensi pasien dan keluarga agar intervensi dapat diterima, dilaksanakan dengan baik, dan memiliki efektivitas tinggi.

4. Seorang pasien dengan riwayat diabetes melitus tipe 2 dirawat karena luka kaki diabetik yang berisiko infeksi. Pendekatan apa yang paling tepat digunakan perawat dalam menentukan prioritas masalah pada pasien ini?

- A. Pendekatan Hierarki Maslow
- B. Pendekatan ABC
- C. Pendekatan psikososial
- D. Pendekatan risiko
- E. Pendekatan ekonomi

Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Pendekatan risiko paling tepat untuk pasien ini karena masalah utama pasien adalah risiko tinggi infeksi luka yang bisa menyebabkan komplikasi serius.

5. Seorang perawat baru mengalami kesulitan menerapkan intervensi keperawatan di ruang perawatan intensif. Faktor manakah yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi perencanaan keperawatan dalam kasus ini?

- A. Ketersediaan alat-alat medis
- B. Kompetensi perawat
- C. Lokasi ruang perawatan

- D. Kondisi cuaca
- E. Warna cat ruang perawatan

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Kompetensi perawat adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi perencanaan keperawatan karena mencakup pengetahuan teoritis, keterampilan praktis, dan kemampuan interpersonal yang penting dalam melaksanakan intervensi secara efektif.

G. Rangkuman materi

Perencanaan keperawatan adalah tahap dalam proses keperawatan yang berfungsi menentukan prioritas masalah, tujuan yang jelas, serta intervensi tepat guna mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini merupakan penghubung antara tahap pengkajian dan implementasi, memastikan tindakan keperawatan terorganisir dan efektif. Keberhasilan perencanaan keperawatan tergantung pada pengetahuan teoritis, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan interpersonal perawat.

Tujuan utama perencanaan keperawatan mencakup penentuan prioritas masalah berdasarkan urgensi, merumuskan tujuan realistis, menentukan intervensi berbasis bukti (evidence-based practice), serta menyediakan pedoman konsisten dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.

Elemen utama perencanaan meliputi penentuan prioritas masalah, formulasi tujuan, dan pemilihan intervensi. Prioritas masalah dapat ditentukan dengan pendekatan hierarki kebutuhan Maslow, yang dimulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri; pendekatan ABC (Airway, Breathing, Circulation), untuk kondisi kritis yang mengancam nyawa; dan pendekatan risiko, yang memprioritaskan masalah berdasarkan potensi komplikasi atau dampak kualitas hidup pasien.

Formulasi tujuan yang efektif menggunakan kriteria SMART, yakni spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Hal ini memungkinkan evaluasi yang objektif serta meningkatkan motivasi pasien dan tim perawat.

Pemilihan intervensi harus berbasis bukti ilmiah, disesuaikan dengan kebutuhan klinis pasien, preferensi pasien dan keluarga, ketersediaan sumber daya, serta mempertimbangkan konteks klinik. Intervensi ini memastikan tindakan keperawatan efektif, efisien, dan diterima dengan baik oleh pasien.

Berpikir kritis adalah aspek penting dalam perencanaan keperawatan, melibatkan analisis informasi, evaluasi alternatif intervensi, serta pengambilan keputusan yang optimal berdasarkan bukti ilmiah. Keterampilan interpersonal perawat, seperti komunikasi empatik, kolaborasi tim multidisiplin, serta edukasi yang

efektif terhadap pasien dan keluarga, juga sangat mendukung keberhasilan perencanaan.

Implementasi perencanaan keperawatan dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya kompetensi perawat, keterlibatan aktif pasien dan keluarga, ketersediaan sumber daya yang memadai, dukungan tim multidisiplin, serta lingkungan organisasi yang kondusif. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara baik merupakan kunci keberhasilan implementasi tindakan keperawatan yang optimal.

H. Glosarium

Perencanaan Keperawatan

Tahap dalam proses keperawatan yang meliputi penentuan prioritas masalah, perumusan tujuan, serta pemilihan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan terbaik untuk memastikan efektivitas tindakan yang diberikan kepada pasien.

SMART

Kriteria penyusunan tujuan keperawatan yang mencakup Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), Dapat Dicapai (Achievable), Relevan (Relevant), dan Berbasis Waktu (Time-bound).

Hierarki Kebutuhan Maslow

Teori psikologi yang mengategorikan kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga tertinggi, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.

Pendekatan ABC (Airway, Breathing, Circulation)

Pendekatan prioritas klinis yang digunakan dalam kondisi darurat untuk memastikan jalan napas pasien terbuka, pernapasan efektif, dan sirkulasi darah stabil.

Pendekatan Risiko

Metode menentukan prioritas intervensi berdasarkan potensi komplikasi atau dampak yang serius terhadap keselamatan pasien atau kualitas hidupnya.

Berpikir Kritis dalam Keperawatan

Proses pengambilan keputusan klinis yang melibatkan analisis objektif data, evaluasi alternatif tindakan, dan pemilihan intervensi yang optimal berdasarkan bukti dan pengalaman klinis.

Komunikasi Empatik

Keterampilan interpersonal perawat yang memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap perasaan dan kebutuhan pasien melalui proses mendengarkan aktif dan empati.

Kolaborasi Tim Multidisiplin

Kerjasama efektif antara berbagai profesi kesehatan, seperti dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya, dalam merencanakan dan melaksanakan perawatan pasien.

Ketersediaan Sumber Daya

Keadaan di mana fasilitas, peralatan, tenaga kesehatan, serta dukungan administratif mencukupi untuk mendukung pelaksanaan intervensi keperawatan secara optimal.

Implementasi Perencanaan Keperawatan

Tahap pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang telah dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya seperti kompetensi perawat, keterlibatan pasien dan keluarga, serta dukungan lingkungan organisasi.

Outcome atau Kriteria Hasil

Parameter atau indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan keperawatan dalam jangka waktu tertentu.

I. Daftar pustaka

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Makic, M. B. F., Martinez-Kratz, M., & Zanotti, M. (2020). *Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care* (12th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2020). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Client Care Across the Life Span* (10th ed.). F. A. Davis Company.
- Gulanick, M., & Myers, J. L. (2021). *Nursing Care Plans: Diagnoses, Interventions, & Outcomes* (10th ed.). Elsevier.
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. Salemba Medika.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Stuart, G. W. (2018). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.

- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2018). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Care* (9th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Wilkinson, J. M., Treas, L. S., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2019). *Fundamentals of Nursing: Theory, Concepts & Applications* (4th ed.). F. A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of Nursing: Active Learning for Collaborative Practice* (2nd ed.). Elsevier Health Sciences.

BAB 7

PRAKTIK/PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH METODE ILMIAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH

Pendahuluan

Dalam dunia keperawatan, metode ilmiah menjadi fondasi yang penting dalam mengambil keputusan yang tepat guna menangani masalah pasien. Praktik metode ilmiah memungkinkan perawat untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien berdasarkan pendekatan ilmiah yang sistematis. Metode ini melibatkan serangkaian langkah yang jelas dan terstruktur, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi solusi. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah, perawat dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan serta mampu memberikan solusi berdasarkan bukti ilmiah yang kuat.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode ilmiah secara efektif dalam menghadapi masalah klinis keperawatan, guna meningkatkan kualitas asuhan yang berbasis bukti ilmiah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Memahami konsep dasar dan langkah-langkah metode ilmiah dalam konteks keperawatan.
- Mengaplikasikan metode ilmiah secara praktis dalam menyelesaikan masalah keperawatan.
- Mengembangkan solusi efektif yang didasarkan pada analisis data dan bukti ilmiah.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu:

- Mendeskripsikan secara lengkap langkah-langkah metode ilmiah: observasi, perumusan masalah, pengumpulan data, formulasi hipotesis, pengujian hipotesis, analisis data, dan penarikan kesimpulan.
- Mengidentifikasi masalah klinis dalam praktik keperawatan secara tepat dan spesifik.
- Melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan klinis.
- Menyusun hipotesis yang jelas berdasarkan analisis situasi dan kajian literatur ilmiah.
- Melakukan uji hipotesis melalui rancangan intervensi atau penelitian yang sistematis.
- Menggunakan metode analisis data kuantitatif maupun kualitatif secara tepat dalam konteks keperawatan.
- Menyimpulkan hasil analisis data dengan jelas serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

Uraian Materi

A. Praktik Langkah-Langkah Metode Ilmiah

Praktik penerapan langkah-langkah metode ilmiah dalam keperawatan mencakup beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Observasi dan Identifikasi Masalah

Observasi dan identifikasi masalah merupakan langkah krusial pertama dalam metode ilmiah keperawatan. Tahapan ini menjadi landasan untuk proses selanjutnya, oleh karena itu harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan sistematis. Berikut penjabarannya secara detail:

a. Observasi Kondisi Pasien secara Menyeluruh

Observasi yang sistematis dan komprehensif mencakup beberapa komponen penting:

- 1) Pemeriksaan fisik: Meliputi pengukuran tanda vital seperti suhu tubuh, denyut nadi, tekanan darah, dan laju pernapasan. Pemeriksaan fisik juga mencakup pemeriksaan kepala hingga kaki (head to toe assessment).
- 2) Evaluasi riwayat kesehatan pasien: Menggali informasi tentang riwayat penyakit pasien, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat alergi, serta riwayat sosial seperti pola hidup dan kebiasaan yang mungkin berkontribusi terhadap kondisi kesehatan saat ini.
- 3) Observasi perilaku dan kondisi psikologis pasien: Memantau ekspresi wajah, tingkat kecemasan, pola komunikasi, serta tanda-tanda lain yang menunjukkan status psikologis pasien.
- 4) Penilaian lingkungan sekitar pasien: Mengamati lingkungan fisik tempat pasien dirawat, termasuk kebersihan, pencahayaan, kebisingan, ventilasi, serta faktor lain yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan pasien.

Observasi harus dilakukan secara objektif, tanpa asumsi atau prasangka yang bisa mengurangi validitas data. Data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap, dan relevan, sehingga memudahkan proses identifikasi masalah berikutnya.

b. Identifikasi Masalah Berdasarkan Gejala dan Tanda Klinis

Setelah melakukan observasi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah secara spesifik berdasarkan gejala yang dialami pasien maupun tanda objektif dari hasil pemeriksaan:

- 1) Gejala subjektif: Keluhan pasien seperti nyeri, sesak napas, mual, pusing, dan lainnya. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasien.
- 2) Tanda objektif: Data hasil pemeriksaan fisik yang dapat diukur dan diamati, seperti suhu tubuh tinggi, tekanan darah rendah, peningkatan denyut jantung, dan sebagainya.

Proses identifikasi masalah ini perlu didokumentasikan secara jelas dan terstruktur, yang nantinya akan menjadi dasar dalam tahap pengumpulan data berikutnya serta pengambilan keputusan klinis.

c. Contoh Kasus:

Seorang pasien lansia berusia 75 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama sesak napas yang semakin memberat sejak dua hari terakhir. Hasil observasi yang dilakukan oleh perawat menunjukkan kondisi berikut:

- 1) Pasien tampak pucat, cemas, dan gelisah.
- 2) Pernapasan cepat dan dangkal (32 kali/menit).
- 3) Tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 108 kali/menit, saturasi oksigen menurun hingga 88%.
- 4) Pasien mengeluhkan sulit tidur akibat sesak napas.

Dari data observasi tersebut, perawat mengidentifikasi masalah klinis sebagai gangguan pola napas akibat penurunan saturasi oksigen, yang berpotensi menimbulkan komplikasi seperti hipoksia berat.

Dengan praktik observasi dan identifikasi masalah yang efektif dan detail, mahasiswa keperawatan akan mampu mengembangkan kemampuan analitis dan kritis, serta memastikan proses pemecahan masalah klinis berjalan secara sistematis dan berbasis bukti ilmiah yang kuat.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah tahap penting yang menentukan arah dan fokus penelitian atau intervensi klinis dalam praktik keperawatan. Langkah ini mengharuskan perawat untuk mendefinisikan masalah secara jelas, spesifik, dan terukur agar intervensi yang diberikan tepat sasaran serta efektif.

a. Definisi Masalah secara Jelas

Masalah klinis yang dihadapi pasien harus didefinisikan secara gamblang dan mudah dipahami. Dalam definisi masalah, perawat harus menjelaskan kondisi pasien secara akurat serta menyebutkan aspek-aspek penting yang menjadi perhatian dalam perawatan. Dengan definisi yang jelas, intervensi bisa diarahkan secara efektif dan efisien.

b. Masalah yang Spesifik

Masalah yang dirumuskan harus bersifat spesifik, tidak terlalu umum, dan mengarah pada aspek tertentu dari kondisi pasien yang perlu diatasi. Fokus yang spesifik membantu perawat untuk menentukan tindakan intervensi yang tepat dan relevan, serta menghindari generalisasi yang bisa mengurangi efektivitas perawatan.

c. Masalah yang Terukur

Masalah yang dirumuskan harus memiliki indikator pengukuran yang jelas, berupa tanda klinis, gejala subjektif pasien, hasil laboratorium, atau parameter lain yang bisa diukur secara objektif. Pengukuran tersebut memudahkan evaluasi keberhasilan intervensi yang dilakukan dan memastikan bahwa tindakan keperawatan berjalan efektif.

d. Langkah-Langkah dalam Merumuskan Masalah:

- 1) Identifikasi Kondisi Klinis: Menentukan masalah berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan pemeriksaan awal.
- 2) Menentukan Cakupan Masalah: Memilih aspek paling relevan dari kondisi pasien untuk difokuskan sebagai inti permasalahan.
- 3) Menguraikan Indikator Pengukuran: Menentukan indikator spesifik yang digunakan untuk menilai kondisi pasien, sehingga masalah tersebut dapat diukur secara objektif.

e. Contoh Detail Perumusan Masalah dalam Praktik Keperawatan:

Seorang pasien diabetes mellitus tipe 2 berusia 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan luka kaki diabetik yang belum sembuh selama tiga minggu terakhir. Berikut adalah perumusan masalah secara jelas, spesifik, dan terukur:

- 1) Jelas: Pasien mengalami luka kaki diabetik kronis yang disertai infeksi berulang.
- 2) Spesifik: Penyembuhan luka kaki pasien terhambat karena adanya infeksi bakteri yang terus-menerus muncul.
- 3) Terukur: Evaluasi dilakukan dengan indikator berikut:
 - a) Tingkat infeksi yang diukur melalui skor infeksi luka.
 - b) Luas luka diukur dalam sentimeter persegi (cm²).
 - c) Hasil pemeriksaan kultur mikroba untuk menentukan jenis bakteri dan resistensi antibiotik.

Dengan kemampuan merumuskan masalah secara sistematis ini, mahasiswa keperawatan akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, yang penting dalam proses pengambilan keputusan klinis. Kemampuan ini juga memastikan bahwa tindakan keperawatan yang diberikan berbasis bukti ilmiah dan optimal untuk pasien.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah keperawatan yang mendasari pengambilan keputusan klinis. Pada tahap ini, perawat harus mampu mengumpulkan data secara akurat, lengkap, dan relevan melalui berbagai metode yang tepat. Pemilihan metode pengumpulan data yang sesuai sangat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh serta efektivitas intervensi yang diberikan.

a. Metode Pengumpulan Data dalam Praktik Keperawatan:

1) Observasi Langsung

Observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan secara sistematis dan objektif terhadap pasien dan lingkungan sekitar. Metode ini penting untuk memperoleh data objektif berupa kondisi fisik, tanda-tanda vital, perilaku pasien, serta respons pasien terhadap intervensi yang diberikan.

2) Langkah-langkah Observasi Langsung:

- a) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan (misalnya termometer, tensimeter, stetoskop).
- b) Melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi fisik pasien seperti kondisi kulit, tanda vital (tekanan darah, suhu, denyut nadi, respirasi), dan gejala klinis yang muncul.
- c) Mencatat hasil observasi secara detail, jelas, dan objektif.

3) Contoh Observasi Langsung:

- a) Memantau tanda vital setiap 4 jam pada pasien dengan hipertensi akut.
- b) Mengobservasi ekspresi wajah, postur tubuh, serta pola tidur pasien yang mengalami nyeri kronis.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data subjektif melalui interaksi langsung antara perawat dengan pasien atau keluarganya. Tujuannya adalah mendapatkan informasi mendalam mengenai kondisi kesehatan, riwayat penyakit, pola hidup, serta persepsi pasien tentang masalah kesehatannya.

1) Langkah-langkah Wawancara Mendalam:

- a) Menyiapkan daftar pertanyaan terbuka dan terstruktur.
- b) Melakukan wawancara dengan pendekatan empati dan aktif mendengarkan.
- c) Mencatat informasi yang diberikan pasien secara lengkap dan terstruktur.

2) Contoh Wawancara Mendalam:

- a) Menanyakan pasien tentang riwayat pengobatan diabetes sebelumnya, pola makan sehari-hari, serta kebiasaan kebersihan luka pada pasien dengan luka diabetik.
- b) Menggali informasi tentang durasi, intensitas, dan faktor pemicu rasa sakit yang dialami pasien.

c. Kajian Dokumentasi

Kajian dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai sumber dokumen yang tersedia, seperti catatan medis pasien, laporan laboratorium, laporan

radiologi, serta catatan keperawatan sebelumnya. Data ini digunakan untuk mendukung analisis klinis serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang terdokumentasi.

1) Langkah-langkah Kajian Dokumentasi:

- a) Menentukan dokumen medis yang relevan dengan masalah klinis.
- b) Meninjau dokumen secara sistematis untuk mendapatkan data penting seperti hasil laboratorium, riwayat penyakit, dan hasil pengobatan sebelumnya.
- c) Mencatat informasi penting dari dokumentasi secara akurat dan jelas.

2) Contoh Kajian Dokumentasi:

- a) Menelaah hasil pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol pada pasien diabetes mellitus.
- b) Meninjau catatan medis sebelumnya untuk mengetahui respon pasien terhadap terapi antibiotik pada kasus infeksi berulang.

d. Langkah-Langkah Sistematis dalam Pengumpulan Data:

- 1) Menentukan Tujuan Pengumpulan Data: Memahami jenis informasi yang dibutuhkan.
- 2) Memilih Metode yang Tepat: Menentukan apakah menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam, atau kajian dokumentasi berdasarkan tujuan.
- 3) Melakukan Pengumpulan Data dengan Objektif: Memastikan data diperoleh tanpa bias dan mencatatnya secara jelas.
- 4) Memvalidasi Data: Memeriksa kembali keakuratan dan keandalan data.

e. Contoh Kasus Pengumpulan Data dalam Praktik Keperawatan:

Seorang pasien lansia penderita diabetes mellitus dirawat dengan keluhan luka kaki diabetik kronis yang sulit sembuh. Perawat melakukan:

- 1) Observasi Langsung: Memeriksa tanda vital, luas luka, tingkat infeksi, dan kondisi kulit sekitar luka.
- 2) Wawancara Mendalam: Menggali informasi terkait kebiasaan kebersihan luka, pola makan, dan riwayat pengobatan pasien.
- 3) Kajian Dokumentasi: Mengkaji hasil pemeriksaan laboratorium sebelumnya serta catatan medis untuk mengetahui respons terapi terdahulu.

Dengan melakukan pengumpulan data secara sistematis, mahasiswa keperawatan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analisis klinis, serta mampu memberikan keputusan klinis berbasis bukti yang tepat dan efektif bagi pasien.

4. Formulasi Hipotesis

Formulasi hipotesis merupakan tahapan krusial dalam metode ilmiah keperawatan. Pada tahap ini, perawat mengembangkan dugaan atau solusi awal yang dapat diuji secara empiris berdasarkan data klinis yang ada serta didukung oleh kajian literatur ilmiah yang relevan. Formulasi hipotesis menjadi landasan untuk menentukan arah intervensi klinis yang efektif dan akurat.

a. Pentingnya Formulasi Hipotesis dalam Praktik Keperawatan

Hipotesis yang diformulasikan secara jelas akan membantu perawat dalam menentukan fokus intervensi klinis, mengarahkan proses pengumpulan data lebih lanjut, serta mengevaluasi efektivitas intervensi secara sistematis. Hipotesis memungkinkan perawat untuk menguji dan membuktikan hubungan sebab-akibat yang ada dalam suatu kondisi klinis, sehingga intervensi yang dilakukan lebih terarah dan efektif.

b. Karakteristik Hipotesis yang Baik:

- 1) Jelas dan Spesifik: Hipotesis harus ditulis secara rinci dan eksplisit, sehingga dapat dimengerti dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.
- 2) Logis: Hipotesis harus memiliki dasar logika yang kuat dan menunjukkan hubungan sebab-akibat secara rasional.
- 3) Terukur: Hipotesis harus memuat parameter atau indikator yang jelas sehingga dapat diuji dan diukur secara objektif.
- 4) Didukung Literatur Ilmiah: Hipotesis harus dibangun berdasarkan hasil penelitian terbaru dan teori ilmiah yang relevan, sehingga memiliki validitas yang tinggi.

c. Langkah-langkah Formulasi Hipotesis:

1) Identifikasi Masalah Klinis

Tahap awal adalah mendefinisikan dengan jelas masalah klinis yang dialami pasien berdasarkan data hasil observasi dan pengumpulan data awal.

2) Kajian Literatur Ilmiah

Perawat melakukan penelusuran literatur ilmiah untuk menemukan informasi terkini yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi. Informasi ini dapat berasal dari jurnal penelitian, buku teks, atau panduan praktik klinis terbaru.

3) Pengembangan Hipotesis Awal

Setelah memperoleh pemahaman dari literatur ilmiah, perawat mengembangkan dugaan atau solusi awal yang relevan dengan permasalahan pasien. Dugaan ini menjadi dasar dalam formulasi hipotesis awal.

4) Penyusunan Hipotesis Akhir

Tahap akhir adalah menyusun hipotesis secara formal. Hipotesis harus diformulasikan secara jelas dalam bentuk pernyataan yang spesifik, logis, terukur, dan dapat diuji secara empiris.

d. Contoh Formulasi Hipotesis dalam Praktik Keperawatan:

Seorang pasien lansia berusia 68 tahun dengan diabetes mellitus tipe 2 mengalami luka kaki diabetik kronis yang sulit sembuh. Berdasarkan hasil pengumpulan data klinis, perawat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1) Identifikasi Masalah Klinis:

Pasien mengalami luka kaki diabetik kronis dengan infeksi berulang yang memperlambat proses penyembuhan.

2) Kajian Literatur Ilmiah:

Kajian terbaru menunjukkan bahwa infeksi berulang pada luka diabetik disebabkan oleh bakteri resisten terhadap antibiotik konvensional, sehingga memperlambat proses regenerasi jaringan dan penyembuhan luka.

3) Pengembangan Hipotesis Awal:

Luka diabetik pasien tidak sembuh karena adanya infeksi bakteri resisten yang memperlambat proses penyembuhan.

4) Penyusunan Hipotesis Akhir:

"Pemberian antibiotik yang spesifik sesuai hasil kultur mikroba dapat secara signifikan mempercepat proses penyembuhan luka diabetik pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2."

Dengan menerapkan langkah-langkah formulasi hipotesis secara sistematis ini, mahasiswa keperawatan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta meningkatkan kualitas intervensi klinis yang diberikan kepada pasien.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah tahap kritis dalam metode ilmiah keperawatan, di mana perawat secara sistematis mengimplementasikan intervensi atau penelitian untuk membuktikan efektivitas solusi yang telah dihipotesiskan sebelumnya. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada pasien memang efektif dan berdasarkan bukti ilmiah.

a. Pentingnya Pengujian Hipotesis dalam Praktik Keperawatan

Pengujian hipotesis merupakan proses kritis yang bertujuan memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar efektif dalam mengatasi masalah klinis. Proses ini membantu perawat dalam mengambil keputusan klinis berbasis bukti, sehingga dapat memberikan perawatan optimal yang terbukti secara ilmiah kepada pasien.

b. Langkah-langkah Pengujian Hipotesis

1) Perencanaan Intervensi

Pada tahap ini, perawat menentukan metode atau tindakan intervensi yang akan dilakukan berdasarkan karakteristik hipotesis dan kondisi klinis pasien. Perencanaan ini mencakup pemilihan metode, penentuan alat yang diperlukan, waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan intervensi.

2) Pelaksanaan Intervensi

Setelah merencanakan intervensi, perawat menjalankan intervensi tersebut secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah disusun. Intervensi dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi bias dan memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya.

3) Pengumpulan Data Hasil Intervensi

Perawat secara sistematis mengumpulkan data hasil intervensi menggunakan metode observasi langsung, wawancara, dan kajian dokumentasi. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan indikator atau parameter yang digunakan dalam hipotesis.

4) Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik atau analisis kualitatif yang sesuai. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan serta menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak.

5) Interpretasi dan Evaluasi Hasil

Perawat melakukan interpretasi hasil analisis secara kritis dan objektif untuk menentukan sejauh mana intervensi yang dilakukan efektif dalam menyelesaikan masalah klinis. Evaluasi ini membantu perawat dalam mengambil keputusan klinis selanjutnya, apakah intervensi tersebut layak untuk dilanjutkan, dimodifikasi, atau diganti dengan intervensi lain.

c. Contoh Detail Pengujian Hipotesis dalam Praktik Keperawatan

Seorang pasien lansia dengan luka kaki diabetik kronis dirawat karena luka yang sulit sembuh. Hipotesis yang telah diformulasikan adalah bahwa pemberian antibiotik khusus berdasarkan hasil kultur mikroba dapat mempercepat penyembuhan luka. Tahapan pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut:

1) Perencanaan Intervensi:

- a) Menentukan jenis antibiotik yang spesifik berdasarkan hasil kultur mikroba.
- b) Menentukan dosis, cara pemberian, serta frekuensi pemberian antibiotik.

2) Pelaksanaan Intervensi:

- a) Melaksanakan pemberian antibiotik secara konsisten sesuai rencana, misalnya pemberian antibiotik setiap 8 jam selama 2 minggu.
- b) Memastikan kepatuhan pasien terhadap intervensi yang diberikan.

3) Pengumpulan Data Hasil Intervensi:

- a) Melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi luka setiap hari, termasuk luas luka, tingkat infeksi, dan tanda-tanda inflamasi.
- b) Mengukur tanda-tanda vital secara rutin untuk memonitor respons pasien terhadap antibiotik.
- c) Melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui pengalaman subjektif pasien selama intervensi.

4) Analisis Data:

- a) Menggunakan analisis statistik untuk membandingkan kondisi luka sebelum dan setelah intervensi.
- b) Melakukan analisis kualitatif berdasarkan wawancara pasien tentang persepsi terhadap proses penyembuhan.

5) Interpretasi dan Evaluasi:

- a) Menyimpulkan apakah ada perbaikan signifikan pada luka berdasarkan hasil analisis data.
- b) Menentukan efektivitas pemberian antibiotik berdasarkan hasil intervensi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil.

Melalui penguasaan langkah-langkah pengujian hipotesis ini, mahasiswa keperawatan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analitis, serta memberikan intervensi yang berbasis bukti ilmiah untuk hasil klinis yang optimal

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam metode ilmiah keperawatan, yang berfungsi untuk mengolah, mengevaluasi, dan memahami data hasil intervensi secara sistematis. Melalui analisis data, perawat mampu menarik kesimpulan valid tentang efektivitas intervensi serta menentukan langkah-langkah klinis berikutnya.

a. Pentingnya Analisis Data dalam Praktik Keperawatan

Analisis data membantu perawat untuk menentukan apakah intervensi klinis berhasil atau memerlukan penyesuaian. Analisis yang tepat dan akurat memungkinkan perawat untuk mengevaluasi secara mendalam efektivitas intervensi, mengidentifikasi area perbaikan, dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti.

b. Jenis-Jenis Data dalam Praktik Keperawatan

- 1) Data Kuantitatif: Data berupa angka atau nilai numerik yang dapat diukur atau dihitung secara objektif, seperti tekanan darah, suhu tubuh, kadar gula darah, atau skala nyeri.
 - 2) Data Kualitatif: Data deskriptif yang berupa informasi subjektif dari pasien seperti persepsi, pengalaman, perasaan, dan respons pasien terhadap intervensi.
- c. Alat Analisis Data dalam Praktik Keperawatan
- 1) Analisis Statistik

Analisis statistik digunakan untuk mengevaluasi data kuantitatif secara objektif. Teknik analisis statistik mencakup:

 - a) Statistik Deskriptif: Menyajikan gambaran umum data seperti mean (rata-rata), median (nilai tengah), modus (nilai yang sering muncul), serta standar deviasi dan rentang sebagai ukuran penyebaran.
 - b) Statistik Inferensial: Menarik kesimpulan dari data sampel ke populasi yang lebih besar dengan menggunakan teknik seperti uji-t, ANOVA, uji chi-square, dan analisis regresi.
 - 2) Analisis Non-Statistik (Kualitatif)

Analisis non-statistik digunakan untuk mengevaluasi data kualitatif yang lebih bersifat subjektif dan deskriptif. Teknik ini meliputi:

 - a) Analisis Isi (Content Analysis): Mengorganisir data berdasarkan kategori tertentu untuk menemukan tema utama.
 - b) Analisis Naratif: Menginterpretasikan cerita atau pengalaman pribadi pasien untuk memahami makna dan konteks klinisnya.
 - c) Analisis Tematik: Mengidentifikasi pola atau tema dari data kualitatif yang mendalam untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang masalah yang dihadapi pasien.
- d. Langkah-langkah Analisis Data dalam Praktik Keperawatan
- 1) Menentukan Jenis Data

Perawat menentukan apakah data yang terkumpul bersifat kuantitatif atau kualitatif untuk memudahkan pemilihan metode analisis yang tepat.
 - 2) Memilih Metode Analisis yang Tepat

Berdasarkan jenis data, perawat memilih teknik analisis statistik atau non-statistik yang relevan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan relevan dengan tujuan analisis.
 - 3) Melaksanakan Analisis Data

Perawat melakukan analisis dengan mengikuti prosedur analisis yang sistematis dan objektif, menggunakan alat dan teknik analisis yang dipilih.
 - 4) Menginterpretasikan Hasil Analisis

Interpretasi hasil analisis dilakukan secara kritis dan mendalam untuk memahami implikasi klinisnya. Interpretasi ini membantu perawat menentukan efektivitas intervensi dan memberikan dasar untuk keputusan klinis lebih lanjut.

e. Contoh Detail Analisis Data dalam Praktik Keperawatan

Seorang pasien lansia dengan luka diabetik kronis menjalani intervensi pemberian antibiotik spesifik berdasarkan hasil kultur mikroba. Berikut adalah contoh detail dari proses analisis data:

1) Analisis Statistik:

- a) Statistik Deskriptif: Menghitung perubahan rata-rata luas luka sebelum dan sesudah intervensi untuk menilai tren perbaikan.
- b) Statistik Inferensial: Menggunakan uji-t untuk mengevaluasi apakah perubahan luas luka secara signifikan berbeda sebelum dan sesudah pemberian antibiotik.

2) Analisis Non-Statistik:

Analisis Tematik: Melakukan wawancara mendalam dan menganalisis persepsi pasien mengenai proses penyembuhan luka, efek samping pengobatan, serta kenyamanan pasien selama perawatan.

3) Interpretasi dan Evaluasi:

- a) Menyimpulkan efektivitas antibiotik berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif.
- b) Mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil intervensi dan memberikan rekomendasi klinis untuk perawatan lanjutan.

Dengan penguasaan langkah-langkah analisis data yang komprehensif ini, mahasiswa keperawatan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang tinggi, sehingga mampu memberikan asuhan keperawatan yang optimal, efektif, dan berbasis bukti ilmiah.

B. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari metode ilmiah keperawatan yang sangat menentukan dalam menilai hasil dari suatu intervensi klinis. Tahap ini melibatkan interpretasi data yang telah dianalisis sebelumnya, serta memberikan rekomendasi yang jelas dan berbasis bukti untuk praktik klinis selanjutnya.

1. Pentingnya Penarikan Kesimpulan dalam Praktik Keperawatan

Penarikan kesimpulan memungkinkan perawat untuk mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas intervensi yang dilakukan. Dengan kesimpulan yang akurat dan jelas, perawat dapat mengambil keputusan klinis berbasis bukti serta meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan melalui rekomendasi yang tepat.

2. Langkah-langkah Penarikan Kesimpulan dalam Praktik Keperawatan

a. Merumuskan Kesimpulan Berdasarkan Hasil Analisis Data

Perawat harus mampu merangkum hasil analisis secara objektif dan sistematis, yang meliputi:

- 1) Menyajikan ringkasan objektif dari hasil analisis data.
- 2) Menentukan apakah hipotesis awal terbukti benar atau salah berdasarkan data.
- 3) Mengidentifikasi temuan-temuan penting yang mempengaruhi hasil intervensi.

b. Memberikan Rekomendasi Berbasis Bukti Ilmiah

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, perawat harus mengembangkan rekomendasi yang jelas dan spesifik, mencakup:

- 1) Penggunaan hasil analisis dan kesimpulan sebagai dasar untuk rekomendasi klinis.
- 2) Penyusunan rekomendasi yang realistis, spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan.
- 3) Fokus pada peningkatan kualitas praktik keperawatan.

3. Contoh Detail Penarikan Kesimpulan dalam Praktik Keperawatan

Kasus: Seorang pasien lansia dengan luka diabetik kronis menjalani intervensi berupa pemberian antibiotik spesifik berdasarkan hasil kultur mikroba. Hasil analisis data mencakup pengukuran luas luka, tingkat infeksi, serta persepsi pasien.

a. Merumuskan Kesimpulan:

- 1) Objektif dan Sistematis: Hasil statistik menunjukkan bahwa luas luka pasien berkurang secara signifikan setelah pemberian antibiotik spesifik.
- 2) Validasi Hipotesis: Hipotesis bahwa pemberian antibiotik berdasarkan kultur mikroba mempercepat penyembuhan luka terbukti benar.
- 3) Temuan Penting Lainnya: Analisis kualitatif menunjukkan pasien merasa lebih nyaman, puas, dan kooperatif selama menjalani perawatan.

b. Memberikan Rekomendasi Berbasis Bukti:

- 1) Rekomendasi Klinis: Menetapkan penggunaan antibiotik berdasarkan hasil kultur mikroba sebagai standar baku dalam penanganan luka diabetik kronis.
- 2) Rekomendasi Edukasi: Mengusulkan pelaksanaan pelatihan lanjutan bagi perawat tentang praktik perawatan luka modern yang berbasis bukti, agar perawatan luka menjadi lebih efektif.

- 3) Rekomendasi Monitoring: Menyarankan evaluasi rutin terhadap kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi antibiotik guna mencegah resistensi bakteri serta meningkatkan efektivitas pengobatan.

Dengan penguasaan penarikan kesimpulan yang detail dan sistematis ini, mahasiswa keperawatan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta meningkatkan kualitas praktik keperawatan secara signifikan dan berbasis bukti ilmiah.

C. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki, usia 68 tahun, dirawat dengan keluhan luka diabetik di kaki yang tidak sembuh selama sebulan. Hasil observasi: pasien tampak lesu, luka tampak kemerahan dengan sekret purulen, suhu tubuh 38,5°C, denyut nadi 96 kali/menit, tekanan darah 130/80 mmHg. Apa langkah pertama yang harus dilakukan perawat dalam metode ilmiah keperawatan?
- A. Mengambil sampel luka untuk kultur
 - B. Mengukur luas luka secara detail
 - C. Melakukan wawancara mendalam
 - D. Menentukan hipotesis penyebab luka
 - E. Melakukan analisis statistik data observasi

Kunci Jawaban: C. Melakukan wawancara mendalam

Pembahasan:

Langkah pertama dalam metode ilmiah adalah observasi dan identifikasi masalah secara menyeluruh. Selain pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, perawat perlu wawancara mendalam untuk menggali data subjektif terkait riwayat luka, pola perawatan sebelumnya, dan kebiasaan pasien yang mungkin berkontribusi terhadap lambatnya penyembuhan luka.

2. Seorang perempuan, usia 75 tahun, masuk RS dengan sesak napas yang berat. Pemeriksaan menunjukkan pernapasan 34 kali/menit, saturasi oksigen 87%, tekanan darah 120/75 mmHg, denyut nadi 110 kali/menit. Apa perumusan masalah keperawatan yang paling tepat?
- A. Pasien mengalami sesak napas
 - B. Pasien mengalami hipoksia
 - C. Gangguan pola napas akibat hipoksia
 - D. Pasien mengalami kegagalan pernapasan akut
 - E. Pasien cemas akibat gangguan napas

Kunci Jawaban: C. Gangguan pola napas akibat hipoksia

Pembahasan:

Perumusan masalah dalam metode ilmiah harus jelas, spesifik, dan terukur. Gangguan pola napas akibat hipoksia memenuhi kriteria ini karena mencakup kondisi pasien (gangguan pola napas) dan penyebab spesifik (hipoksia yang ditandai saturasi oksigen rendah).

3. Pasien laki-laki, usia 60 tahun, mengalami luka diabetik kronis. Perawat mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung, dan kajian dokumentasi medis. Apa tujuan utama penggunaan metode kajian dokumentasi dalam kasus ini?
- A. Memperoleh persepsi subjektif pasien tentang luka
 - B. Mengumpulkan data tanda vital secara langsung
 - C. Menilai respons pasien terhadap terapi sebelumnya
 - D. Menentukan hipotesis intervensi keperawatan
 - E. Melakukan analisis statistik hasil intervensi

Kunci Jawaban: C. Menilai respons pasien terhadap terapi sebelumnya

Pembahasan:

Kajian dokumentasi bertujuan mendapatkan data terdokumentasi yang penting seperti respons pasien terhadap terapi sebelumnya. Ini penting untuk menentukan efektivitas intervensi sebelumnya serta rencana perawatan lanjutan yang tepat.

4. Pasien perempuan, usia 70 tahun, menderita hipertensi kronis dengan tekanan darah saat ini 170/95 mmHg. Hipotesis yang diajukan adalah pemberian edukasi diet rendah garam akan menurunkan tekanan darah pasien secara signifikan. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan perawat?
- A. Melakukan observasi tanda vital
 - B. Melakukan wawancara tentang pola makan
 - C. Mengimplementasikan edukasi diet rendah garam
 - D. Melakukan analisis data hasil edukasi
 - E. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil edukasi

Kunci Jawaban: C. Mengimplementasikan edukasi diet rendah garam

Pembahasan:

Setelah formulasi hipotesis, langkah berikutnya dalam metode ilmiah adalah menguji hipotesis dengan mengimplementasikan intervensi yang direncanakan, dalam hal ini edukasi diet rendah garam, untuk mengetahui apakah benar-benar efektif.

5. Seorang pasien lansia, usia 72 tahun, menjalani intervensi perawatan luka diabetik dengan antibiotik khusus selama dua minggu. Setelah intervensi, luas luka menurun dari 10 cm² menjadi 4 cm². Apa tahap metode ilmiah berikutnya yang harus dilakukan perawat?
- A. Melakukan observasi tanda vital pasien
 - B. Melakukan wawancara tentang kenyamanan pasien
 - C. Menentukan perumusan masalah baru
 - D. Melakukan analisis data hasil intervensi
 - E. Mengidentifikasi masalah klinis lain

Kunci Jawaban: D. Melakukan analisis data hasil intervensi

Pembahasan:

Setelah intervensi selesai dilakukan dan data hasil intervensi dikumpulkan (penurunan luas luka), langkah berikutnya adalah analisis data untuk mengevaluasi efektivitas intervensi secara statistik dan kualitatif guna menarik kesimpulan valid tentang hasil perawatan tersebut.

D. Rangkuman materi

Praktik metode ilmiah dalam keperawatan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah klinis secara ilmiah dan berbasis bukti. Proses ini diawali dengan observasi dan identifikasi masalah, di mana perawat melakukan observasi mendalam terhadap kondisi pasien secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan fisik, evaluasi riwayat kesehatan, observasi kondisi psikologis, serta penilaian lingkungan pasien. Selanjutnya, data hasil observasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah secara spesifik berdasarkan gejala subjektif yang dirasakan pasien dan tanda objektif hasil pemeriksaan.

Setelah observasi, langkah berikutnya adalah perumusan masalah, di mana perawat mendefinisikan masalah klinis dengan jelas, spesifik, serta memiliki indikator pengukuran yang objektif. Perumusan yang tepat akan membantu menentukan intervensi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi langsung untuk memperoleh data objektif pasien, wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi subjektif mengenai persepsi dan pengalaman pasien, serta kajian dokumentasi medis untuk memperoleh informasi tambahan dari catatan kesehatan pasien sebelumnya.

Setelah data terkumpul, perawat melakukan formulasi hipotesis dengan merancang dugaan atau solusi awal berdasarkan analisis data dan kajian literatur ilmiah terbaru. Hipotesis yang baik harus jelas, spesifik, logis, terukur, serta didukung oleh bukti ilmiah. Tahapan selanjutnya adalah pengujian hipotesis, di mana perawat

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi klinis secara sistematis untuk menentukan efektivitas tindakan yang dilakukan. Data hasil intervensi yang terkumpul kemudian dianalisis melalui metode analisis statistik untuk data kuantitatif, atau analisis tematik untuk data kualitatif, agar dapat menginterpretasikan secara tepat efektivitas intervensi tersebut.

Terakhir, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum hasil analisis secara objektif dan menentukan validitas hipotesis yang diajukan. Kesimpulan ini menjadi dasar penting dalam memberikan rekomendasi klinis yang jelas dan berbasis bukti, seperti rekomendasi tindakan intervensi lanjutan, pelaksanaan edukasi keperawatan, atau pemantauan rutin untuk memastikan perawatan yang efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah ini secara komprehensif dan terstruktur, mahasiswa keperawatan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang berbasis bukti ilmiah.

E. Glosarium

Analisis Data: Proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil intervensi klinis untuk mengevaluasi efektivitas intervensi serta menentukan keputusan klinis selanjutnya, baik menggunakan pendekatan statistik maupun non-statistik.

Analisis Inferensial: Analisis statistik yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data sampel ke populasi lebih luas, misalnya uji-t, ANOVA, dan uji chi-square.

Analisis Kualitatif: Metode analisis data yang menitikberatkan pada informasi deskriptif, naratif, atau persepsi pasien, seperti analisis isi, naratif, dan tematik.

Analisis Statistik: Proses pengolahan data kuantitatif secara sistematis menggunakan teknik statistik untuk menentukan gambaran umum atau kesimpulan ilmiah yang objektif.

Data Kualitatif: Informasi subjektif berupa persepsi, pengalaman, atau perasaan pasien yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau observasi perilaku.

Data Kuantitatif: Data numerik yang diperoleh dari pengukuran objektif seperti tekanan darah, suhu tubuh, kadar gula darah, atau intensitas nyeri.

Evaluasi Hasil Intervensi: Proses interpretasi kritis terhadap hasil analisis data untuk menentukan apakah intervensi yang dilakukan efektif dan memenuhi tujuan klinis yang telah ditetapkan.

Formulasi Hipotesis: Tahap dalam metode ilmiah keperawatan yang berupa pembuatan dugaan awal yang jelas, spesifik, logis, terukur, serta didukung oleh literatur ilmiah untuk diuji secara empiris.

Gejala Subjektif: Keluhan atau gejala yang dirasakan dan dilaporkan oleh pasien, misalnya nyeri, sesak napas, atau mual, yang tidak dapat diukur langsung secara objektif.

Hipotesis: Dugaan atau solusi awal yang disusun berdasarkan identifikasi masalah klinis serta literatur ilmiah, yang selanjutnya diuji melalui intervensi klinis atau penelitian.

Identifikasi Masalah: Proses penentuan masalah klinis secara spesifik berdasarkan hasil observasi kondisi pasien, mencakup gejala subjektif dan tanda objektif.

Intervensi Keperawatan: Tindakan atau strategi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perawat untuk mengatasi masalah klinis pasien berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan.

Kajian Dokumentasi: Pengumpulan data dari catatan medis, hasil laboratorium, radiologi, atau dokumentasi perawatan sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

Observasi: Tahapan pengamatan sistematis terhadap kondisi pasien, perilaku, lingkungan, dan tanda vital yang dilakukan secara objektif tanpa prasangka.

Observasi Langsung: Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap kondisi fisik pasien, perilaku, serta respons pasien terhadap intervensi yang diberikan.

Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir metode ilmiah keperawatan yang merangkum hasil analisis data secara objektif serta memberikan rekomendasi klinis yang berbasis bukti.

Pengujian Hipotesis: Proses sistematis penerapan intervensi yang dirancang untuk membuktikan efektivitas solusi atau dugaan awal (hipotesis) terhadap masalah klinis pasien.

Perumusan Masalah: Proses pendefinisian masalah klinis secara jelas, spesifik, dan terukur, yang menjadi dasar penentuan fokus intervensi serta evaluasi keberhasilan perawatan.

Statistik Deskriptif: Metode analisis statistik yang menggambarkan gambaran umum data, seperti rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan rentang data.

Tanda Objektif: Data hasil pemeriksaan fisik yang dapat diukur secara objektif, seperti suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, respirasi, serta tanda klinis lainnya.

Validasi Data: Proses pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, serta keandalannya dalam mendukung keputusan klinis.

Wawancara Mendalam: Metode pengumpulan data dengan berinteraksi langsung bersama pasien atau keluarga pasien untuk memperoleh informasi subjektif mengenai riwayat kesehatan, persepsi pasien, serta pola hidup yang relevan dengan masalah kesehatan.

F. Daftar pustaka

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., & Flynn Makic, M. B. (2020). *Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care* (12th ed.). Elsevier.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Client Care Across the Life Span* (10th ed.). F.A. Davis Company.
- Grove, S. K., & Gray, J. R. (2019). *Understanding Nursing Research: Building an Evidence-Based Practice* (7th ed.). Elsevier.
- LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2018). *Nursing Research: Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice* (9th ed.). Elsevier.
- Nieswiadomy, R. M., & Bailey, C. (2018). *Foundations of Nursing Research* (7th ed.). Pearson.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). *Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice* (10th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2021). *Evidence-Based Practice for Nurses: Appraisal and Application of Research* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.

BAB 8

KONSEP PROSES KEPERAWATAN

Pendahuluan:

Proses keperawatan merupakan pendekatan sistematis yang digunakan oleh perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif, efisien, dan berbasis bukti. Pendekatan ini mencakup lima tahapan utama, yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap pengkajian berfungsi untuk mengumpulkan data pasien secara komprehensif sebagai dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan. Selanjutnya, diagnosis keperawatan dirumuskan berdasarkan respons pasien terhadap masalah kesehatannya, yang kemudian menjadi acuan dalam perencanaan intervensi yang tepat dan realistis. Implementasi dilakukan dengan melaksanakan intervensi yang telah dirancang, sementara evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diberikan serta melakukan modifikasi jika diperlukan.

Di Indonesia, proses keperawatan didukung oleh Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). SDKI membantu dalam menentukan masalah keperawatan yang berbasis bukti, SLKI digunakan untuk mengukur hasil asuhan keperawatan, dan SIKI memberikan panduan intervensi yang sesuai dengan diagnosis pasien. Ketiga standar tersebut telah dirumuskan oleh organisasi profesi Keperawatan yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Penerapan proses keperawatan memberikan manfaat bagi pasien dan tenaga keperawatan. Bagi pasien, pendekatan ini memastikan bahwa asuhan keperawatan diberikan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai kebutuhan individu. Bagi perawat, proses ini meningkatkan kemandirian profesional, keterampilan pengambilan keputusan, serta mendukung praktik berbasis bukti. Dengan menerapkan proses keperawatan yang konsisten dan menggunakan pedoman SDKI, SLKI, serta SIKI, diharapkan pelayanan keperawatan menjadi lebih optimal serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Buku ini dirumuskan untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dan memberikan pemahaman mendalam tentang proses keperawatan serta bagaimana

proses ini diterapkan dalam praktik asuhan keperawatan. Setelah mempelajari buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami konsep dasar proses keperawatan, menguasai tahapan-tahapan dalam proses keperawatan, serta menerapkannya dalam berbagai konteks klinis untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang berbasis bukti dan etika profesi. Sasaran utama dari buku ini adalah mahasiswa keperawatan tingkat dasar hingga lanjut, perawat profesional, serta tenaga pendidik di bidang keperawatan yang ingin memperdalam pemahaman mengenai proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah keperawatan.

Buku ini disusun secara sistematis dan terdiri dari beberapa bab yang mencakup berbagai aspek penting dalam proses keperawatan. Bab pertama membahas pengertian dan prinsip dasar proses keperawatan, termasuk sejarah perkembangan konsep ini. Bab kedua menjelaskan secara rinci lima tahapan utama dalam proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Bab selanjutnya menguraikan manfaat penerapan proses keperawatan bagi pasien, perawat, dan institusi kesehatan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bagaimana proses keperawatan berfungsi sebagai metode penyelesaian masalah keperawatan serta membandingkannya dengan metode ilmiah dalam konteks penyelesaian masalah kesehatan.

Untuk memfasilitasi pembelajaran, buku ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif. Materi disajikan dalam bentuk teks yang dilengkapi dengan ilustrasi, studi kasus, dan latihan soal guna membantu pembaca dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang dibahas. Pendekatan pembelajaran yang digunakan meliputi pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan analisis, pembelajaran aktif dengan studi kasus dan diskusi, serta pembelajaran kolaboratif yang mendorong kerja sama tim dalam menerapkan proses keperawatan.

Tujuan Intruksional :

- Tujuan Umum : Setelah mempelajari buku ajar "Konsep Proses Keperawatan", pembelajar diharapkan mampu memahami dan menerapkan proses keperawatan sebagai metode sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas serta berbasis bukti untuk meningkatkan kesehatan pasien.
- Tujuan Khusus :
 - Menjelaskan pengertian dan prinsip dasar proses keperawatan
 - Menguraikan lima tahapan utama dalam proses keperawatan: pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi
 - Mengidentifikasi manfaat proses keperawatan bagi pasien, perawat, dan institusi kesehatan
 - Menerapkan Proses Keperawatan sebagai Metode Penyelesaian Masalah

- Membandingkan Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan dalam Penyelesaian Masalah

Capaian Pembelajaran:

Capaian Pembelajaran luaran (CPL) :

- Mampu memahami keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan (CPL.O2)
- Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim (CPL.O3)
- Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi (CPL.O5)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :

- Memahami konsep dasar proses keperawatan sebagai pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan berbasis bukti. (CPL.O2)
- Menerapkan keterampilan komunikasi terapeutik dalam proses keperawatan untuk meningkatkan hubungan perawat-klien serta mendukung kerja tim yang efektif. (CPL.O3)
- Melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan memperhatikan keselamatan klien, mutu pelayanan, serta prinsip caring sesuai kode etik profesi. (CPL.O5)

Sub-CPMK :

- Memahami konsep dasar dan manfaat proses keperawatan (CPL.O2)
 - Menjelaskan pengertian dan prinsip dasar proses keperawatan.
 - Mengidentifikasi manfaat proses keperawatan dalam praktik klinis dan pengambilan keputusan keperawatan.
- Menganalisis tahapan proses keperawatan dalam asuhan keperawatan profesional (CPL.O3)
 - Menguraikan lima tahapan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi).
 - Menjelaskan langkah-langkah dalam setiap tahapan proses keperawatan dan keterkaitannya dalam praktik klinis.
- Menerapkan proses keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas (CPL.O5)

- Menggunakan pendekatan proses keperawatan dalam menangani masalah keperawatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- Mengevaluasi penerapan proses keperawatan dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan.
- Mengintegrasikan prinsip caring dan kode etik profesi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.

Uraian Materi

Uraian materi dalam BAB ini membahas konsep proses keperawatan sebagai pendekatan sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan. Pembahasan dimulai dengan pengertian proses keperawatan, yang menjelaskan peranannya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dijelaskan tahapan proses keperawatan, yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, serta kaitannya dengan SDKI, SLKI, dan SIKI sebagai standar praktik di Indonesia. Selain itu, buku ini menguraikan manfaat proses keperawatan, baik bagi pasien, perawat, maupun institusi kesehatan, serta bagaimana pendekatan ini digunakan sebagai metode penyelesaian masalah keperawatan. Terakhir, dibahas perbandingan antara metode ilmiah dan proses keperawatan, menyoroti persamaan dan perbedaannya dalam penyelesaian masalah klinis. Buku ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menerapkan proses keperawatan secara profesional.

A. Pengertian Proses Keperawatan

Proses keperawatan merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien, merencanakan intervensi yang sesuai, melaksanakan tindakan keperawatan, serta mengevaluasi hasil dari intervensi yang telah dilakukan. Sebagai suatu metode berbasis ilmiah, proses keperawatan tidak hanya membantu perawat dalam memberikan pelayanan yang lebih terstruktur tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah dalam perawatan didasarkan pada bukti dan standar praktik profesional (Potter & Perry, 2021).

Menurut Potter dan Perry (2021), proses keperawatan terdiri dari lima tahapan utama, yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap pengkajian merupakan langkah awal dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai kondisi pasien, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Data yang dikumpulkan pada tahap ini menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam proses keperawatan. Selanjutnya, perawat melakukan diagnosis keperawatan berdasarkan analisis data yang telah diperoleh. Diagnosis ini berfokus pada respons pasien terhadap masalah kesehatannya dan menjadi dasar dalam merancang rencana asuhan keperawatan (NANDA International, 2020).

Tahap perencanaan melibatkan penyusunan strategi intervensi keperawatan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi. Rencana keperawatan ini harus bersifat realistis, terukur, dan

dapat dievaluasi. Implementasi merupakan tahap di mana perawat melaksanakan intervensi yang telah direncanakan untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan kesehatannya. Akhirnya, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diterapkan. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, maka proses keperawatan harus dikaji ulang dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pasien (Doenges, Moorhouse, & Murr, 2019).

Sebagai bentuk standar dokumentasi keperawatan di Indonesia, digunakan tiga sistem utama, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). SDKI berisi daftar diagnosis keperawatan yang berbasis bukti ilmiah dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan masalah keperawatan pasien. SLKI berfungsi untuk mengukur luaran dari asuhan keperawatan yang diberikan, memastikan bahwa intervensi yang dilakukan telah mencapai hasil yang diharapkan. SIKI memberikan panduan bagi perawat dalam melaksanakan intervensi yang tepat sesuai dengan diagnosis yang telah ditetapkan (PPNI, 2020).

Penerapan proses keperawatan memiliki berbagai manfaat, baik bagi pasien maupun tenaga keperawatan. Bagi pasien, pendekatan ini memastikan bahwa asuhan keperawatan diberikan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Sementara itu, bagi perawat, proses keperawatan membantu dalam meningkatkan kemandirian profesional, keterampilan pengambilan keputusan, serta mendukung standar praktik berbasis bukti (Taylor, Lillis, & Lynn, 2020). Dengan memahami dan menerapkan proses keperawatan secara konsisten serta menggunakan pedoman SDKI, SLKI, dan SIKI, diharapkan pelayanan keperawatan yang diberikan dapat lebih optimal dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien.

B. Tahapan Proses Keperawatan

Tahapan proses keperawatan terdiri dari 5 langkah kerja yang sistematis dan komprehensif. Langkah kerja proses keperawatan adalah sebagai berikut :

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan langkah awal dan fundamental dalam proses keperawatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi lengkap mengenai kondisi kesehatan pasien secara holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan serta penyusunan rencana asuhan keperawatan yang sesuai (Potter & Perry, 2021). Pengkajian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi yang akurat dan holistik sehingga dapat diperoleh Batasan karakteristik

data yang mengarahkan pada masalah keperawatan (PPNI, 2020). Proses pengkajian dapat dilakukan dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara (Anamnesis): Bertujuan untuk menggali informasi riwayat kesehatan, keluhan utama, dan faktor risiko. Dilakukan dengan pendekatan komunikasi terapeutik agar pasien merasa nyaman. Sumber data yang dapat diwawancarai adalah pasien, keluarga, dan pelaku rawat (*Care Giver*).
- b. Pemeriksaan Fisik: Pemeriksaan yang dilakukan perawat secara langsung kepada pasien, dengan menggunakan teknik *inspeksi* (melihat), *palpasi* (meraba), *perkusi* (memukul), dan *auskultasi* (mendengar) untuk mengidentifikasi kondisi fisik pasien. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan secara langsung berfokus pada area yang dikeluhkan pasien atau secara menyeluruh dari ujung kepala hingga ujung kaki (*Head to Toe*). Contoh : pemeriksaan jantung dan paru-paru untuk menilai fungsi kardiopulmoner, pemeriksaan abdomen untuk mengetahui bising usus, ada tidaknya pembengkakan atau kekakuan, dan lain-lain.
- c. Observasi: memantau kondisi pasien sejak pertama kali terlihat, dengan memperhatikan gerak tubuh, gerture wajah, respon pasien terhadap lingkungan, atau perilaku lainnya yang memungkinkan ada hubungannya dengan Kesehatan pasien. Contohnya : kepuatan, tampak mual, keringat dingin, gelisah, gemetar, dan lain-lain.
- d. Studi Dokumentasi: memperoleh data dari rekam medis pasien baik dari dokumen fisik maupun elektronik. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data terkait Riwayat Kesehatan, pengobatan, dan hasil pemeriksaan medis pasien seperti hasil laboratorium, pemeriksaan organ dalam, foto rontgen, dan Tindakan prosedur medis lainnya.

Pengkajian menghasilkan data yang akan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu :

- a. Data Subjektif: Data yang diperoleh langsung dari pasien, keluarga, atau pengasuh. Contoh: keluhan nyeri, perasaan cemas, atau riwayat kesehatan pribadi.
- b. Data Objektif: Data yang diperoleh melalui observasi, pemeriksaan fisik, atau hasil laboratorium. Contoh: tekanan darah, suhu tubuh, hasil pemeriksaan darah.

Di Indonesia, pengkajian keperawatan mengikuti Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) yang telah disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). SDKI membantu perawat dalam mengelompokkan data berdasarkan klasifikasi diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan,

sehingga memudahkan dalam proses analisis dan perencanaan asuhan keperawatan (PPNI, 2020).

Pengkajian keperawatan umumnya dilakukan berdasarkan pendekatan Gordon's Functional Health Patterns atau sistem tubuh, namun pendekatan teori keperawatan lainnya juga dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan pengkajian keperawatan. Beberapa komponen utama yang dinilai berdasarkan pendekatan Gordon's Functional Health Patterns atau sistem tubuh antara lain:

- a. Pola Persepsi dan Manajemen Kesehatan : Riwayat kesehatan, kebiasaan hidup sehat, imunisasi.
- b. Pola Nutrisi dan Metabolik : Asupan makanan dan cairan, status gizi, masalah pencernaan.
- c. Pola Eliminasi : Kebiasaan buang air besar dan kecil.
- d. Pola Aktivitas dan Latihan : Kemampuan mobilisasi, toleransi terhadap aktivitas.
- e. Pola Tidur dan Istirahat : Durasi dan kualitas tidur.
- f. Pola Kognitif dan Persepsi : Fungsi kognitif, tingkat kesadaran, gangguan sensorik.
- g. Pola Persepsi Diri dan Konsep Diri : Kepercayaan diri, harga diri, emosi.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan salah satu tahapan utama dalam proses keperawatan yang memiliki peran krusial dalam menentukan arah intervensi yang tepat. Dengan diagnosis yang akurat, perawat dapat menyusun rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu pasien, sehingga meningkatkan efektivitas perawatan dan keselamatan pasien. Diagnosis keperawatan disusun berdasarkan data objektif dan subjektif yang diperoleh selama pengkajian, sehingga perawat harus memiliki keterampilan analisis kritis dalam menghubungkan faktor penyebab dengan tanda dan gejala yang muncul. Misalnya, dalam kasus pasien dengan tekanan darah tinggi yang mengalami sakit kepala hebat, perawat tidak hanya mencatat gejala, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan gangguan perfusi serebral sebagai diagnosis utama.

Perbedaan diagnosis keperawatan dengan diagnosis medis menjadi aspek fundamental dalam profesi keperawatan. Diagnosis medis berfokus pada identifikasi penyakit dan patofisiologi yang mendasarinya, sementara diagnosis keperawatan lebih menekankan pada respons pasien terhadap kondisi kesehatan tersebut. Oleh karena itu, intervensi yang dirancang berdasarkan diagnosis keperawatan bersifat holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Menurut Doenges, Moorhouse, dan Murr (2019), diagnosis keperawatan berfungsi untuk mengidentifikasi masalah pasien yang dapat

ditangani oleh intervensi keperawatan secara mandiri, berbeda dengan diagnosis medis yang lebih berfokus pada penyakit dan etiologinya. Berikut adalah perbedaan antara diagnosis medis dengan keperawatan :

Tabel 7.1 Perbedaan Diagnosis Medis dengan Keperawatan

Aspek	Diagnosis Medis	Diagnosis Keperawatan
Definisi	Identifikasi penyakit atau kondisi patologis berdasarkan pemeriksaan medis.	Identifikasi respons pasien terhadap kondisi kesehatan atau penyakit yang dialami.
Tujuan	Menentukan terapi medis atau pengobatan yang diperlukan.	Menentukan intervensi keperawatan yang sesuai untuk meningkatkan kesehatan pasien.
Penanggung Jawab	Dokter atau tenaga medis yang berwenang.	Perawat yang melakukan pengkajian dan analisis data pasien.
Fokus	Penyebab penyakit dan proses patologis yang terjadi dalam tubuh.	Respons fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien terhadap penyakit atau kondisi yang dialami.
Sifat	Cenderung tetap atau hanya berubah jika ada perkembangan signifikan pada kondisi pasien.	Dinamis, dapat berubah sesuai dengan kondisi pasien dan respons terhadap intervensi keperawatan.
Contoh Diagnosis	Infark Miokard Akut, Diabetes Mellitus, Pneumonia.	Nyeri akut, Gangguan perfusi jaringan jantung, Cemas, Gangguan pola tidur.
Metode Penyusunan	Berdasarkan hasil pemeriksaan medis seperti laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan fisik.	Berdasarkan data subjektif dan objektif dari pengkajian keperawatan menggunakan format PES (Problem, Etiology, Signs/Symptoms).
Pendekatan	Berorientasi pada penyebab spesifik penyakit.	Berorientasi pada pengalaman dan kebutuhan pasien selama perawatan.
Peran dalam Asuhan	Memandu pengobatan medis dan prosedur klinis.	Membantu menentukan intervensi keperawatan untuk mendukung pemulihan pasien.

Diagnosis keperawatan juga telah distandarisasi melalui sistem klasifikasi internasional, seperti yang dikembangkan oleh *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA) International (2020), yang mendefinisikan diagnosis keperawatan sebagai pernyataan klinis tentang respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial yang dapat diatasi melalui intervensi keperawatan. Di Indonesia, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) yang dikembangkan oleh PPNI mendukung pendekatan ini dengan mendefinisikan diagnosis keperawatan sebagai keputusan klinis yang menjadi dasar dalam penyusunan intervensi dan evaluasi keperawatan (PPNI, 2018). Dengan adanya standar ini, perawat dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan asuhan keperawatan berbasis bukti yang lebih efektif dan terarah.

Menurut NANDA International (2020), diagnosis keperawatan dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis utama :

- a. Diagnosis keperawatan aktual: menggambarkan masalah nyata yang sedang terjadi berdasarkan data klinis yang ditemukan. Penegakan diagnosis keperawatan aktual harus memenuhi unsur **P**roblem **E**tiologi **S**ymptom (PES). Symptom (S) dalam diagnosis ini harus mencakup kriteria mayor serta sebagian kriteria minor sesuai dengan pedoman diagnosis NANDA. Contoh: Gangguan pola tidur karena adanya sensasi nyeri, ditandai dengan sulit tidur dan sering terbangun di malam hari.
- b. Diagnosis keperawatan risiko: menggambarkan potensi terjadinya masalah kesehatan jika tidak dilakukan intervensi yang tepat. Penegakan diagnosis keperawatan risiko harus mencakup unsur **P**roblem dan **E**tiologi (PE). Penggunaan istilah "risiko" atau "risiko tinggi" disesuaikan dengan tingkat keparahan atau kerentanan terhadap masalah. Contoh : Risiko aspirasi karena adanya gangguan menelan.
- c. Diagnosis keperawatan *wellness* (sejahtera): merupakan keputusan klinis mengenai keadaan individu, keluarga, atau masyarakat yang sedang dalam transisi menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Terdapat dua kunci utama dalam diagnosis ini: (1) adanya aspek yang mendukung peningkatan kesejahteraan, dan (2) status serta fungsi yang efektif. Contoh : Kesiapan peningkatan nutrisi karena adanya keinginan klien untuk mengubah pola makan lebih sehat.
- d. Diagnosis keperawatan sindrom: adalah diagnosis yang mencakup sekelompok diagnosis keperawatan aktual atau risiko yang diperkirakan akan muncul akibat suatu kejadian atau situasi tertentu. Contoh : Sindrom nyeri kronis, sindrom imobilisasi.

Sementara *International Classification for Nursing Practice* (ICNP) membagi diagnosis keperawatan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu Fisiologis, Psikologis, Perilaku, Relasional, dan Lingkungan (SDKI, 2020).

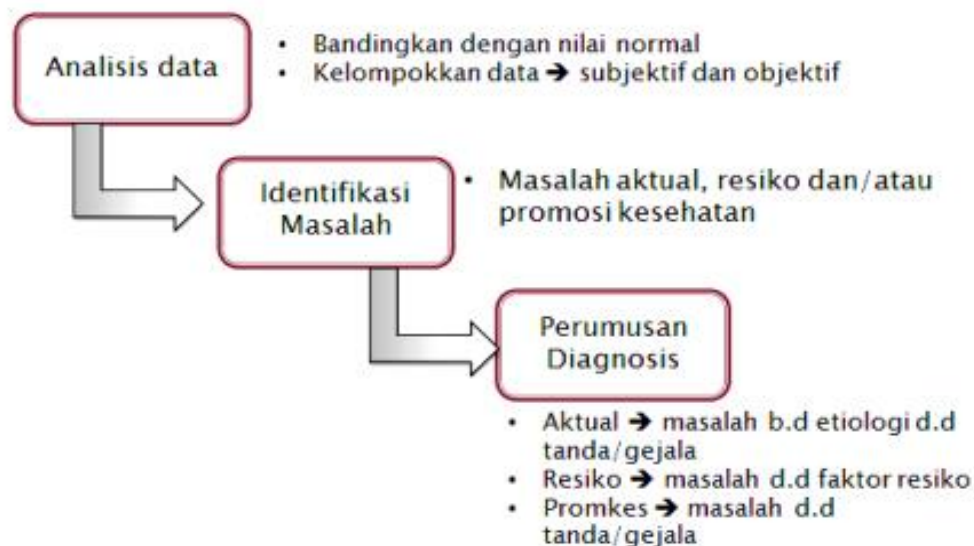


Gambar 7.1. Klasifikasi Diagnosis Keperawatan (ICNP dalam SDKI, 2020)

Indikator diagnostic terdiri dari penyebab, tanda/gejala, dan faktor risiko dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penyebab : (*Etiology*) yang merupakan factor pengaruh perubahan status Kesehatan. Etiologi dapat mencakup empat kategori yaitu : a) Fisiologis, Biologis, atau Psikologis; b) Efek terapi/Tindakan; c) Situasional (lingkungan atau personal), dan d) Maturasional.
- b. Tanda (Sign) dan Gejala (Symptom). Tanda merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan prosedur diagnostic, sedangkan gejala merupakan data subjektif yang diperoleh dari hasil anamnesis. Tanda dan gejala dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu :
 - 1) Mayor : Tanda/gejala ditemukan sekitar 80% - 100% untuk memvalidasi diagnosis.
 - 2) Minor : Tanda/gejala tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis.
- c. Faktor risiko merupakan kondisi atau situasi yang dapat meningkatkan kerentanan klien mengalami masalah Kesehatan.

Proses penegakan diagnosis terdiri dari tiga tahap, yaitu analisis data, identifikasi masalah, dan perumusan diagnosis.



Gambar 7.2 Tahapan Penegakan Diagnosis Keperawatan (NANDA, 2020)

Penulisan diagnosis keperawatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu penulisan tiga bagian dan penulisan dua bagian. Penulisan tiga bagian hanya dilakukan pada diagnosa aktual, dengan formulasi: Masalah berhubungan dengan (b.d) Penyebab (Etiologi) ditandai dengan d.d Tanda dan Gejala.

Masalah b.d Penyebab d.d Tanda dan Gejala

Contoh diagnosis keperawatan:

- Gangguan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan produksi sekret akibat infeksi saluran pernapasan.
- Ditandai dengan suara napas tambahan (ronki), batuk tidak efektif, peningkatan frekuensi napas, dan penggunaan otot bantu napas.
- Nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi akibat post operasi laparatomi.
- Ditandai dengan ekspresi wajah meringis, skala nyeri 7/10, ketidakmampuan tidur, dan peningkatan tekanan darah serta denyut nadi

Penentuan prioritas diagnosis keperawatan sangat penting dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan yang efektif. Berbagai peminatan keperawatan memiliki fokus berbeda dalam menentukan diagnosis yang harus segera ditangani, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak terhadap pasien, serta kemungkinan komplikasi. Pendekatan Maslow, ABCDE, dan prinsip PES membantu perawat dalam menentukan diagnosis prioritas secara sistematis, sehingga asuhan keperawatan dapat lebih efektif dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien.

- a. Prioritas Diagnosis Keperawatan Berdasarkan Pendekatan ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*)
- b. Prioritas Diagnosis Keperawatan Berdasarkan Pendekatan Model Maslow (Kebutuhan Dasar Manusia)
- c. Prioritas Diagnosis Keperawatan Berdasarkan Pendekatan Skala Prioritas, biasa digunakan dalam perumusan diagnosis keperawatan keluarga dan komunitas.

3. Perencanaan Keperawatan (Intervensi Keperawatan)

Intervensi keperawatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan diagnosis keperawatan untuk membantu pasien mencapai hasil yang diharapkan. Intervensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tindakan yang bersifat mandiri hingga tindakan yang memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) merupakan panduan yang dikembangkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk memberikan standarisasi dalam praktik keperawatan di Indonesia. Dalam SIKI, intervensi keperawatan dikategorikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan domain asuhan keperawatan. Intervensi keperawatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemandirian perawat dalam melakukan tindakan, yaitu:

a. Intervensi Mandiri

Intervensi mandiri adalah tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat secara independen tanpa memerlukan instruksi atau arahan dari tenaga medis lainnya. Intervensi ini didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan wewenang yang dimiliki oleh perawat sesuai dengan standar praktik keperawatan. Tindakan dalam kategori ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien, mencegah komplikasi, serta mendukung proses penyembuhan secara mandiri (Berman et al., 2022). Beberapa contoh intervensi mandiri meliputi:

- 1) Edukasi Pasien: Perawat memberikan informasi kepada pasien mengenai penyakit, pengobatan, dan tindakan pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi (Smeltzer et al., 2020).
- 2) Latihan Pernapasan: Diberikan kepada pasien dengan gangguan pernapasan untuk meningkatkan fungsi paru dan mencegah atelektasis (Hinkle & Cheever, 2021).
- 3) Perawatan Luka Sederhana: Meliputi pembersihan luka, pemantauan tanda-tanda infeksi, dan penggantian balutan untuk mempercepat penyembuhan luka akut atau kronis (Potter & Perry, 2021).

b. Intervensi Kolaboratif

Intervensi kolaboratif adalah tindakan keperawatan yang dilakukan dalam kerja sama dengan tenaga medis lain, seperti dokter, fisioterapis, atau ahli gizi. Perawat berperan sebagai bagian dari tim multidisiplin yang bertujuan untuk memberikan perawatan holistik kepada pasien (Stanhope & Lancaster, 2020). Contoh intervensi kolaboratif meliputi:

- 1) Pemberian Obat Berdasarkan Instruksi Dokter: Perawat bertanggung jawab dalam pemberian obat yang diresepkan oleh dokter, termasuk pemantauan efek samping dan kepatuhan pasien terhadap terapi obat (Hinkle & Cheever, 2021).
- 2) Fisioterapi untuk Pasien Stroke: Perawat bekerja sama dengan fisioterapis dalam membantu pasien stroke menjalani latihan rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi motorik dan mobilitas (Potter & Perry, 2021).

c. Intervensi Dependen

Intervensi dependen adalah tindakan keperawatan yang hanya dapat dilakukan atas instruksi atau perintah dari tenaga kesehatan lain, seperti dokter. Dalam intervensi ini, perawat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tindakan yang telah diresepkan atau diinstruksikan oleh tenaga medis yang berwenang (Potter & Perry, 2021). Intervensi dependen sering kali melibatkan prosedur medis yang membutuhkan izin dokter atau tenaga medis lainnya, karena tindakan tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi dan memerlukan evaluasi medis sebelum dilakukan (Hinkle & Cheever, 2021). Beberapa contoh intervensi dependen meliputi:

- 1) Pemberian Terapi Intravena (IV): Administrasi cairan atau obat melalui jalur intravena hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan instruksi dari dokter, mengingat adanya risiko efek samping dan komplikasi seperti reaksi alergi atau infeksi (Berman et al., 2022).
- 2) Pemberian Transfusi Darah: Prosedur ini memerlukan evaluasi dokter untuk menentukan kebutuhan transfusi, jenis darah yang sesuai, dan pemantauan ketat selama prosedur untuk mencegah reaksi transfusi (Smeltzer et al., 2020).
- 3) Pemasangan Kateter Urin: Meskipun perawat memiliki keterampilan dalam pemasangan kateter urin, tindakan ini biasanya dilakukan berdasarkan instruksi dokter, terutama untuk pasien dengan kondisi medis tertentu seperti retensi urin akut atau gangguan ginjal (Potter & Perry, 2021).

Pelaksanaan intervensi keperawatan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan efektivitas. Intervensi keperawatan

dilakukan melalui berbagai teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan pasien, mencegah komplikasi, serta mempercepat proses pemulihan. Berikut ini beberapa teknik yang digunakan dalam pelaksanaan intervensi keperawatan, yaitu :

d. Teknik Non-Farmakologis

Teknik non-farmakologis merupakan pendekatan yang tidak melibatkan pemberian obat, tetapi menggunakan metode lain untuk mengurangi gejala atau meningkatkan kesejahteraan pasien. Teknik ini sering digunakan untuk mengelola nyeri, kecemasan, dan disfungsi fisik melalui stimulasi sensorik atau aktivitas terapeutik (Berman et al., 2022).

1) Relaksasi dan Distraksi

- a) Relaksasi dan distraksi digunakan untuk mengurangi nyeri serta kecemasan pasien. Teknik ini dapat berupa:
- b) Teknik Pernapasan Dalam: Digunakan untuk menurunkan stres dan meningkatkan oksigenasi dengan cara memperlambat pernapasan (Hinkle & Cheever, 2021).
- c) Terapi Musik: Mendengarkan musik yang menenangkan dapat membantu pasien mengalihkan perhatian dari rasa nyeri dan memberikan efek relaksasi (Bradt & Dileo, 2020).
- d) Pijatan: Memberikan rangsangan pada sistem saraf perifer untuk merangsang pelepasan endorfin yang berfungsi sebagai analgesik alami (Potter & Perry, 2021).

2) Terapi Okupasi

- a) Terapi okupasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien dengan melibatkan mereka dalam aktivitas terapeutik. Beberapa contoh penerapannya meliputi:
- b) Latihan Motorik Halus: Digunakan pada pasien stroke untuk meningkatkan kontrol otot kecil dengan melakukan aktivitas seperti menulis atau meremas bola terapi (Stanhope & Lancaster, 2020).
- c) Latihan ADL (Activities of Daily Living): Membantu pasien dalam melatih kemandirian dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan mandi (Smeltzer et al., 2020).

3) Teknik Farmakologis

Teknik farmakologis dalam keperawatan berkaitan dengan pemberian obat kepada pasien dengan cara yang tepat, aman, dan sesuai dengan aturan medis. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberian obat dilakukan sesuai dengan prinsip "5 Benar" (pasien benar, obat benar,

dosis benar, waktu benar, dan rute pemberian benar) untuk mencegah kesalahan medikasi (Berman et al., 2022).

4) Pemberian Obat Oral

- a) Perawat harus memastikan pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap terapi obat.
- b) Obat oral biasanya diberikan dalam bentuk tablet, kapsul, atau cairan dan harus dikonsumsi sesuai dengan instruksi, misalnya sebelum atau sesudah makan untuk mengoptimalkan efektivitas obat (Hinkle & Cheever, 2021).

5) Pemberian Obat Injeksi

- a) Perawat melakukan teknik aseptik saat memberikan injeksi untuk mencegah infeksi.
- b) Beberapa metode injeksi yang umum dilakukan meliputi:
 - Injeksi Intramuskular (IM): Pemberian obat ke dalam otot untuk penyerapan yang lebih cepat, misalnya pada vaksinasi.
 - Injeksi Intravena (IV): Digunakan untuk pemberian cairan atau obat langsung ke dalam pembuluh darah untuk efek yang lebih cepat.
 - Injeksi Subkutan (SC): Digunakan untuk obat yang diserap perlahan, seperti insulin untuk pasien diabetes (Potter & Perry, 2021).

e. Teknik Keperawatan Dasar

Teknik keperawatan dasar mencakup tindakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien, menjaga kenyamanan, serta mencegah komplikasi yang berkaitan dengan imobilitas atau gangguan kebersihan (Smeltzer et al., 2020).

1) Mobilisasi Pasien

- a) Mobilisasi pasien sangat penting dalam mencegah dekubitus dan komplikasi akibat imobilisasi, seperti trombosis vena dalam (DVT).
- b) Perawat harus mengubah posisi pasien tirah baring setiap 2 jam serta memberikan latihan gerakan pasif atau aktif sesuai dengan kondisi pasien (Hinkle & Cheever, 2021).

2) Perawatan Kebersihan

- a) Kebersihan diri pasien sangat penting untuk mencegah infeksi dan meningkatkan kenyamanan.
- b) Perawatan kebersihan mencakup mandi, perawatan kebersihan oral, serta perawatan kulit untuk pasien yang mengalami inkontinensia atau memiliki risiko luka tekan (Potter & Perry, 2021).

f. Teknik Keperawatan Kritis

Teknik keperawatan kritis digunakan dalam situasi darurat atau pada pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah komplikasi lebih lanjut (Berman et al., 2022).

1) Manajemen Jalan Napas

a) Perawat dapat melakukan suction atau pemasangan alat bantu napas seperti nasal cannula, masker oksigen, atau intubasi endotrakeal pada pasien dengan gangguan jalan napas.

b) Tindakan ini bertujuan untuk memastikan oksigenasi yang optimal dan mencegah hipoksia (Hinkle & Cheever, 2021).

2) Penatalaksanaan Keadaan Gawat Darurat

a) Dalam kondisi henti jantung atau gangguan pernapasan akut, perawat harus melaksanakan resusitasi jantung paru (RJP) sesuai dengan protokol Advanced Cardiac Life Support (ACLS).

b) Perawat juga dapat membantu dalam pemberian terapi kejutan defibrilasi pada pasien dengan aritmia yang mengancam nyawa (Potter & Perry, 2021).

Observasi, Terapeutik, Edukasi, dan Kolaborasi (OTEK) diklasifikasikan sebagai jenis intervensi keperawatan berdasarkan tindakan yang dilakukan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Klasifikasi ini digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan intervensi secara sistematis dan terarah sesuai dengan kebutuhan pasien. Pengertian dari setiap komponen klasifikasi intervensi adalah sebagai berikut :

a. Observasi (O)

Observasi adalah Tindakan pengumpulan data dan pemantauan kondisi pasien untuk mengidentifikasi masalah kesehatan atau menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Contoh : pemantauan tanda-tanda vital pasien, observasi adanya tanda-tanda infeksi pada luka pasien, pemantauan kadar gula darah pada pasien diabetes, observasi respons pasien terhadap pemberian terapi oksigen.

b. Terapeutik (T)

Terapeutik adalah tindakan keperawatan yang bertujuan untuk memberikan efek penyembuhan atau meringankan kondisi pasien. Tindakan ini dapat berupa intervensi farmakologis maupun non-farmakologis yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan mempercepat pemulihan pasien. Contoh : Perawatan luka untuk mempercepat penyembuhan, pemberian terapi oksigen untuk pasien dengan gangguan pernafasan, latihan gerak *range of*

motion (ROM), Latihan teknik relaksasi seperti terapi music atau distraksi untuk mengurangi nyeri.

c. Edukasi (E)

Edukasi adalah tindakan keperawatan yang berfokus pada pemberian informasi atau pendidikan kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi kesehatan, perawatan diri, atau Tindakan pencegahan penyakit. Contoh : Edukasi kesehatan, edukasi proses penyakit, Edukasi keselamatan lingkungan, dan lain-lain.

d. Kolaborasi (K)

Kolaborasi adalah tindakan keperawatan yang melibatkan kerja sama dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter, ahli gizi, fisioterapis, atau farmasis, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pasien. Contoh: Tindakan pembedahan, Pemberian obat, pemberian latihan rehabilitasi medik, tindakan resusitasi, dan lain-lain.

Perencanaan melibatkan penyusunan rencana asuhan keperawatan berdasarkan diagnosis yang telah ditetapkan. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) digunakan untuk menentukan luaran keperawatan yang diharapkan, sementara Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) memberikan panduan dalam memilih intervensi yang sesuai (PPNI, 2020). Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbasis waktu (SMART) (Taylor, Lillis, & Lynn, 2020).

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi merupakan tahap di mana intervensi keperawatan yang telah direncanakan dilaksanakan untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan. Menurut PPNI (2020). Implementasi melibatkan keterampilan teknis, komunikasi terapeutik, serta pendekatan yang berbasis empati dan keselamatan pasien. Ditinjau dari teknis penulisan intervensi menggunakan kalimat pasif, sementara pada implementasi penulisannya diubah menjadi kalimat aktif yang membuktikan tindakan telah dilakukan oleh perawat. Pelaksanaan implementasi memperhatikan waktu, kesiapan pasien dan keluarga, serta pencatatan respon saat tindakan dilaksanakan.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai apakah intervensi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan kondisi pasien sebelum dan setelah intervensi, menilai tingkat pencapaian luaran keperawatan berdasarkan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), serta

menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan (PPNI, 2020). Evaluasi keperawatan melibatkan beberapa langkah berikut:

- a. Pengukuran Respons Pasien – Menilai perubahan kondisi pasien berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
- b. Analisis Keberhasilan Intervensi – Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan.
- c. Modifikasi Rencana Asuhan – Jika tujuan belum tercapai, perawat perlu menyesuaikan intervensi yang dilakukan berdasarkan data terbaru.
- d. Evaluasi yang tepat dan berbasis bukti akan membantu perawat dalam meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan serta memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, evaluasi keperawatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode SOAP/SOAPIER yaitu :

- a. **S (Subjektif)**: Data yang didapatkan dari pasien (keluhan, perasaan, dll).
- b. **O (Objektif)**: Data yang didapatkan dari hasil pengukuran dan observasi perawat (misalnya, tekanan darah, suhu, dll).
- c. **A (Analisis)**: Interpretasi dari data subjektif dan objektif.
- d. **P (Plan)**: Rencana tindakan keperawatan selanjutnya.
- e. **I (Intervention)**: Intervensi yang telah dilakukan.
- f. **E (Evaluation)**: Evaluasi terhadap intervensi yang telah dilakukan.
- g. **R (Revision)**: Revisi rencana keperawatan jika diperlukan.

C. Manfaat Proses Keperawatan

Proses keperawatan merupakan pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah kesehatan pasien tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan keperawatan secara keseluruhan. Manfaat dari penerapan proses keperawatan dapat dirasakan oleh pasien, perawat, dan institusi kesehatan.

1. Manfaat bagi Pasien, Perawat, dan Institusi Kesehatan

- a. Manfaat bagi Pasien
 - 1) Pasien menerima asuhan yang lebih terstruktur dan berbasis bukti, sehingga meningkatkan efektivitas dan keselamatan perawatan.
 - 2) Meningkatkan partisipasi pasien dalam perawatan karena adanya komunikasi terapeutik dan keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan.
 - 3) Mengurangi risiko kesalahan medis melalui proses yang terstandarisasi, mulai dari pengkajian hingga evaluasi.

b. Manfaat bagi Perawat

- 1) Memberikan panduan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan, sehingga memudahkan perawat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan mengevaluasi intervensi keperawatan.
- 2) Meningkatkan profesionalisme perawat dengan pendekatan berbasis bukti yang memastikan bahwa tindakan yang diberikan sesuai dengan standar keperawatan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan kepuasan kerja karena perawat dapat melihat hasil dari intervensi yang diberikan kepada pasien.

c. Manfaat bagi Institusi Kesehatan

- a. Meningkatkan efisiensi dalam pemberian layanan kesehatan karena asuhan keperawatan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
- b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdampak pada kepuasan pasien dan keluarganya.
- c. Meminimalkan risiko tuntutan hukum dengan memastikan bahwa tindakan keperawatan dilakukan sesuai standar dan terdokumentasi secara lengkap.

2. Peningkatan Kualitas Asuhan Keperawatan

Penerapan proses keperawatan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan keperawatan dengan cara:

- a. Menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam setiap langkah asuhan keperawatan, sehingga meningkatkan akurasi diagnosis dan efektivitas intervensi.
- b. Memastikan adanya evaluasi berkala terhadap tindakan yang diberikan, sehingga memungkinkan perbaikan dan penyesuaian terhadap kebutuhan pasien.
- c. Menstandarkan pelayanan keperawatan sehingga setiap pasien mendapatkan perawatan dengan kualitas yang sama tanpa adanya bias atau ketidakpastian dalam pengambilan keputusan klinis.

3. Pendekatan Holistik dalam Pelayanan Kesehatan

Proses keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek fisik pasien tetapi juga memperhitungkan faktor psikologis, sosial, dan spiritual dalam perawatan. Pendekatan holistik ini mencakup:

- a. Aspek Fisik: Identifikasi dan penanganan masalah kesehatan yang bersifat biologis atau patologis.
- b. Aspek Psikologis: Memberikan dukungan emosional, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan mental pasien.
- c. Aspek Sosial: Mempertimbangkan kondisi sosial pasien, termasuk dukungan keluarga dan lingkungan sekitar dalam perawatan.

- d. Aspek Spiritual: Memberikan perhatian pada nilai-nilai, kepercayaan, dan keyakinan pasien yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan mereka.
- e. Dengan adanya pendekatan holistik ini, proses keperawatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pasien tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya secara menyeluruh.

D. Proses Keperawatan Sebagai Metode Penyelesaian Masalah keperawatan

Proses keperawatan merupakan metode ilmiah yang membantu perawat dalam menyelesaikan masalah klinis secara sistematis. Dengan menerapkan lima tahapan proses keperawatan, perawat dapat memberikan asuhan yang efektif dan berbasis bukti, sehingga meningkatkan keselamatan serta kualitas hidup pasien. Berikut ini adalah contoh penerapan asuhan keperawatan dalam kasus :

Kasus: Pasien dengan Diabetes Mellitus Tipe 2

Hasil pengkajian:

Seorang Perempuan 55 tahun, terdiagnosis medis diabetes mellitus tipe 2. Hasil pemeriksaan perawat menunjukkan kadar glukosa darah sewaktu 300 mg/dl, adanya luka pada kaki kanan, serta pasien mengeluhkan sering merasa haus dan Lelah.

Diagnosis Keperawatan:

1. Ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan resistensi insulin
2. Ketidakseimbangan Nutrisi: Lebih dari Kebutuhan Tubuh berhubungan dengan pola makan tidak sehat
3. Risiko Infeksi berhubungan dengan luka diabetic

Rencana Tindakan Keperawatan (Intervensi Keperawatan) :

1. Memberikan edukasi mengenai diet sehat dan manajemen diabetes
2. Memantau kadar glukosa darah secara berkala
3. Melakukan perawatan luka dengan teknik steril

Implementasi Keperawatan :

1. Mengajarkan pasien mengenai pola makan rendah karbohidrat dan tinggi serat
2. Memberikan terapi insulin sesuai instruksi dokter
3. Melakukan debridemen pada luka dan memberikan perawatan luka dengan antiseptic

Evaluasi Keperawatan :

- S : - Pasien mengatakan merasa lebih baik dibandingkan sebelumnya
- Keluhan sering haus dan Lelah mulai berkurang
 - Pasien mengatakan mengikuti anjuran diet rendah karbohidrat dan tinggi serat
- O : - Kondisi luka tampak bersih dan lembab
- Kadar GDS 180 mg/dl
 - Tanda-tanda Vital dalam batas normal : TD 130/80 mmHg, N 76 x/menit, RR 18 x/menit
 - tidak tampak tanda-tanda infeksi
- A : - Masalah keperawatan ketidakstabilan gula darah teratasi Sebagian
- Masalah ketidakseimbangan nutrisi: lebih dari kebutuhan tubuh teratasi Sebagian
 - Masalah risiko infeksi teratasi
- P : Lanjutkan intervensi :
- Memantau kadar gula darah
 - Melanjutkan perawatan luka
 - Memantau diet pasien

E. Perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah

Metode ilmiah pada proses keperawatan merupakan dua pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis dan berbasis bukti. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam hal penggunaan logika, analisis data, dan langkah-langkah yang sistematis dalam penyelesaian masalah. Proses keperawatan mengadopsi pendekatan berbasis bukti atau Evidence-Based Nursing (EBN) dalam pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini menggabungkan hasil penelitian terbaru dengan pengalaman klinis perawat dan preferensi pasien untuk mencapai perawatan yang optimal. Komponen pendekatan berbasis bukti dalam keperawatan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Ilmiah: Penggunaan hasil studi klinis dan meta-analisis yang telah terbukti efektif dalam praktik keperawatan.
2. Pengalaman Klinis Perawat: Keputusan keperawatan juga didasarkan pada intuisi, keterampilan, dan pengalaman profesional perawat dalam menangani kasus yang serupa.
3. Nilai dan Preferensi Pasien: Aspek psikososial dan budaya pasien menjadi pertimbangan dalam menentukan intervensi yang sesuai.

4. Sumber Daya dan Konteks Klinis: Ketersediaan fasilitas, tenaga medis, serta kebijakan institusi kesehatan memengaruhi implementasi keperawatan berbasis bukti

Pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan, mengurangi kesalahan klinis, dan memastikan bahwa tindakan yang diberikan sesuai dengan standar praktik profesional yang berlaku. Terdapat kelebihan dan keterbatasan dari kedua pendekatan penyelesaian masalah kesehatan klien tersebut, yaitu :

Tabel 7.2 Kelebihan Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan

Metode	Kelebihan
Metode Ilmiah	- Memungkinkan inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan - Menghasilkan teori dan konsep yang dapat digunakan di berbagai bidang - Mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan
Proses Keperawatan	- Memberikan asuhan keperawatan yang sistematis dan terorganisir - Berorientasi pada pasien dengan pendekatan holistik - Dapat langsung diterapkan dalam praktik klinis

Tabel 7.3 Keterbatasan Metode Ilmiah dan Proses Keperawatan

Metode	Keterbatasan
Metode Ilmiah	- Membutuhkan waktu lama dalam proses penelitian - Tidak selalu dapat langsung diterapkan dalam situasi klinis - Terkadang hasil penelitian bersifat teoretis dan sulit diimplementasikan
Proses Keperawatan	- Bergantung pada keterampilan dan pengalaman perawat dalam menginterpretasikan data pasien - Dapat dipengaruhi oleh faktor subjektivitas dalam pengambilan keputusan klinis - Implementasi dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan

F. Latihan

Pilihan Ganda

1. Seorang perawat baru bekerja di RS dan mendapatkan mandat dari perawat primer untuk mengisi poses keperawatan pada elektronik health record. Apakah yang dimaksud dengan tahap awal yang dilakukan untuk memperoleh data sebelum merumuskan masalah keperawatan?

- A. Tahapan Pengkajian
 - B. Tahap Diagnosis
 - C. Tahap Perencanaan
 - D. Tahap Implementasi
 - E. Tahap Evaluasi
2. Seorang perawat melakukan pengkajian pada pasien dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan pada pasien, keluarga pasien, dan pengantar pasien. Apakah jenis data yang akan didokumentasikan oleh perawat?
- A. Data Subjektif
 - B. Data Objektif
 - C. Data Fokus
 - D. Analisa Data
 - E. Data Personal Pasien
3. Seorang perawat melakukan pengkajian pada pasien dengan teknik pemeriksaan fisik pada pasien dan studi dokumentasi pada rekam medis pasien. Apakah jenis data yang akan didokumentasikan oleh perawat?
- A. Data Subjektif
 - B. Data Objektif
 - C. Data Fokus
 - D. Analisa Data
 - E. Data Personal Pasien
4. Seorang perawat baru bekerja di RS dan mendapatkan mandat dari perawat primer untuk mengisi poses keperawatan pada elektronik healt record. Manakah urutan penyusunan dokumentasi asuhan keperawatan yang benar?
- A. Pengkajian-Diagnosa-Intervensi-Implementasi-Evaluasi
 - B. Pengkajian-Intervensi- Diagnosa-Implementasi-Evaluasi
 - C. Pengkajian-Diagnosa-Implementasi-Intervensi-Evaluasi
 - D. Pengkajian-Intervensi-Diagnosa-Evaluasi-Implementasi
 - E. Pengkajian-Implementasi-Diagnosa-Intervensi-Evaluasi
5. Seorang Seorang perawat melakukan pengkajian ke pasien dengan melihat kondisi pasien mulai dari tampilan ketika masuk sampai dengan penampakan kondisi tubuh pasien. Apakah teknik pengkajian yang dilakukan oleh perawat tersebut ?
- A. Auskultasi

- B. Inspeksi
 - C. Palpasi
 - D. Studi Dokumentasi
 - E. Perkusi
6. Pada tahap perencanaan dalam proses keperawatan, prinsip utama yang digunakan adalah?
- A. SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
 - B. ADPIE (Assessment, Diagnosis, Planning, Implementation, Evaluation)
 - C. ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure)
 - D. SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)
 - E. SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)
7. Seorang perawat telah selesai mengelompokkan data pada proses analisa data. Apakah yang akan dirumuskan oleh perawat pada tahap selanjutnya ?
- A. Melakukan analisa data
 - B. Merumuskan Intervensi Keperawatan
 - C. Merumuskan diagnosis keperawatan
 - D. Melakukan Implementasi keperawatan
 - E. Melaksanakan evaluasi keperawatan
8. Dalam tahap implementasi, perawat melakukan intervensi yang terdiri dari?
- A. Intervensi mandiri, intervensi kolaboratif, intervensi dependen
 - B. Intervensi teknis, intervensi non-teknis, intervensi sosial
 - C. Intervensi promotif, intervensi preventif, intervensi kuratif
 - D. Intervensi aktif, intervensi pasif, intervensi reflektif
 - E. Intervensi preventif, intervensi rehabilitatif, intervensi suportif
9. Seorang wanita usia 28 tahun mengeluh tidak bisa tidur sejak 3 hari rawat di RS, karena merasakan nyeri pada kaki kanan yang patah, dan selalu berkeringat saat tidur. Hal tersebut membuat pasien sering terbangun saat tidur, dan hanya tidur nyenyak 2 jam setiap malamnya. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada pasien tersebut?
- A. Gangguan Pola tidur
 - B. Gangguan rasa nyaman
 - C. Gangguan pertukaran gas
 - D. Intoleransi aktifitas
 - E. Gangguan Mobilitas Fisik

10. Seorang wanita usia 28 tahun mengeluh nyeri pasca bedah kaki dan saat ini terdapat luka terbuka pada jaringan kaki post debridement dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan kedalaman 0,5 cm, dasar luka tampak merah, tidak ada pus/nanah, tertutup kasa dengan balutan ocllusive dressing. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada pasien tersebut?
- A. Gangguan integritas kulit/jaringan
 - B. Nyeri Akut
 - C. Nyeri Kronis
 - D. Gangguan mobilitas fisik
 - E. Risiko Infeksi

G. Kunci Jawaban

- 1. A. Tahapan Pengkajian
- 2. A. Data Subjektif
- 3. B. Data Objektif
- 4. A. Pengkajian-Diagnosa-Intervensi-Implementasi-Evaluasi
- 5. B. Inspeksi
- 6. A. SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
- 7. C. Merumuskan diagnosis keperawatan
- 8. A. Intervensi mandiri, intervensi kolaboratif, intervensi dependen
- 9. A. Gangguan Pola tidur
- 10. A. Gangguan integritas kulit/jaringan

H. Rangkuman Materi

Proses keperawatan merupakan metode sistematis yang digunakan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif, efisien, dan berbasis bukti. Proses ini terdiri dari lima tahap utama:

- 1. Pengkajian – Mengumpulkan data subjektif dan objektif pasien melalui wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, dan studi dokumentasi.
- 2. Diagnosis Keperawatan – Menentukan masalah keperawatan berdasarkan analisis data pengkajian menggunakan format Problem-Etiology-Symptom (PES).
- 3. Perencanaan – Merancang intervensi keperawatan yang spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu (SMART) sesuai dengan diagnosis keperawatan.
- 4. Implementasi – Melaksanakan intervensi yang telah dirancang, baik secara mandiri, kolaboratif, maupun dependen.
- 5. Evaluasi – Menilai efektivitas intervensi dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah intervensi serta melakukan modifikasi rencana keperawatan jika diperlukan.

Di Indonesia, penerapan proses keperawatan didukung oleh Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Ketiga standar ini menjadi acuan dalam mendokumentasikan dan memberikan asuhan keperawatan yang sistematis. Proses keperawatan memiliki manfaat signifikan bagi pasien, perawat, dan institusi kesehatan. Bagi pasien, pendekatan ini memastikan asuhan keperawatan yang terstruktur dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan individu. Bagi perawat, proses ini meningkatkan kemandirian profesional dan keterampilan pengambilan keputusan. Sementara bagi institusi kesehatan, penerapan proses keperawatan meningkatkan efisiensi layanan serta mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian asuhan keperawatan.

I. Glosarium

Asuhan Keperawatan – Rangkaian kegiatan perawatan yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga, atau masyarakat untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan.

Pengkajian – Proses sistematis dalam mengumpulkan data tentang kondisi pasien untuk menentukan kebutuhan keperawatan.

Diagnosis Keperawatan – Pernyataan klinis mengenai respons pasien terhadap masalah kesehatan yang dapat diatasi melalui intervensi keperawatan.

Intervensi Keperawatan – Tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatannya.

Implementasi – Pelaksanaan rencana asuhan keperawatan yang telah dirancang berdasarkan diagnosis dan perencanaan yang telah dibuat.

Evaluasi – Tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia) – Standar yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah keperawatan berdasarkan bukti ilmiah.

SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) – Panduan intervensi keperawatan yang sesuai dengan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan.

SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia) – Standar yang digunakan untuk mengukur hasil dari intervensi keperawatan yang diberikan.

SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) – Metode dokumentasi keperawatan yang mencakup data subjektif, objektif, analisis, dan rencana tindakan keperawatan.

Terapi Musik – Metode non-farmakologis yang digunakan dalam intervensi keperawatan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien.

Proses Keperawatan – Pendekatan sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan yang mencakup lima tahap utama: pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

PES (Problem, Etiology, Symptom) – Format dalam diagnosis keperawatan yang mencakup masalah keperawatan, penyebab, dan gejala yang ditemukan pada pasien.

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) – Prinsip dalam perencanaan keperawatan untuk menetapkan tujuan yang jelas, dapat diukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu.

EBN (Evidence-Based Nursing) – Pendekatan keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah, pengalaman klinis perawat, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis.

J. Daftar Pustaka

- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Patient Care*. F.A. Davis.
- NANDA International. (2020). *NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 2021-2023*. Thieme Medical Publishers.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2020). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*. PPNI.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Taylor, C., Lillis, C., & Lynn, P. (2020). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Care*. Wolters Kluwer.

PROFIL PENULIS



Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep., adalah seorang dosen di Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 1990. Riwayat pendidikan dimulai dari jenjang Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, yang masing-masing diselesaikan pada tahun 2012 dan 2013. pendidikan Magister Keperawatan Manajemen di institusi yang sama dan lulus pada tahun 2017. Sejak tahun 2014 hingga

sekarang, aktif mengajar sebagai dosen di program studi DIII, S1 Keperawatan, dan prodi Profesi Ners di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI pada tahun 2014 hingga sekarang. Selain ini penulis menjabat sebagai tim pengembangan akademik dan kurikulum program studi Keperawatan dan ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Keperawatan FPOK UPI.

Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, beliau mengampu berbagai mata kuliah, seperti Keperawatan Dasar, Praktik Klinik Keperawatan Dasar, Manajemen Keperawatan, Manajemen Keselamatan Pasien, Konsep Dasar Keperawatan, Metodologi Keperawatan, Kewirausahaan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, serta Keterampilan Dasar Keperawatan. Penulis telah membuat buku ajar keperawatan dasar, manajemen keperawatan.

Penulis dapat dihubungi melalui email: asihpurwandari@upi.edu atau asihpwp@upi.edu.



Ester Radandima, S.Kep., Ns., M.Kep., Penulis dilahirkan di Sumba Timur pada Tahun 1978 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis menyelesaikan DIII pada Program Studi D III- Keperawatan Waingapu Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2005. Pendidikan S1 Keperawatan dan Ners di Universitas Udayana Denpasar Bali pada tahun 2013 dan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Airlangga pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 lulus CPNS dan ditempatkan kembali di Program Studi DIII-Keperawatan Waingapu

Poltekkes Kemenkes Kupang sebagai Dosen hingga sekarang. Penulis adalah tim pengajar di Departemen Keperawatan Keluarga dan Komunitas dan aktif melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui Email: esterndima@gmail.com

PROFIL PENULIS



Toto Harto, M.K.M., Lahir di Tuguharum, 27 Februari 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Keperawatan, Akademi Keperawatan Al-Ma'arif Baturaja lulus tahun 2011. Pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif Baturaja dan lulus tahun pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Universitas Sriwijaya dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sampai saat ini yaitu bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif Baturaja mengampu mata kuliah Metodologi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan reviewer jurnal. Semoga kedepannya penulis terlibat aktif dalam menulis buku ajar, *book chapter*, monograf, dan buku referensi. e-mail: totoharto27@gmail.com. Motto: "Bersungguh- sungguhlah, maka kebaikan akan datang"



Dr. Sri Astutik Andayani, S.Kep., Ns, M.Kes., adalah akademisi keperawatan yang berdedikasi dalam pengembangan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat di bidang keperawatan, khususnya keperawatan jiwa dan komunitas. Lahir dan besar di Situbondo, ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di wilayah tersebut sebelum melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ia meraih gelar Sarjana Keperawatan dari Universitas Ngudi Waluyo Semarang (2008), gelar Magister Kesehatan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014), dan menuntaskan program Doktor di Universitas Airlangga Surabaya (2022). Sebagai pengajar, beliau aktif mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan di program studi keperawatan dan kebidanan di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid. Dalam perannya, beliau menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan berbasis bukti dalam praktik keperawatan, serta membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal dan penelitian

PROFIL PENULIS



Muhammad Syahid Hidayat BS., SH., S.Kep., MS., MH., adalah seorang praktisi keperawatan, akademisi, dan peneliti multidisipliner yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keperawatan dan hukum. Lahir di Demak, Jawa Tengah pada 1 November 1977, ia mengawali karier profesionalnya sebagai perawat klinis sebelum berkembang menjadi seorang manajer keperawatan, peneliti, dan penulis produktif dalam bidang kesehatan dan manajemen layanan kesehatan. Saat ini, penulis sedang menempuh studi Magister Keperawatan (*Master of Science in Nursing*) di National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan, sebuah universitas riset ternama yang menjadi pusat keunggulan bidang keperawatan di Asia. Sebelumnya, ia telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di Universitas Patria Artha Makassar, dan meraih gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep.). Di luar disiplin keperawatan, penulis juga menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.), Magister Hukum (M.H.), dan Doktor Hukum (Dr.), menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan pengetahuan interdisipliner yang menyatukan aspek klinis, etik, dan legal dalam pelayanan kesehatan. Karier profesionalnya meliputi lebih dari dua dekade pengalaman, termasuk sebagai Direktur Riset dan Pengembangan di RS Swasta, Manajer Keperawatan, dan Surveyor Akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penulis dikenal karena dedikasinya dalam pengembangan mutu layanan keperawatan berbasis *evidence-based practice* (EBP), khususnya dalam bidang komunikasi SBAR, keselamatan pasien, dan manajemen keperawatan. Sebagai penulis dan peneliti, berbagai artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional terakreditasi telah diterbitkan dan menjadi narasumber dalam forum-forum akademik nasional. Beberapa publikasi pentingnya antara lain membahas implementasi komunikasi SBAR dalam peningkatan mutu *handover* keperawatan, perawatan paliatif, serta kepuasan pasien. Ia juga telah menulis dan menerbitkan dua buku keperawatan:

Konsep Dasar Keperawatan (2024)

Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan (2025)

Dengan latar belakang multidisipliner dan rekam jejak yang kuat dalam praktik, akademik, dan penelitian, buku *Metodologi Penelitian* yang ditulisnya ini merupakan hasil refleksi dari pengalaman nyata di lapangan serta pemahaman mendalam tentang pendekatan riset kuantitatif, kualitatif, dan *mixed-methods* yang relevan bagi mahasiswa, peneliti pemula, dan praktisi kesehatan di Indonesia.

PROFIL PENULIS



D. Eka Harsanto, S.Kp., M.Kes., Lahir di Bogor 22 Desember 1976, Pendidikan SDN Polisi V Bogor, SMPN 1 Bogor, SMAN 3 Bogor, Sarjana Keperawatan (S.Kp) di PSIK-FK Universitas Padjadjaran Bandung dan melanjutkan Magister Kesehatan (Kajian Administrasi Rumah Sakit) UKB Palembang. Memulai karir sebagai Dosen Keperawatan pada Tahun 2002 di STIKES HARAPAN IBU Jambi. Menjadi Dosen PNS Pada Poltekkes Kemenkes Palembang Program Studi Diploma III Keperawatan Kampus Lubuklinggau dari Tahun 2003 sampai dengan 2013. Saat ini sebagai Dosen Pengajar di Poltekkes Kemenkes Palembang Program Studi Diploma III Keperawatan Kampus Baturaja. Mata Kuliah yang diampu antara lain : Metodologi Keperawatan, Dokumentasi Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa, Psikologi. Aktif dalam organisasi profesi keperawatan dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa (IPKJI)



Ns. I Gusti Ayu Putu Desy Rohana, M.Kep, Sp.Kep.Kom., Lahir di Jakarta, 15 Oktober 1986. Telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana dan Profesi Ners di Universitas Pembangunan Negara (UPN) "Veteran" Jakarta pada tahun 2010. Melanjutkan Pendidikan Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Komunitas di Universitas Indonesia (UI), tahun 2015 – 2018. Pernah bekerja sebagai dosen keperawatan pada STIKes. Pamentas, dan STIKes. Dr. Sismadi menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S1 Keperawatan, Tahun 2011 – 2015. Memiliki pengalaman klinikal sebagai Kepala Seksi Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) 2018 – 2020. Saat ini bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) Dosen pada bidang ilmu Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palembang, aktif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan terlibat sebagai Tim Champion Kementerian Kesehatan, selain itu juga berperan dalam pembinaan produk kreatif mahasiswa di Program Studi D III Keperawatan Baturaja. Beberapa karya ilmiah terakhir yang dipublikasikan pada jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat, terdapat sebanyak 35 artikel. Selain karya ilmiah yang terpublikasi, terdapat juga karya yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) berupa video, poster, alat peraga, dan video virtual reality SOP Praktik Intervensi Keperawatan, jumlah perolehan HaKi sebanyak 20 HaKi yang tersertifikat. Email: igustiayu.desyrohana@poltekkespalembang.ac.id

Motto: "To be Your Self" Jangan pernah kehilangan jati diri, dan pastikan usaha Mu dalam hidup sudah maksimal dari apa yang Kau mampu, karena kesuksesan itu diraih bukan dinanti.

PROFIL PENULIS



Hernita Frisnawati Purba, S.Kep., Ns., M.Kep., Staf Dosen pada Prodi D III Keperawatan STIKes RS Prof Dr. J.A. Latumeten Ambon. Lahir di Medan, 07 Juli 1979. Dibesarkan di Kota Medan, Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Maranatha Medan, SMP Methodist I Medan, SPK DR Rusdi Medan di tahun 1997, dan Lulus dari Akper Darmo Medan tahun 2001. Setelah menyelesaikan pendidikan Akper, penulis bekerja di RS Bethesda Yogyakarta selama 3 tahun dari tahun 2001 s/d 2004, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan di Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2007.

Setelah lulus, Penulis bekerja sebagai staf dan Dosen di Akper Rumkit TK III DR. J.A. Latumeten (sekarang bernama STIKes RS. Prof DR. J.A. Latumeten). Di Tahun 2010 Penulis lulus CPNS di lingkup Provinsi Maluku dan di tempatkan di RSUD dr.M.Haulussy Ambon. Penulis menjalankan tugas baik sebagai ASN di RSUD dr.M. Haulussy maupun sebagai Dosen di STIKes RS. Prof DR.J.A Latumeten. Di tahun 2013 s/d 2015 penulis mendapat tanggung jawab sebagai Manajer Ruangan Bedah Wanita RSUD dr.M.Haulussy Ambon, dan di tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Padjadjaran Bandung dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah lulus tahun 2017. Dan kembali mengabdikan sebagai Dosen di STIKes RS Prof DR. J.A. Latumeten sekaligus sebagai ASN bertanggungjawab sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan di RSUD dr. M.Haulussy Ambon. Penulis melakukan Tri dharma Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang penulis lakukan telah dipublikasi pada Jurnal keperawatan Nasional terakreditasi dan jurnal Internasional. Penulis sudah menulis buku referensi dan buku ini merupakan buku ajar yang ketiga yang penulis tulis. Semoga kedepannya penulis dapat lebih produktif dalam menulis buku ajar, book-chapter, monograf dan buku referensi lainnya. Email penulis: hernitapurba1977@gmail.com

Buku ajar ini disusun secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai metodologi dalam keperawatan, yang menjadi dasar penting dalam praktik klinis yang efektif dan efisien. Diawali dengan pembahasan tentang konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam keperawatan, buku ini menegaskan pentingnya kemampuan analitis yang mendalam dalam menangani berbagai situasi klinis, sehingga perawat dapat mengambil keputusan secara tepat berbasis bukti ilmiah.

Selanjutnya, buku ini mendalami penerapan proses keperawatan sebagai metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah atau memberikan asuhan keperawatan. Melalui bab ini, pembaca diajak memahami bagaimana langkah-langkah ilmiah yang sistematis dapat diterapkan secara praktis dalam situasi klinis sehari-hari. Penjelasan tentang praktik menetapkan diagnosa keperawatan secara akurat dan tepat guna, serta perbandingan antara metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai pendekatan dalam penyelesaian masalah, juga menjadi bagian penting dari pembahasan buku ini. Selain itu, buku ini juga secara khusus menyoroti tren dan isu terkini dalam dunia keperawatan, memungkinkan pembaca untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam profesi ini. Pembahasan mengenai perencanaan keperawatan memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk menyusun intervensi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan. Buku ini ditutup dengan penjelasan konsep proses keperawatan secara komprehensif, yang membantu mahasiswa dan praktisi memahami proses ini sebagai siklus ilmiah yang berkelanjutan dalam praktik sehari-hari.

Dengan pendekatan teori yang kuat disertai contoh aplikatif di lapangan, buku ini sangat tepat sebagai referensi utama bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi keperawatan dalam mengembangkan kemampuan metodologis yang kritis dan praktis di dunia keperawatan.

Buku ajar ini disusun secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai metodologi dalam keperawatan, yang menjadi dasar penting dalam praktik klinis yang efektif dan efisien. Diawali dengan pembahasan tentang konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam keperawatan, buku ini menegaskan pentingnya kemampuan analitis yang mendalam dalam menangani berbagai situasi klinis, sehingga perawat dapat mengambil keputusan secara tepat berbasis bukti ilmiah.

Selanjutnya, buku ini mendalami penerapan proses keperawatan sebagai metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah atau memberikan asuhan keperawatan. Melalui bab ini, pembaca diajak memahami bagaimana langkah-langkah ilmiah yang sistematis dapat diterapkan secara praktis dalam situasi klinis sehari-hari. Penjelasan tentang praktik menetapkan diagnosa keperawatan secara akurat dan tepat guna, serta perbandingan antara metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai pendekatan dalam penyelesaian masalah, juga menjadi bagian penting dari pembahasan buku ini.

Selain itu, buku ini juga secara khusus menyoroti tren dan isu terkini dalam dunia keperawatan, memungkinkan pembaca untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam profesi ini.

Pembahasan mengenai perencanaan keperawatan memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk menyusun intervensi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan. Buku ini ditutup dengan penjelasan konsep proses keperawatan secara komprehensif, yang membantu mahasiswa dan praktisi memahami proses ini sebagai siklus ilmiah yang berkelanjutan dalam praktik sehari-hari.

Dengan pendekatan teori yang kuat disertai contoh aplikatif di lapangan, buku ini sangat tepat sebagai referensi utama bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi keperawatan dalam mengembangkan kemampuan metodologis yang kritis dan praktis di dunia keperawatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-27-2



9

786347

294272